ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 02 · IF

Manual de

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

& Microbiología

Módulo 1 · Medicina Interna · 25 clases

Índice general

01 Urgencias Críticas, Sepsis e Infecciones del SNC 3

1.1. Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora) 5
1.2. Meningitis Aguda Bacteriana y Viral 8
1.3. Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral 12
1.4. Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig 15

02 Salud Pública, Profilaxis Post-Exposición e IAAS 20

2.1. Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes 22
2.2. Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico 25
2.3. IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento 28
2.4. Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera 30

03 Infecciones Crónicas, Retrovirales y Granulomatosas 34

3.1. Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES) 36
3.2. Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA 39
3.3. Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR 43
3.4. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas 47
3.5. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH 51

04 Zoonosis, Medicina Tropical y Vectores 55

4.1. Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH) 57
4.2. Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica 61
4.3. Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla 64
4.4. Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis 68
4.5. Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea 71
4.6. Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio) 74

05 Infecciones Comunitarias, Exantemas y Huésped Inmunocomprometido 78

5.1. Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis 80
5.2. Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH 84
5.3. Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki 88
5.4. Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster 93
5.5. Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco 97
5.6. Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño) 100

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 104

MANUAL EUNACOM DE INFECTOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

4	11	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
1.1	Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)	5
1.2	Meningitis Aguda Bacteriana y Viral	8
1.3	Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	12
1.4	Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	15

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.2.007, 4.01.2.029, 2.01.2.023, 1.04.4.009, 1.07.3.001	Sepsis y Shock Séptico	Específico	Inicial	Derivar
1.04.2.006, 1.04.4.006, 1.04.5.002, 2.01.2.015, 2.01.2.016, 1.04.5.003, 1.08.5.006, 1.10.2.016	Meningitis Aguda Bacteriana y Viral	Específico	Inicial	Derivar
1.04.2.002, 1.10.2.014, 1.04.2.001, 2.01.1.015	Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	Específico	Inicial	Derivar
1.04.2.005, 1.04.2.004, 1.04.1.001, 6.01.2.005	Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
11 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El concepto de SIRS fue eliminado: Sepsis = sospecha de infección + disfunción orgánica aguda (SOFA ≥ 2).
- qSOFA (≥ 2 de 3): FR ≥ 22 rpm, Glasgow < 15, Presión Sistólica ≤ 100 mmHg. Herramienta de alarma rápida.
- Shock Séptico = necesidad de vasopresores para PAM ≥ 65 mmHg a pesar de 30 mL/kg de fluidos Y Lactato > 2 mmol/L.
- Vasopresor de 1ª línea indiscutido: Noradrenalina EV. La dopamina está en desuso por arritmias y mayor mortalidad.
- Paquete 1ª hora: Lactato + Hemocultivos x 2 + ATB amplio espectro EV + Cristaloides 30 mL/kg + Noradrenalina precoz.
- **! TRAMPA** · Tríada meníngea: fiebre + rigidez de nuca + alteración mental. La ausencia de los 3 descarta prácticamente el cuadro.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Sepsis y Shock Séptico	EUNACOM Julio 2024 · #148
Meningitis Aguda Bacteriana y Viral	EUNACOM Julio 2025 · #137 · EUNACOM Julio 2025 · #80 · EUNACOM Julio 2017 · #81 · EUNACOM Diciembre 2017 · #61
Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	EUNACOM Diciembre 2024 · #42 · EUNACOM Julio 2019 · #100 · EUNACOM Diciembre 2019 · #157 · EUNACOM Julio 2019 · #65
Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	EUNACOM Agosto 2021 · #172 · EUNACOM Diciembre 2019 · #135

1.1. Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.2.007 | 4.01.2.029 | 2.01.2.023 | 1.04.4.009 | 1.07.3.001

¿POR QUÉ?

La sepsis y el shock séptico son emergencias médicas de máxima evaluación en el EUNACOM. La clave radica en aplicar el Consenso Sepsis-3 (abandono del SIRS, centralidad del SOFA/qSOFA) y ejecutar con rapidez estricta el Paquete de la Primera Hora antes de que se instale la disfunción multiorgánica irreversible.

1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (SEPSIS-3)

1.04.2.007 | 4.01.2.029

La sepsis se define según el consenso **Sepsis-3** como la **disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección**. El concepto de SIRS fue abandonado por inespecífico.

La confirmación requiere sospecha de infección + aumento agudo de **≥ 2 puntos en el Score SOFA** basal. En la cabecera del paciente y urgencias se utiliza el **qSOFA (quick SOFA)**: FR ≥ 22 rpm, Glasgow < 15 y Presión Sistólica ≤ 100 mmHg. Dos o más puntos identifican alto riesgo de muerte.

2. DEFINICIÓN ESTRICTA DE SHOCK SÉPTICO

1.04.2.007 | 2.01.2.023

El shock séptico es un subgrupo de sepsis con colapso circulatorio y celular profundo. Se diagnostica cuando, tras una adecuada resucitación con volumen, persisten simultáneamente:

1. Necesidad de **vasopresores para mantener PAM ≥ 65 mmHg**, Y
2. **Lactato sérico > 2 mmol/L (> 18 mg/dL)** a pesar de la carga de volumen.

3. PAQUETE DE LA 1ª HORA (SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN)

1.04.2.007

Cada hora de demora en los antibióticos aumenta la mortalidad en 8 %. En los primeros 60 minutos:

1.04.2.007 | 1.04.4.009

- **Medir Lactato sérico** (remeir a las 2–4 h si está elevado; meta: descenso > 20 % en 2 h).
- **Tomar 2 frascos de hemocultivos** antes de iniciar antimicrobianos (sin demorar > 45 min).
- **Antibióticos EV de amplio espectro** en dosis plenas según foco probable.
- **Cristaloides a 30 mL/kg** (Ringer Lactato o Solución Fisiológica) en bolo rápido si hay hipotensión o lactato ≥ 4.

4. ESCALAMIENTO VASOACTIVO Y MANEJO AVANZADO

1.04.2.007 | 2.01.2.023

Vasopresor de 1ª línea: Noradrenalina EV. La dopamina está proscrita por mayor arritmogenia y mortalidad. Se puede iniciar por vía periférica mientras se instala el CVC.

Si la hipotensión persiste con dosis crecientes de noradrenalina (> 0.25 mcg/kg/min), se asocia **Vasopresina (0.03 U/min)** e **Hidrocortisona EV (200 mg/día)**. Si coexiste disfunción miocárdica ($ScvO_2$ < 70 % con PAM adecuada), agregar **Dobutamina**.

5. TERMORREGULACIÓN: FIEBRE, HIPERTERMIA, HIPOTERMIA Y HEMOCULTIVO

1.07.3.001

Fiebre: elevación regulada del punto de ajuste hipotalámico por pirógenos (IL-1, IL-6, TNF-α, vía PGE_2); se define como temperatura central **≥ 38,0 °C** (axilar ≥ 37,8 °C). La **hipertermia** es distinta: el punto de ajuste no cambia y el calor se acumula por producción o pérdida deficiente (golpe de calor, síndrome serotoninérgico o neuroléptico maligno, hipertermia maligna, hipertiroidismo, cocaína); **no responde a antipiréticos** y exige enfriamiento activo y tratar la causa. La **hipotermia** (< 35 °C central) en un paciente séptico, en el recién nacido y en el anciano es un **signo de gravedad** con peor pronóstico que la fiebre; el adulto mayor puede no hacer fiebre (aumento de ≥ 1,1 °C sobre su basal o dos tomas ≥ 37,2 °C ya sugieren infección). Manejo: buscar y tratar el foco, hidratar, paracetamol 500–1.000 mg cada 6–8 h (evitar AAS en niños por síndrome de Reye); la hipotermia se corrige con recalentamiento pasivo o activo y fluidos tibios.

1.04.4.009

Interpretación del hemocultivo (nivel «interpreta y emplea»): el estándar son **2 a 3 sets** (aerobio + anaerobio) de sitios de punción distintos, antes del antibiótico y con 8–10 mL por frasco. Un cultivo positivo es **verdadero** cuando crece *S. aureus*, *E. coli* u otros bacilos gramnegativos, *S. pneumoniae*, *Streptococcus* β-hemolítico, *Enterococcus* o *Candida* (incluso en un solo frasco; **un *S. aureus* en sangre nunca es contaminante**: repetir hemocultivos, buscar endocarditis o foco metastásico y tratar EV por semanas). Es **probable contaminante** el estafilococo coagulasa negativo, *Corynebacterium*, *Bacillus* y *Cutibacterium* cuando crecen en **1 de 2 sets** y sin catéter ni prótesis. Un hemocultivo negativo **no descarta** bacteriemia (antibiótico previo, gérmenes exigentes); la positividad persistente a las 48–72 h bajo tratamiento obliga a buscar endocarditis, catéter infectado o foco no drenado.

FIGURA 1.1 · RESUCITACIÓN HEMODINÁMICA Y ESCALAMIENTO VASOACTIVO EN SHOCK SÉPTICO

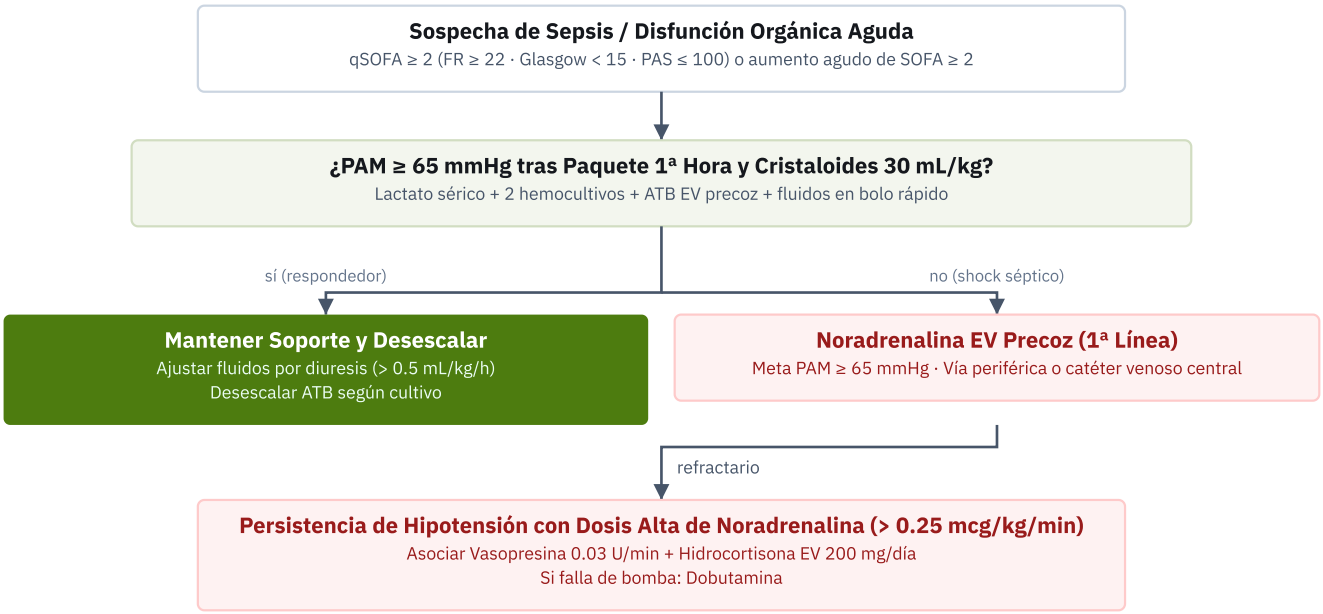


TABLA 1.1 · SEPSIS VS SHOCK SÉPTICO VS HIPOVOLEMIA — DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

1.04.2.007, 4.01.2.029, 2.01.2.023, 1.04.4.009, 1.07.3.001

PARÁMETRO	SEPSIS (SEPSIS-3)	SHOCK SÉPTICO	HIPOTENSIÓN HIPOVOLÉMICA
Criterio clínico	Infección + aumento SOFA ≥ 2	PAM < 65 post-fluidos + Lactato > 2	Déficit intravascular puro
Respuesta a 30 mL/kg	Estabiliza PA transitoriamente	Refractario; persiste hipotensión	Restaura PA y perfusión 100%
Vasopresor de elección	No indicado (solo fluidos)	Noradrenalina (meta PAM ≥ 65)	Contraindicado (requiere volumen)
Lactato Sérico	Normal o leve elevación	> 2 mmol/L post-fluidos	Normal o normaliza con volumen
Mortalidad	10% a 15%	> 40%	< 5% con reposición

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Hombre de 68 años con ITU complicada febril (39 °C), soporoso, PA 82/48 (PAM 59 mmHg), FC 122 lpm, FR 26 rpm. Se administran 2.500 mL de Ringer lactato (30 mL/kg) en 2 horas. Tras la carga, la PA es de 84/50 mmHg (PAM 61 mmHg) y lactato 4.2 mmol/L.

Conducta oficial. Shock séptico urinario refractario a fluidos: cumple criterios Sepsis-3 con persistencia de PAM < 65 mmHg y lactato > 2 mmol/L tras 30 mL/kg de cristaloides. La conducta inmediata es el inicio impostergable de Noradrenalina EV (meta PAM ≥ 65 mmHg), toma de hemocultivos y antibióticos EV de amplio espectro.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El concepto de SIRS fue eliminado: Sepsis = sospecha de infección + disfunción orgánica aguda (SOFA ≥ 2).
- qSOFA (≥ 2 de 3): FR ≥ 22 rpm, Glasgow < 15, Presión Sistólica ≤ 100 mmHg. Herramienta de alarma rápida.
- Shock Séptico = necesidad de vasopresores para PAM ≥ 65 mmHg a pesar de 30 mL/kg de fluidos Y Lactato > 2 mmol/L.
- Vasopresor de 1ª línea indiscutido: Noradrenalina EV. La dopamina está en desuso por arritmias y mayor mortalidad.
- Paquete 1ª hora: Lactato + Hemocultivos x 2 + ATB amplio espectro EV + Cristaloides 30 mL/kg + Noradrenalina precoz.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Sepsis y Shock Séptico

1. Un paciente de 62 años con neumonía adquirida en la comunidad grave evoluciona con taquipnea (FR 28 rpm), compromiso de conciencia y PA 80/50 mmHg. A pesar de la administración de 2.000 mL de solución salina al 0.9% en 90 minutos, la PAM persiste en 58 mmHg y el lactato sérico se reporta en 3.6 mmol/L. ¿Cuál es la conducta farmacológica inmediata más indicada?

A) Iniciar infusión continua de dopamina a dosis beta
B) Iniciar infusión de noradrenalina con meta de PAM ≥ 65 mmHg
C) Administrar un bolo de 100 mg de hidrocortisona EV antes de vasopresores
D) Continuar la carga de cristaloides con 2.000 mL adicionales en 1 hora
E) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio 2/3 molar

Banco de Preguntas Oficial · Sepsis y Shock Séptico

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos forma parte del score qSOFA (quick SOFA) para la identificación rápida de sepsis en el servicio de urgencia?

A) Temperatura axilar > 38.3 °C o < 36.0 °C
B) Leucocitosis > 12.000/mm³ o baciliformes > 10%
C) Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto
D) Frecuencia cardíaca > 90 latidos por minuto
E) Diuresis horaria < 0.5 mL/kg/h

Más preguntas online de Sepsis y Shock Séptico →

1.2. Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.2.006 | 1.04.4.006 | 1.04.5.002 | 2.01.2.015 | 2.01.2.016 | 1.04.5.003 | 1.08.5.006 | 1.10.2.016

¿POR QUÉ?

La meningitis aguda es una emergencia infectológica crítica. En el EUNACOM se evalúan dos principios inviolables: saber cuándo se debe solicitar TAC previo a la punción lumbar (sin postergar jamás los antibióticos) y dominar el perfil citoquímico del LCR para distinguir etiología bacteriana de viral.

1. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y FISIOPATOLOGÍA

1.04.2.006 | 2.01.2.015 | 1.10.2.016

La infección subaracnoidea comunitaria se produce principalmente por *Streptococcus pneumoniae* y *Neisseria meningitidis*. La tríada clásica incluye **fiebre, cefalea y rigidez de nuca** (presente en < 50 % de casos; pero la ausencia de los 3 descarta prácticamente el cuadro). **(ver Imagen 1.2B y C)**

1.04.2.006

La respuesta inflamatoria masiva produce edema vasogénico, citotóxico e intersticial, con rápida elevación de la presión intracraneana y riesgo de isquemia cerebral.

2. BANDERAS ROJAS: CUÁNDO TAC PREVIO A PUNCIÓN LUMBAR

1.04.2.006 | 1.04.5.002 | 1.08.5.006

La **Punción Lumbar (PL)** es el estudio de elección, pero en presencia de efecto de masa puede provocar **herniación cerebral fatal**. Requieren TAC previo:

- **Déficit neurológico focal** (paresia, asimetría facial, afasia).
- **Crisis convulsiva de reciente inicio** (< 1 semana).
- **Compromiso de conciencia profundo** (Glasgow < 10).
- **Papiledema** en el fondo de ojo o **inmunodepresión severa** (VIH con CD4 bajo).

Regla de oro: Si tiene indicación de TAC, **NUNCA esperar la imagen para tratar**: tomar hemocultivos, administrar Dexametasona + ATB empíricos EV de inmediato y luego trasladar a TAC.

3. TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO Y CORTICOIDES

1.04.2.006 | 2.01.2.015

Dexametasona EV (10 mg cada 6 h por 4 días): administrar 15–20 minutos ANTES o junto con la primera dosis de antibiótico. Reduce secuelas auditivas y mortalidad en meningitis por neumococo.

1.04.2.006 | 2.01.2.015 | 1.10.2.016

Esquema estándar (3 meses a 50 años): Ceftriaxona 2 g cada 12 h EV + Vancomicina 15–20 mg/kg cada 12 h EV.

1.04.2.006 | 2.01.2.015

Mayores de 50 años, embarazadas e inmunodeprimidos: AGREGAR Ampicilina 2 g cada 4 h EV para cubrir *Listeria monocytogenes* (intrínsecamente resistente a cefalosporinas).

4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

1.04.2.006 | 1.04.4.006 | 2.01.2.015 | 1.10.2.016

El análisis de LCR orienta la etiología: bacteriana aguda presenta **pleocitosis con predominio PMN (> 80 %)**, **hipoglucorraquia marcada (ratio LCR/suero < 0.4)** e hiperproteinorraquia severa (> 100–500 mg/dL). La etiología viral presenta predominio mononuclear con **glucosa normal**.

5. MENINGOCOCCEMIA, PUNCIÓN LUMBAR Y CULTIVOS

2.01.2.016

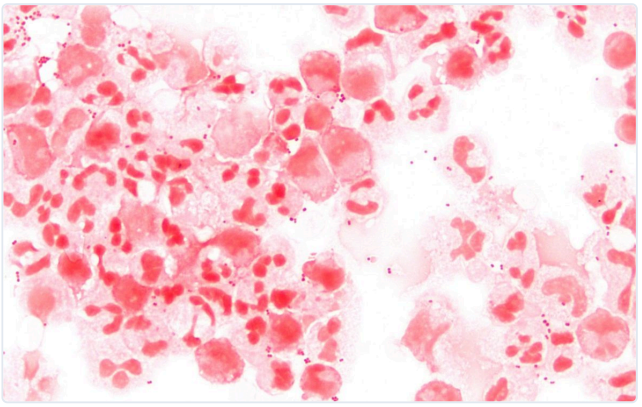
Meningococcemia (urgencia): sepsis por *Neisseria meningitidis* con o sin meningitis. Fiebre alta de inicio brusco, mialgias y **petequias que progresan en horas a equimosis y púrpura** (púrpura fulminante), con hipotensión, acidosis y CID. El **síndrome de Waterhouse-Friderichsen** es la hemorragia suprarrenal bilateral con insuficiencia suprarrenal aguda y shock refractario. Ante la **sospecha** no se espera la punción lumbar: hemocultivos, **ceftriaxona 2 g EV inmediata**, volumen, corticoide si hay shock refractario y **derivación urgente a UCI**. Aislamiento respiratorio por gotitas hasta 24 h de tratamiento, notificación inmediata (ENO) y **quimioprofilaxis de contactos íntimos** (rifampicina 600 mg cada 12 h por 2 días, o ceftriaxona 250 mg IM dosis única, o ciprofloxacino 500 mg dosis única; véase Tema 2.1). **(ver Imagen 1.2A)**

1.04.5.002 | 1.08.5.006

Punción lumbar (nivel «realizar»): con consentimiento, descartar antes **efecto de masa** (banderas rojas del punto 2), infección cutánea en el sitio y coagulopatía (plaquetas < 50.000/mm³ o INR > 1,5). Paciente en decúbito lateral en posición fetal o sentado inclinado hacia adelante; el espacio **L3–L4** (o L4–L5) se ubica con la línea que une ambas crestas ilíacas (línea de Tuffier). Asepsia y campo estéril, anestesia local, aguja 20–22 G con el bisel paralelo a las fibras de la duramadre, avance hasta sentir el «pop» y salida de LCR; se mide la **presión de apertura** (normal 10–20 cmH_2O) y se recogen **4 tubos** (bioquímica, Gram y cultivo, recuento celular, adicional) junto con una glicemia simultánea. Complicaciones: **cefalea postpunción** (reposo, hidratación, cafeína; parche hemático si persiste), dolor radicular, hematoma espinal y herniación si se omitió la TAC.

1.04.5.003

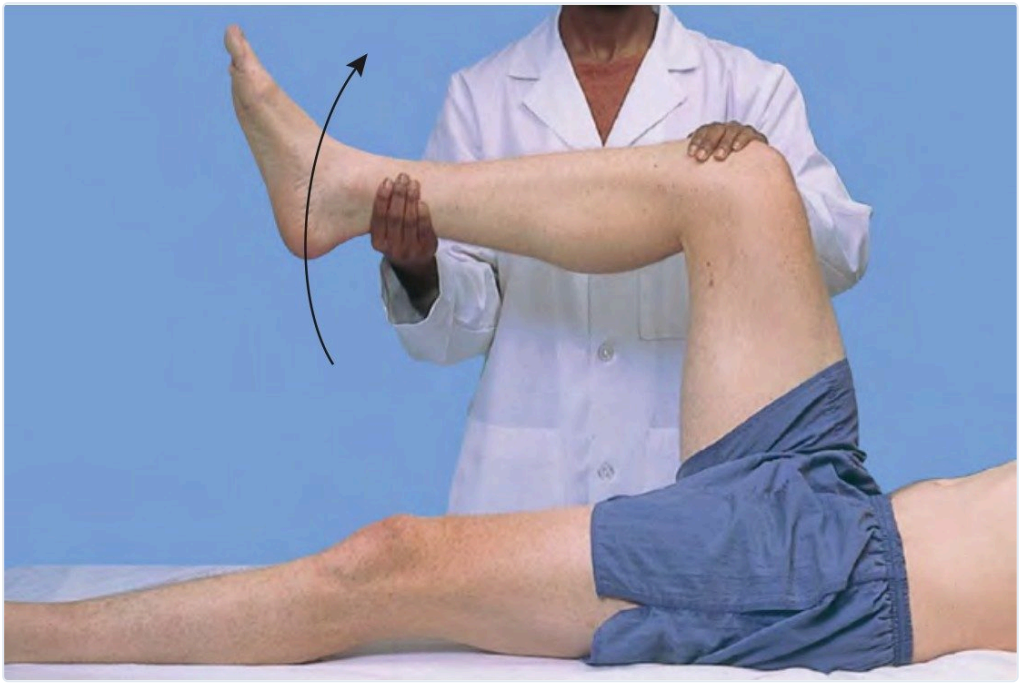
Sembrar muestras para cultivo (nivel «realizar»): obtener la muestra **antes del antibiótico**, con técnica aséptica y en un envase estéril rotulado. El LCR se procesa de inmediato a **temperatura ambiente** (no refrigerar: *N. meningitidis* y *H. influenzae* son lábiles al frío) y se siembra en **agar sangre y agar chocolate** con incubación a 35–37 °C en 5 % de CO_2; los hemocultivos se inoculan en frascos aerobio y anaerobio tras desinfectar el tapón. La siembra en placa se hace con asa estéril y **estrías por agotamiento** para obtener colonias aisladas; el Gram directo del LCR (diplococos grampositivos lanceolados = neumococo; diplococos gramnegativos = meningococo) orienta el antibiótico en minutos, y el cultivo con antibiograma lo confirma a las 24–48 h.



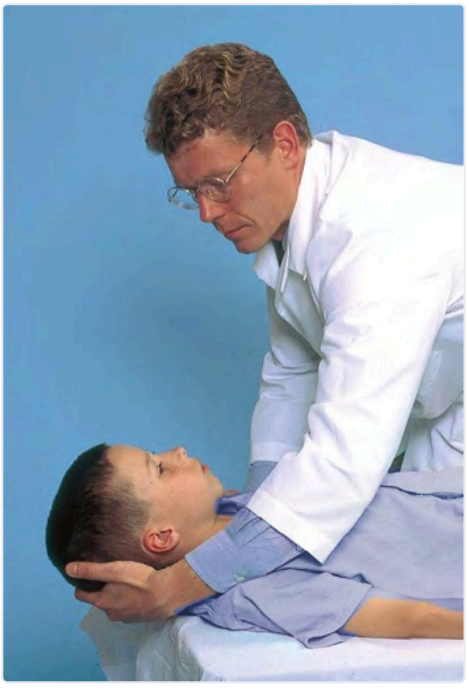
Tinción de Gram del LCR con diplococos



A. PÚRPURA MENINGOCÓCICA



B. KERNIG



C. RIGIDEZ DE NUCA

Imagen 1.2

FIGURA 1.2 · ENFRENTAMIENTO DE MENINGITIS AGUDA Y DECISIÓN DE TAC CEREBRAL

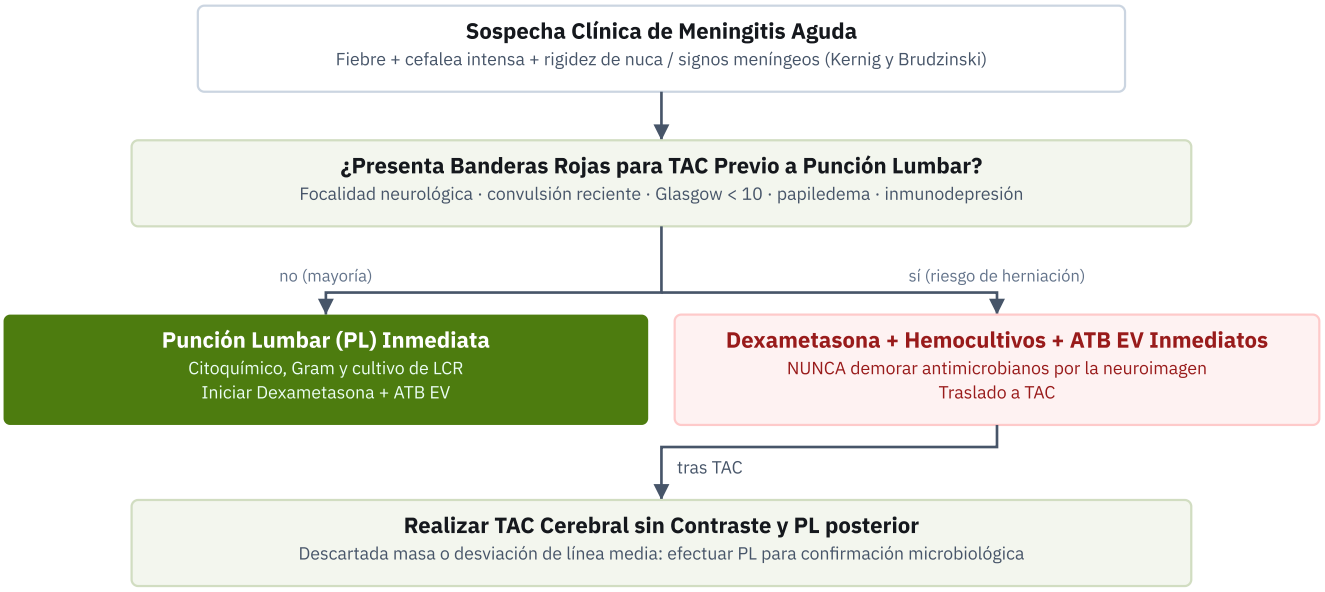


TABLA 1.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL CITOQUÍMICO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

1.04.2.006, 1.04.4.006, 1.04.5.002, 2.01.2.015, 2.01.2.016, 1.04.5.003, 1.08.5.006, 1.10.2.016

PARÁMETRO	NORMAL	BACTERIANA AGUDA	VIRAL (ASÉPTICA)	TUBERCULOSA / FÚNGICA
Presión apertura	10–20 cm H2O	Elevada (> 25 cm H2O)	Normal o leve aumento	Marcadamente elevada (> 30)
Leucocitos /mm³	< 5	Muy alto (1.000–10.000+)	Moderado (50–500)	Moderado (100–500)
Predominio celular	Mononucleares	Polimorfonucleares (> 80%)	Mononucleares / Linfocitos	Mononucleares / Linfocitos
Glucosa (LCR/Suero)	> 0.6 (> 60%)	Baja (< 0.4 / < 40 mg/dL)	Normal (> 0.6)	Muy baja (< 0.3)
Proteínas	< 45 mg/dL	Muy elevadas (> 100–500)	Leve aumento (50–100)	Muy elevadas (100–500+)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.2

Mujer de 54 años consulta por 24 horas de cefalea holocraneana, fiebre de 39.2 °C, fotofobia y vómitos. Al examen: orientada parcialmente (Glasgow 14), sin focalidad neurológica, fondo de ojo normal, rigidez de nuca y Brudzinski positivos. PL inmediata: LCR turbio, presión 32 cm H2O, 4.200 leucocitos/mm³ con 92% PMN, glucosa LCR 18 mg/dL (glicemia sérica 110 mg/dL), proteínas 280 mg/dL.

Conducta oficial. Meningitis bacteriana aguda típica por citoquímico (pleocitosis PMN > 80%, consumo severo de glucosa ratio < 0.4 e hiperproteinorraquia). Al ser mayor de 50 años, la cobertura empírica obligatoria debe incluir Ceftriaxona + Vancomicina + AMPICILINA EV (para cubrir Listeria monocytogenes) junto con Dexametasona EV precoz.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Tríada meníngea: fiebre + rigidez de nuca + alteración mental. La ausencia de los 3 descarta prácticamente el cuadro.
- Citoquímico bacteriano: PMN > 80 %, proteínas > 100 mg/dL y consumo severo de glucosa (ratio LCR/suero < 0.4).
- Citoquímico viral: predominio mononuclear/linfocítico con GLUCOSA NORMAL y proteínas levemente aumentadas.
- Banderas rojas para TAC previo a PL: focalidad neurológica, convulsión nueva, Glasgow < 10, papiledema e inmunodepresión.
- Si requiere TAC: administrar Dexametasona + ATB EV de inmediato antes del traslado, NUNCA demorarlos.
- En > 50 años, alcohólicos y embarazadas: agregar siempre AMPICILINA para cubrir Listeria monocytogenes.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

1. Hombre de 58 años es traído a urgencias con fiebre de 39 °C, rigidez de nuca y sopor. Al examen se constata hemiparesia braquiocrural derecha leve y signo de Babinski ipsilateral. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada a seguir?

A) Realizar punción lumbar de urgencia de inmediato y esperar el Gram para iniciar fármacos
B) Tomar hemocultivos, administrar dexametasona y antibióticos EV de inmediato, y luego solicitar TAC cerebral
C) Trasladar a TAC cerebral de inmediato sin administrar fármacos para no interferir con los cultivos
D) Iniciar infusión de manitol al 15% y diferir todo estudio invasivo por 24 horas
E) Administrar ceftriaxona en dosis única intramuscular y enviar a domicilio con control en 12 horas

Banco de Preguntas Oficial · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

2. Se recibe el informe del citoquímico de LCR de un joven de 21 años previamente sano con fiebre y rigidez de nuca: aspecto transparente, leucocitos 180/mm³ con 88% de mononucleares, glucosa en LCR 62 mg/dL (glicemia sérica simultánea 98 mg/dL) y proteínas 68 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae
B) Meningitis bacteriana por Listeria monocytogenes
C) Meningitis viral (aséptica)
D) Meningitis tuberculosa en fase avanzada
E) Meningitis fúngica por Cryptococcus neoformans

Más preguntas online de Meningitis Aguda Bacteriana y Viral →

1.3. Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 `1.04.2.002` `1.10.2.014` `1.04.2.001` `2.01.1.015`

¿POR QUÉ?

La encefalitis aguda y el absceso cerebral son infecciones parenquimatosas del SNC con elevada morbimortalidad y secuelas neurocognitivas graves. En el EUNACOM se evalúa la distinción entre meningitis (afectación meníngea pura) y encefalitis (compromiso parenquimatoso con afasia, conducta bizarra y crisis focales), donde el Aciclovir empírico salva vidas.

1. ENCEFALITIS HERPÉTICA (VHS-1): PATOGENIA Y CUADRO CLÍNICO

`1.04.2.002` `1.10.2.014`

El **Virus Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1)** es la causa más frecuente de encefalitis viral esporádica no epidémica en inmunocompetentes (> 90% de los casos). El virus accede al sistema nervioso central por transporte axonal retrógrado a través del nervio olfatorio o trigémino hacia las zonas basales del cerebro. **(ver Imagen 1.3A)**

Presenta un tropismo selectivo por las **estructuras límbicas y los lóbulos temporales anteriores e inferiores**, causando necrosis hemorrágica localizada, edema severo y gliosis reactiva.

Clínica cardinal: a diferencia de la meningitis pura, la encefalitis se define por **alteración de la función cerebral superior**: cambios conductuales bizarros, alteraciones de memoria reciente, afasia de comprensión (compromiso del lóbulo temporal izquierdo dominante), alucinaciones olfatorias/gustativas y crisis convulsivas focales con o sin generalización secundaria.

2. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EMPÍRICO CON ACICLOVIR

`1.04.2.002` `1.10.2.014`

Resonancia Magnética (RMN) cerebral: es el examen de imagen de elección (muy superior a la TAC), demostrando hiperintensidad en secuencias T2 y FLAIR en los **lóbulos temporales de forma asimétrica** y corteza insular.

Punción Lumbar y PCR: el LCR típicamente muestra pleocitosis linfocítica con **eritrocitos o xantocromía** (por la necrosis hemorrágica temporal). El diagnóstico de certeza se establece mediante **PCR para VHS-1 en LCR** (sensibilidad y especificidad > 95%).

Conducta médica de primera línea: ante toda sospecha clínica de encefalitis, se debe iniciar de inmediato **Aciclovir EV (10 mg/kg cada 8 horas por 14 a 21 días)** sin esperar el resultado de la PCR. Cada hora de retraso empeora drásticamente el pronóstico neurológico definitivo.

3. ABSCESO CEREBRAL: FOCOS PRIMARIOS Y TRIADA CLÍNICA

`1.04.2.001`

El absceso cerebral es una infección focal supurada intraparenquimatosa. Se produce principalmente por tres mecanismos: (1) **Contigüidad (50%):** sinusitis frontal/etmoidal (absceso frontal), otitis media crónica o mastoiditis (absceso temporal o cerebeloso); (2) **Diseminación hematógena (30%):** cardiopatías congénitas cianóticas con cortocircuito derecha-izquierda, endocarditis bacteriana, bronquiectasias o fístulas arteriovenosas pulmonares; (3) **Inoculación directa:** traumatismo craneoencefálico penetrante o neurocirugía. **(ver Imagen 1.3B)**

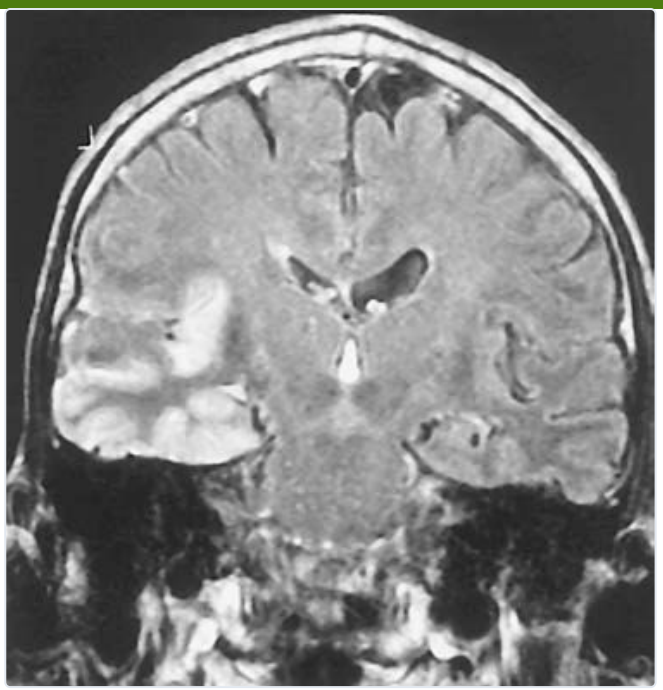
Tríada clásica: cefalea persistente refractaria + fiebre (ausente en 50%) + déficit focal neurológico. La sospecha exige **TAC o RMN con contraste** que revela la clásica **lesión en anillo con realce periférico** y edema vasogénico perilesional.

Tratamiento: Ceftriaxona 2g c/12h EV + Metronidazol 500mg c/8h EV (para anaerobios de foco ótico/sinusal) + Vancomicina si hay antecedente quirúrgico o trauma. Descompresión quirúrgica (aspiración estereotáxica o escisión) si mide > 2.5 cm.

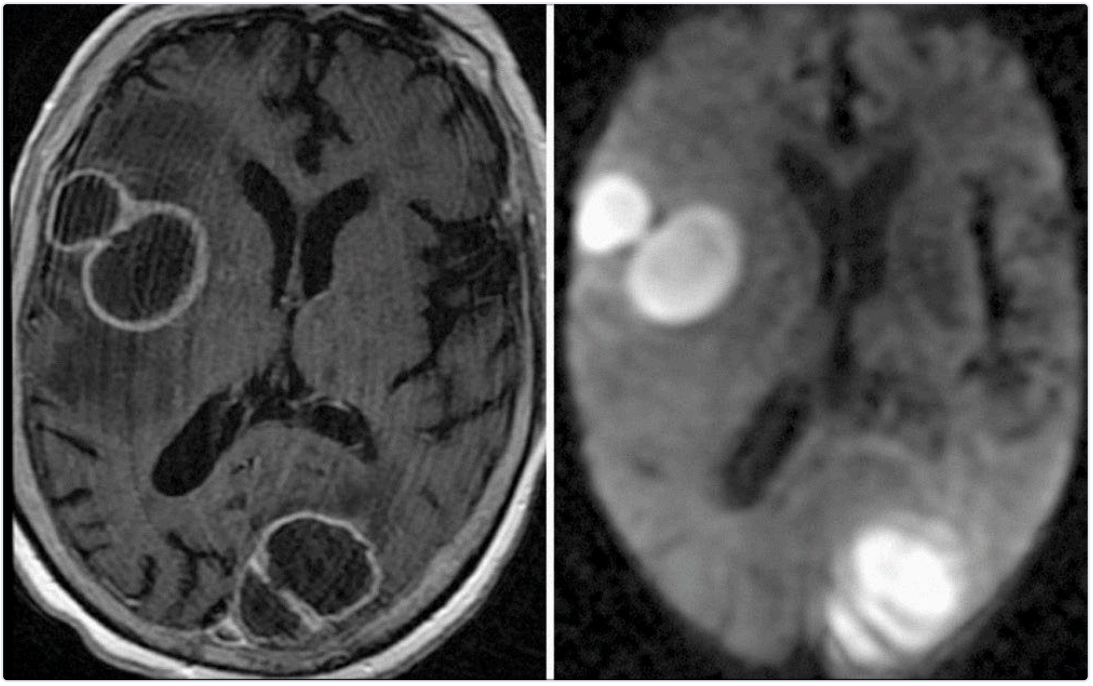
4. MENINGOENCEFALITIS BACTERIANA AGUDA EN EL NIÑO

`2.01.1.015`

En el niño la etiología cambia con la edad: **recién nacido y menor de 3 meses**, *Streptococcus agalactiae* (SGB), *E. coli* y *Listeria*; **mayor de 3 meses**, *S. pneumoniae* y *N. meningitidis* (el *H. influenzae* b es raro tras la vacunación). En el lactante la presentación es inespecífica: fiebre o hipotermia, irritabilidad o letargia, rechazo alimentario, vómitos, convulsiones y **fontanela abombada**; la rigidez de nuca y los signos meníngeos aparecen tarde o faltan. La sospecha obliga a estabilizar (vía aérea, volumen), tomar hemocultivos y realizar **punción lumbar** si no hay contraindicación. Antibiótico EV inmediato: menor de 1 mes **ampicilina + cefotaxima** (o gentamicina); mayor de 1 mes **ceftriaxona 100 mg/kg/día + vancomicina**; en mayores de 1 mes se agrega **dexametasona 0,15 mg/kg cada 6 h por 2–4 días** antes o junto con la primera dosis. Se deriva a centro con UCI pediátrica. Todo niño debe tener **audiometría** al alta (la sordera es la secuela más frecuente) y control del neurodesarrollo; la prevención son las vacunas anti-*Haemophilus* b, neumococo y meningococo.



A. ENCEFALITIS HERPÉTICA



B. ABSCESO CEREBRAL

Imagen 1.3

TABLA 1.3 · MENINGITIS VS ENCEFALITIS VS ABSCESO CEREBRAL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 1.04.2.002, 1.10.2.014, 1.04.2.001, 2.01.1.015

CARACTERÍSTICA	MENINGITIS AGUDA	ENCEFALITIS HERPÉTICA	ABSCESO CEREBRAL
Compromiso cerebral	Ausente (conciencia clara o somnolencia)	Marcado (afasia, conducta bizarra, crisis)	Focalidad motora o sensitiva progresiva
Signos meníngeos	Marcados (rigidez, Kernig, Brudzinski)	Ausentes o leves	Raros (salvo rotura intraventricular)
Hallazgo en Imagen	Habitualmente normal (realce meníngeo)	Hiperintensidad temporal en RMN (FLAIR)	Lesión con captación en anillo y edema
LCR patognomónico	Bacteriana: PMN + glucosa baja	Linfocitos + hematíes / PCR VHS (+)	PL contraindicada por riesgo de herniación
Tratamiento de elección	Ceftriaxona + Vancomicina (± Ampicilina)	Aciclovir 10 mg/kg c/8h EV por 14-21 d	Ceftriaxona + Metronidazol + Cirugía

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.3

Hombre de 42 años sin antecedentes mórbidos es llevado a urgencias por sus familiares debido a cuadro de 3 días de fiebre leve, cefalea y conducta crecientemente inapropiada y desinhibida. La esposa relata que no comprende lo que se le dice y emite palabras incoherentes. Durante la evaluación médica presenta una crisis convulsiva tónico-clónica focalizada en brazo y hemicara derecha. Examen físico: T° 38.4 °C, sin rigidez de nuca franca, afasia sensitiva (de Wernicke) evidente.

Conducta oficial. El cuadro de fiebre, cambios conductuales agudos, afasia sensitiva y crisis convulsivas focales de origen temporal es la presentación clásica de Encefalitis por Virus Herpes Simplex (VHS-1). La sospecha clínica obliga a hospitalizar en UTI e iniciar de inmediato Aciclovir por vía endovenosa (10 mg/kg cada 8 horas). No se debe esperar la confirmación por PCR en LCR ni el informe de la RMN para iniciar el antiviral, pues la letalidad sin tratamiento supera el 70% y la ventana terapéutica es muy estrecha.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Encefalitis = fiebre + alteración de funciones cerebrales superiores (afasia, delirio, conducta bizarra, crisis focales).
- Causa más frecuente y letal: Virus Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1), con tropismo temporal y frontal basal.
- Examen de imagen más sensible: Resonancia Magnética (hiperintensidad temporal asimétrica en secuencias FLAIR).
- Test de confirmación: PCR para VHS en líquido cefalorraquídeo.
- Tratamiento de elección inmediato: Aciclovir 10 mg/kg cada 8 horas EV por 14 a 21 días.
- En absceso cerebral de origen ótico o sinusal: la combinación empírica es Ceftriaxona + Metronidazol (para anaerobios).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

1. Una mujer de 35 años consulta por fiebre de 38.5 °C, cefalea y desorientación de 48 horas. Durante la anamnesis presenta alucinaciones olfatorias y afasia de comprensión. La TAC cerebral inicial sin contraste no muestra lesiones evidentes. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Iniciar Aciclovir endovenoso de inmediato
B) Indicar tratamiento con Ceftriaxona y Vancomicina EV y observar
C) Esperar el resultado de la PCR viral en LCR antes de indicar antivirales
D) Iniciar Dexametasona oral y enviar a domicilio con reposo
E) Solicitar electroencefalograma ambulatorio para descartar pseudocrisis

Banco de Preguntas Oficial · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

2. ¿Cuál de los siguientes esquemas antibióticos empíricos es el de elección para el tratamiento de un absceso cerebral secundario a una otitis media crónica no complicada con neurocirugía previa?

A) Ceftriaxona + Metronidazol EV
B) Ciprofloxacino + Clindamicina oral
C) Vancomicina + Gentamicina EV
D) Ampicilina en monoterapia EV
E) Cefazolina + Dexametasona EV

Más preguntas online de Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral →

1.4. Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.2.005 | 1.04.2.004 | 1.04.1.001 | 6.01.2.005

¿POR QUÉ?

Las infecciones necrotizantes de partes blandas y la angina de Ludwig son emergencias quirúrgicas con altísima letalidad. El EUNACOM evalúa dos conceptos cardinales: el reconocimiento precoz del dolor desproporcionado a la inspección y la indicación indiscutible de exploración quirúrgica inmediata sin perder tiempo en imágenes.

1. FASCITIS NECROTIZANTE: TIPOS MICROBIOLÓGICOS

1.04.2.005 | 6.01.2.005

La fascitis necrotizante es una infección rápidamente destructiva que afecta la fascia profunda y el tejido subcutáneo con trombosis microvascular secundaria. **(ver Imagen 1.4A)**

Se clasifica en: **Tipo I (Polimicrobiana - 80%)**, mezcla de anaerobios (*Bacteroides*) con enterobacterias y estreptococos en diabéticos o tras cirugía perineal (**Gangrena de Fournier**); y **Tipo II (Monomicrobiana - 20%)**, por *Streptococcus pyogenes* en pacientes jóvenes tras traumatismos menores o varicela.



Gangrena de Fournier

2. SIGNOS CLÍNICOS CARDINALES Y DIAGNÓSTICO

1.04.2.005 | 6.01.2.005

El signo más precoz es el **dolor desproporcionado a los hallazgos físicos iniciales**: la piel parece solo eritematosa pero el dolor es intolerable y sobrepasa los márgenes visibles.

Signos duros de necrosis: flictenas con contenido serohemático, **crepitación** a la palpación (gas tisular por anaerobios), **anestesia cutánea focal** (por necrosis de nervios dérmicos) y shock séptico fulminante con acidosis y lactato elevado.

3. ANGINA DE LUDWIG Y PILARES TERAPÉUTICOS

1.04.2.004

La **Angina de Ludwig** es una celulitis gangrenosa bilateral de los espacios submandibular y sublingual, originada en el 80% de los casos por infección de **2° o 3° molares inferiores**. Cursa con trismus, lengua protruida y estridor: el riesgo inminente es la asfixia. **(ver Imagen 1.4B)**

1.04.2.005 | 1.04.2.004 | 6.01.2.005

Manejo de urgencia: 1) Asegurar vía aérea en Ludwig (intubación con fibra óptica o traqueostomía); 2) **Aseo quirúrgico y fasciotomía urgente** (no diferir por TAC ni RMN); 3) Terapia EV: **Meropenem + Vancomicina + Clindamicina** (la clindamicina bloquea la producción de toxinas estreptocócicas).

4. ADENITIS, ADENOFLEGMÓN Y OTROS FLEGMONES CERVICALES

1.04.1.001

Adenitis aguda: ganglio cervical unilateral aumentado de tamaño, caliente, doloroso y eritematoso, habitualmente por *S. aureus* o *S. pyogenes* a partir de una faringoamigdalitis, caries o lesión cutánea. El **adenoflegmón** es la evolución a colección: aparece fluctuación y fiebre. Tratamiento: antibiótico oral 7–10 días (cloxacilina o cefadroxilo; amoxicilina-ácido clavulánico si el origen es dental o hay anaerobios) y **drenaje** cuando fluctúa. Diagnóstico diferencial según el ritmo: la adenopatía **crónica e indolora** sugiere tuberculosis (escrófula; PPD y cultivo) o micobacteria atípica; la asociada a un gato, enfermedad por arañazo de gato (*Bartonella*, azitromicina); la bilateral con faringitis y esplenomegalia, mononucleosis; la > 1,5 cm unilateral con fiebre prolongada en un niño, Kawasaki; y la **dura, adherida o supraclavicular** obliga a descartar linfoma o metástasis con biopsia.

1.04.2.004

Otros flegmones del piso de la boca y del cuello: la angina de Ludwig (bilateral, submandibular + sublingual + submentoniano) es solo uno de ellos. El **flegmón submaxilar unilateral**, el absceso **parafaríngeo**, el **retrofaríngeo** (niños pequeños, rigidez cervical, babeo) y el del espacio masticador comparten origen odontogénico (segundo y tercer molar inferior) o faríngeo, y las mismas alarmas: **trismo, desplazamiento de la lengua, disfagia, voz «de papa caliente», estridor**. La prioridad es la **vía aérea**; luego antibiótico EV de amplio espectro con anaerobios (ampicilina-sulbactam, o clindamicina + ceftriaxona), TAC de cuello con contraste y **drenaje quirúrgico**. El médico general sospecha, inicia el antibiótico y **deriva de urgencia**.



A. FASCITIS NECROTIZANTE



B. ANGINA DE LUDWIG

Imagen 1.4

FIGURA 1.4 · ENFRENTAMIENTO DE INFECCIÓN NECROTIZANTE Y ANGINA DE LUDWIG

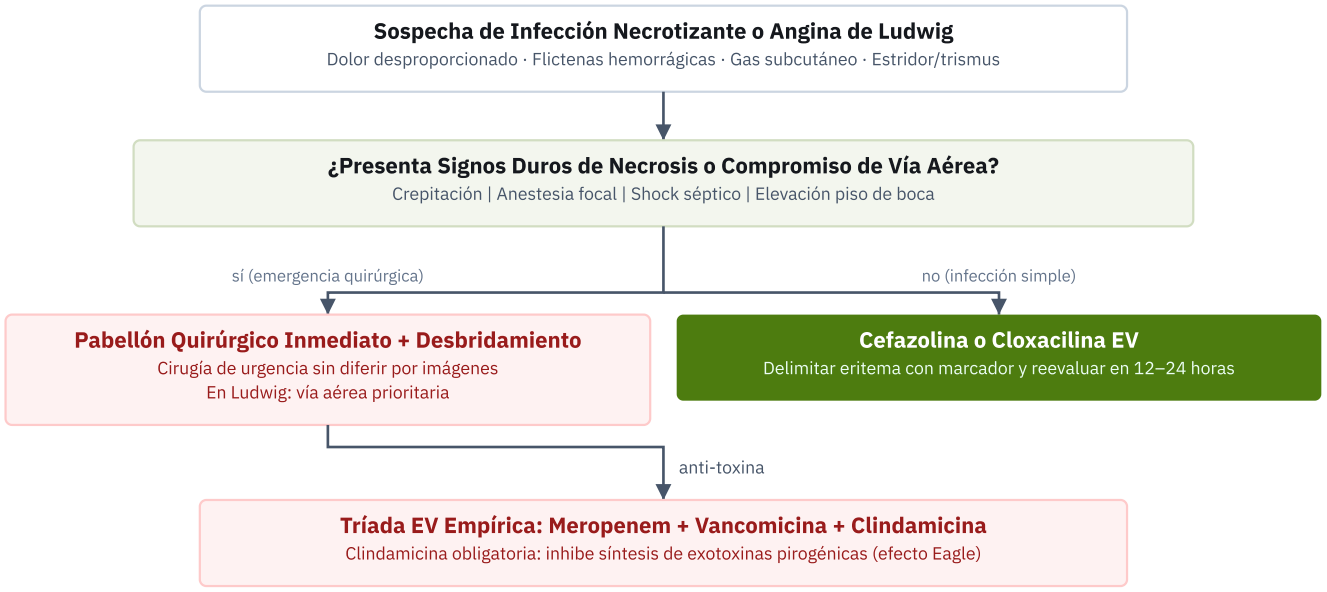


TABLA 1.4 · CELULITIS SIMPLE VS INFECCIÓN NECROTIZANTE DE PARTES BLANDAS `1.04.2.005, 1.04.2.004, 1.04.1.001, 6.01.2.005`

CARACTERÍSTICA	CELULITIS / ERISIPELA	FASCITIS NECROTIZANTE
Dolor y clínica	Proporcional al eritema visible	Severo, lacerante y desproporcionado al examen
Signos locales críticos	Calor, rubor y edema con fóvea	Flictenas hemorrágicas, crepitación, anestesia focal
Compromiso sistémico	Fiebre moderada, hemodinamia estable	Shock séptico, lactato elevado, falla multiorgánica
Conducta de elección	Antibióticos orales o EV en sala	Pabellón urgente + desbridamiento amplio + clindamicina

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Hombre de 56 años con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada consulta por aumento de volumen doloroso en pierna izquierda de 24 horas de evolución posterior a una herida cortante menor en el pie. Al examen: T° 38.8 °C, PA 85/55 mmHg, FC 126 lpm. En tercio medio de pierna se observa eritema mal delimitado con edema tenso. A la palpación el dolor es insoportable; se aprecian dos flictenas con líquido serosanguinolento y se palpa crepitación fina en el tejido celular subcutáneo. Exámenes: leucocitos 24.000/mm³, PCR 320 mg/L, sodio plasmático 128 mEq/L, lactato 4.8 mmol/L.

Conducta oficial. El paciente presenta una fascitis necrotizante (infección invasiva de partes blandas con shock séptico en paciente diabético). La presencia de dolor desproporcionado, flictenas hemorrágicas, crepitación subcutánea y compromiso hemodinámico con hiperlactatemia e hiponatremia (Score LRINEC > 8) confirman la sospecha diagnóstica. La conducta médica inmediata que define la sobrevida del paciente es el traslado urgente a pabellón para exploración quirúrgica y desbridamiento tisular extenso de todo el tejido necrótico, junto con resucitación hemodinámica y triterapia antibiótica con Meropenem + Vancomicina + Clindamicina.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El signo de sospecha más precoz de fascitis necrotizante es el DOLOR DESPROPORCIONADO al aspecto externo de la piel.
- Signos duros que confirman necrosis: flictenas serohemáticas, crepitación (gas tisular), anestesia cutánea focal y toxicidad sistémica.
- La exploración quirúrgica en pabellón con desbridamiento de urgencia es la medida terapéutica que define la sobrevida.
- NUNCA solicitar resonancia o TAC para confirmar la sospecha si ello demora la entrada a pabellón quirúrgico.
- Antibioticoterapia de elección: Meropenem + Vancomicina + Clindamicina (la clindamicina bloquea la síntesis de toxinas pirogénicas).
- Angina de Ludwig: celulitis bilateral submandibular/sublingual de origen dental; prioridad número 1 es asegurar la vía aérea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

1. Un paciente diabético de 52 años es evaluado en el box de reanimación por una lesión eritematosa en el muslo derecho con marcado edema y dolor intenso. A la palpación se detecta crepitación subcutánea y se aprecian flictenas hemorrágicas en el centro de la lesión. El paciente se encuentra febril (39 °C) e hipotenso (PA 80/50 mmHg). ¿Cuál es la conducta prioritaria en este momento?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear urgente del muslo para evaluar la profundidad del compromiso

B) Trasladar de inmediato a pabellón para exploración y desbridamiento quirúrgico extenso

C) Iniciar Cloxacilina 2 g EV y reevaluar los límites del eritema en 12 horas

D) Realizar punción aspirativa con aguja fina en la zona crepitante para cultivo y esperar resultado

E) Administrar corticoides endovenosos a dosis altas para reducir el edema de partes blandas

Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

2. Un paciente de 38 años consulta por aumento de volumen doloroso cervical anterior y submandibular de 48 horas de evolución, posterior a la extracción del tercer molar inferior izquierdo. Al examen se observa cuello en embudo, elevación de la lengua contra el paladar duro, trismus moderado, voz engolada y estridor inspiratorio intermitente. ¿Cuál es la prioridad médica inmediata?

A) Asegurar la vía aérea de forma inmediata mediante intubación guiada o traqueostomía

B) Solicitar TAC de cuello con contraste para drenaje percutáneo

C) Administrar antibióticos orales con Amoxicilina/Clavulánico y analgesia

D) Realizar laringoscopía indirecta con espejo en el box dental

E) Indicar nebulizaciones con adrenalina racémica y hospitalizar en sala básica

Más preguntas online de Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)	El concepto de SIRS fue eliminado: Sepsis = sospecha de infección + disfunción orgánica...	**qSOFA (≥ 2 de 3): FR ≥ 22 rpm, Glasgow < 15, Presión Sistólica ≤ 100 mmHg. Herramienta...**	—
Meningitis Aguda Bacteriana y Viral	Tríada meníngea: fiebre + rigidez de nuca + alteración mental. La ausencia de los 3...	**Citoquímico bacteriano: PMN > 80 %, proteínas > 100 mg/dL y consumo severo de glucosa...**	Si requiere TAC: administrar Dexametasona + ATB EV de inmediato antes del traslado...
Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	Encefalitis = fiebre + alteración de funciones cerebrales superiores (afasia, delirio...	**Causa más frecuente y letal: Virus Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1), con tropismo temporal...**	El cuadro de fiebre, cambios conductuales agudos, afasia sensitiva y crisis convulsivas...
Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	El signo de sospecha más precoz de fascitis necrotizante es el DOLOR DESPROPORCIONADO...	**Signos duros que confirman necrosis: flictenas serohemáticas, crepitación (gas...**	NUNCA solicitar resonancia o TAC para confirmar la sospecha si ello demora la entrada a...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El concepto de SIRS fue eliminado: Sepsis = sospecha de infección + disfunción orgánica aguda (SOFA ≥ 2).

qSOFA (≥ 2 de 3): FR ≥ 22 rpm, Glasgow < 15, Presión Sistólica ≤ 100 mmHg. Herramienta de alarma rápida.

Shock Séptico = necesidad de vasopresores para PAM ≥ 65 mmHg a pesar de 30 mL/kg de fluidos Y Lactato > 2 mmol/L.

Vasopresor de 1ª línea indiscutido: Noradrenalina EV. La dopamina está en desuso por arritmias y mayor mortalidad.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- qSOFA (≥ 2 de 3): FR ≥ 22 rpm, Glasgow < 15, Presión Sistólica ≤ 100 mmHg. Herramienta de alarma rápida.
- Shock Séptico = necesidad de vasopresores para PAM ≥ 65 mmHg a pesar de 30 mL/kg de fluidos Y Lactato > 2 mmol/L.
- Citoquímico bacteriano: PMN > 80 %, proteínas > 100 mg/dL y consumo severo de glucosa (ratio LCR/suero < 0.4).
- Citoquímico viral: predominio mononuclear/linfocítico con GLUCOSA NORMAL y proteínas levemente aumentadas.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El concepto de SIRS fue eliminado: Sepsis = sospecha de infección + disfunción orgánica aguda (SOFA ≥ 2).	Tema 1.1 →
Tríada meníngea: fiebre + rigidez de nuca + alteración mental. La ausencia de los 3 descarta prácticamente el...	Tema 1.2 →
Encefalitis = fiebre + alteración de funciones cerebrales superiores (afasia, delirio, conducta bizarra, crisis...	Tema 1.3 →
El signo de sospecha más precoz de fascitis necrotizante es el DOLOR DESPROPORCIONADO al aspecto externo de la...	Tema 1.4 →

MANUAL EUNACOM DE INFECTOLOGÍA

BLOQUE 02 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

4	10	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
2.1	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	22
2.2	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	25
2.3	IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	28
2.4	Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	30

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.3.009, 1.04.3.010, 1.04.3.001, 1.05.4.011, 1.08.5.007	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Específico	Completo	Completo
1.04.2.009, 1.04.3.008, 1.04.3.002, 1.04.3.012	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Específico	Inicial	Derivar
1.04.1.015, 1.04.3.005, 1.01.5.003, 1.04.3.011, 1.08.5.004, 1.09.5.004	IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	Específico	Completo	Completo
1.04.1.026, 1.04.1.007, 1.04.3.004	Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 02 · SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Todo menor de 15 años contacto de TBC bacilífera recibe isoniazida de entrada, sin importar el PPD inicial.
- El PPD solo se indica de rutina en menores de 15 años y pacientes VIH; en adultos sanos no se pide de rutina.
- Duración de profilaxis TBC: adultos PPD > 10 mm = 6 meses; VIH PPD > 5 mm = 9 meses; menor de 15 años = 6 meses si vira o 3 meses si persiste PPD (-).
- RN de madre con TBC: isoniazida 6 meses, diferir BCG, mantener lactancia materna con mascarilla.
- Profilaxis de contactos de meningitis: SOLO se realiza para Meningococo (Rifampicina 2 días o Cipro/Ceftriaxona dosis única) y Haemophilus influenzae b (Rifampicina 4 días).
- En embarazada contacto de meningococo, el antibiótico de elección es Ceftriaxona 250 mg IM dosis única.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	EUNACOM Diciembre 2022 · #81 · EUNACOM Julio 2019 · #142 · EUNACOM Diciembre 2017 · #16
IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	EUNACOM Julio 2025 · #33 · EUNACOM Diciembre 2024 · #69 · EUNACOM Enero 2023 · #102 · EUNACOM Diciembre 2019 · #114
Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	EUNACOM Diciembre 2024 · #45 · EUNACOM Enero 2023 · #76 · EUNACOM Diciembre 2022 · #55

2.1. Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 `1.04.3.009` `1.04.3.010` `1.04.3.001` `1.05.4.011` `1.08.5.007`

¿POR QUÉ?

El manejo de contactos y la profilaxis post-exposición son prioridades de salud pública en el EUNACOM. Los tres conceptos indispensables son: la quimioprofilaxis universal con isoniazida en todo menor de 15 años expuesto a TBC bacilífera, el uso de rifampicina en contactos de meningococo, y la ventana estricta de 72 horas para la triterapia antirretroviral laboral.

1. TUBERCULOSIS: QUIMIOPROFILAXIS EN CONTACTOS

La TBC se transmite por aerosoles desde pacientes bacilíferos (BK+). En **menores de 15 años y pacientes con VIH**, la respuesta celular es inmadura o deficiente, con altísimo riesgo de meningitis TBC y forma miliar. `1.04.3.009`

Regla de oro: en Chile, **todo menor de 15 años conviviente recibe Isoniazida oral de entrada** (10 mg/kg/día), sin esperar el PPD. Si el PPD inicial es negativo, se repite al 3° mes: si continúa negativo se suspende; si positiviza, se completan 6 meses. En adultos solo se trata si el PPD es > 10 mm (o > 5 mm en VIH). `1.04.3.009` `1.05.4.011`

2. RECIÉN NACIDO DE MADRE CON TBC ACTIVA

En el RN de madre con TBC pulmonar activa bacilífera, la conducta obligatoria consta de tres medidas simultáneas: `1.04.3.009`

1) Iniciar **Isoniazida oral por 6 meses**; 2) **Postergar la vacuna BCG** al término de la quimioprofilaxis (para no neutralizar el bacilo vacunal vivo); 3) **Mantener la lactancia materna** con uso obligatorio de mascarilla quirúrgica materna.

3. MENINGOCOCO, COQUELUCHE Y PROFILAXIS RESPIRATORIA

Meningococo (*N. meningitidis*): profilaxis a contactos que pernoctan bajo el mismo techo o expuestos a secreciones en los 7 días previos. Fármaco de elección: **Rifampicina oral 600 mg c/12h por 2 días** (o Ciprofloxacino 500 mg dosis única). En embarazadas: **Ceftriaxona 250 mg IM dosis única**. `1.04.3.010`

Coqueluche (*B. pertussis*): profilaxis con **Azitromicina oral por 5 días** a todos los contactos sintomáticos y a menores de 1 año o embarazadas.

4. ACCIDENTE CORTOPUNZANTE LABORAL (PEP VIH)

Tras una punción profunda con aguja hueca con sangre, el virus tarda 48 a 72 horas en diseminarse a los ganglios linfáticos. Por ello, la **Profilaxis Post-Exposición (PEP)** con **Triterapia Antirretroviral por 28 días** debe iniciarse antes de las **72 horas** (idealmente primeras 2–4 h). `1.04.3.001`

Conducta: lavado inmediato con agua y jabón, ELISA basal al trabajador, y oferta inmediata de triterapia sin retrasarla por el consentimiento o serología de la fuente.

5. PUNCIÓN VENOSA SEGURA Y LECTURA DEL PPD

Punción venosa (nivel «realizar»): higiene de manos y guantes; torniquete 7–10 cm sobre el sitio por menos de 1 minuto; se elige la vena mediana cubital o cefálica, se limpia con alcohol 70 % o clorhexidina en espiral y se **deja secar**; con la piel tensa, aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 15–30°; se **suelta el torniquete antes de retirar la aguja** y se comprime con gasa sin flexionar el codo. Orden de los tubos: frascos de hemocultivo, citrato (celeste), suero, heparina y EDTA (lila). La seguridad es parte del procedimiento: **no reencapuchar** las agujas, descartarlas de inmediato en contenedor rígido y, si ocurre una punción accidental, aplicar el manejo del accidente cortopunzante de este tema (lavado, notificación, serología y profilaxis). `1.08.5.007`

Técnica y lectura del PPD (nivel «interpreta y emplea»): se inyectan **2 UT de tuberculina (RT-23) por vía intradérmica** en la cara anterior del antebrazo, formando una pápula de 6–10 mm. Se lee a las **48–72 horas** midiendo en milímetros el diámetro transversal de la **induración** (no del eritema). Se considera positivo **≥ 10 mm** en la población general y **≥ 5 mm** en personas con VIH, inmunosupresión, contacto estrecho reciente de un caso bacilífero o Rx con secuelas. Un PPD positivo indica **infección**, no enfermedad activa (descartarla con clínica y Rx/baciloscopía antes de indicar quimioprofilaxis). La BCG previa rara vez da reacciones > 10 mm; son **falsos negativos** la anergia (VIH avanzado, desnutrición, corticoides, TBC miliar) y la mala técnica. El IGRA (QuantiFERON) no se afecta por la BCG. `1.05.4.011`

FIGURA 2.1 · ALGORITMO DE PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN Y MANEJO DE CONTACTOS

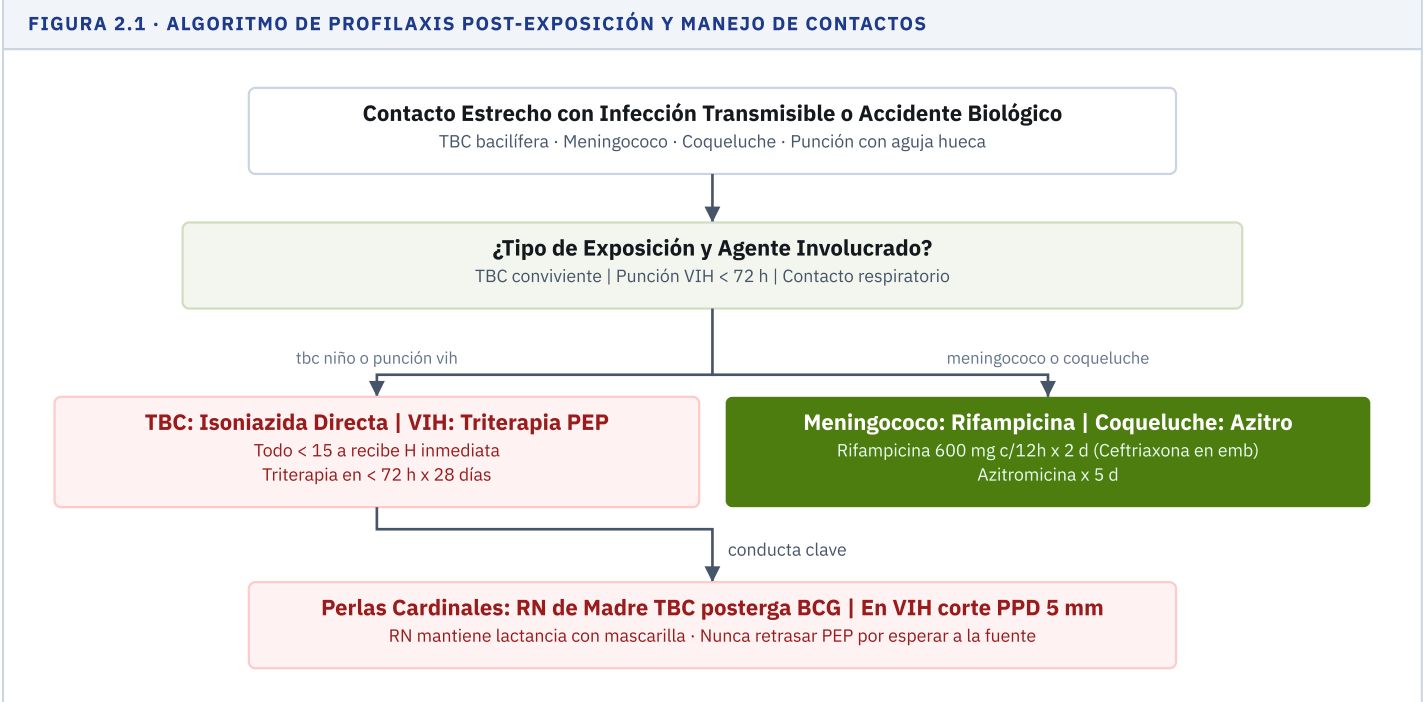


TABLA 2.1 · REGLAS DE QUIMIOPROFILAXIS EN CONTACTOS EUNACOM

1.04.3.009, 1.04.3.010, 1.04.3.001, 1.05.4.011, 1.08.5.007

ESCENARIO DE CONTACTO	POBLACIÓN OBJETIVO	ESQUEMA PROFILÁCTICO	PERLA CRÍTICA DE EXAMEN
TBC Pulmonar (BK+)	Menores de 15 años convivientes	Isoniazida directa (3 meses si PPD -; 6 meses si vira)	Todo < 15 a recibe isoniazida aunque PPD inicial sea 0 mm
RN de madre con TBC	Hijo de madre con TBC activa	Isoniazida 6 meses + postergar BCG al final	Lactancia materna permitida con mascarilla materna
Meningitis meningocócica	Convivientes en últimos 7 días	Rifampicina 600 mg c/12h x 2 días (o Cipro dosis única)	En embarazadas usar Ceftriaxona 250 mg IM dosis única
Accidente cortopunzante	Punción laboral con fuente VIH(+) o desc.	Triterapia oral x 28 días iniciada antes de 72 h	Nunca demorar PEP esperando resultado serológico de la fuente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.1

Interno de medicina de 24 años sufre punción profunda en dedo índice con aguja hueca calibre 21G tras tomar gases arteriales a un paciente hospitalizado en medicina interna cuyo estatus serológico es desconocido. El interno lava la herida inmediatamente con abundante agua y jabón. Al consultar al paciente fuente, este se niega inicialmente a realizarse exámenes de sangre.

Conducta oficial. En un accidente cortopunzante ocupacional de alto riesgo (aguja hueca con sangre arterial) proveniente de una fuente con estatus serológico desconocido, la normativa nacional de salud laboral indica ofrecer de inmediato la Profilaxis Post-Exposición (PEP) con triterapia antirretroviral oral al trabajador dentro de las primeras 2 a 4 horas (ventana máxima útil de 72 horas) por un total de 28 días, mientras se define la situación serológica. Paralelamente, se debe solicitar ELISA de VIH basal al trabajador accidentado (para documentar la ausencia de infección previa al accidente). Por ley, la toma de serología al paciente fuente requiere siempre consentimiento informado; no se puede obligar al paciente fuente ni esperar su autorización para proteger farmacológicamente al trabajador.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Todo menor de 15 años contacto de TBC bacilífera recibe isoniazida de entrada, sin importar el PPD inicial.
- El PPD solo se indica de rutina en menores de 15 años y pacientes VIH; en adultos sanos no se pide de rutina.
- Duración de profilaxis TBC: adultos PPD > 10 mm = 6 meses; VIH PPD > 5 mm = 9 meses; menor de 15 años = 6 meses si vira o 3 meses si persiste PPD (-).
- RN de madre con TBC: isoniazida 6 meses, diferir BCG, mantener lactancia materna con mascarilla.
- Profilaxis de contactos de meningitis: SOLO se realiza para Meningococo (Rifampicina 2 días o Cipro/Ceftriaxona dosis única) y Haemophilus influenzae b (Rifampicina 4 días).
- En embarazada contacto de meningococo, el antibiótico de elección es Ceftriaxona 250 mg IM dosis única.
- Coqueluche: profilaxis con Azitromicina por 5 días a contactos sintomáticos y a grupos de alto riesgo (< 1 año, embarazadas 3er trimestre).
- Accidente cortopunzante con fuente VIH (+) o desconocida: ofrecer triterapia antirretroviral (PEP) en las primeras horas durante 28 días, con controles serológicos al día 0, 6 semanas y 3 meses.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Manejo de Contactos

1. Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. Tras el lavado profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir?

A) Esperar resultado del ELISA del paciente fuente antes de decidir
B) Ofrecer de inmediato triterapia antirretroviral profiláctica (PEP) por 28 días a 6 semanas
C) Simplemente observar ya que la fuente probablemente es VIH negativa
D) Solicitar PCR para VIH al trabajador de salud de inmediato y esperar resultado
E) Iniciar monoterapia con zidovudina por 4 semanas

Banco de Preguntas Oficial · Manejo de Contactos

2. Niño de 8 años, contacto intradomiciliario de padre con tuberculosis bacilífera. Baciloscopía negativa, radiografía normal, PPD 6 mm. ¿Cuál es la conducta?

A) Iniciar tratamiento antituberculoso completo con 4 fármacos
B) No requiere profilaxis ya que el PPD es negativo (< 10 mm)
C) Isoniazida por 3 meses y controlar con nuevo PPD al término
D) Isoniazida por 6 meses sin necesidad de control posterior
E) Vacunar con BCG y observar evolución

Más preguntas online de Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes →

2.2. Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.2.009 | 1.04.3.008 | 1.04.3.002 | 1.04.3.012

¿POR QUÉ?

La rabia humana y el tétanos son enfermedades infecciosas neurotrópicas prevenibles por vacunación con letalidad cercana al 100% una vez que se manifiestan clínicamente. En el EUNACOM se evalúan las reglas exactas del MINSAL para indicar vacuna antirrábica (observación de perro por 10 días vs murciélago) y la inmunoprofilaxis antitetánica según el tipo de herida y el estado vacunal previo.

1. RABIA HUMANA: PATOGENIA Y NORMA TÉCNICA MINSAL

El virus rábico (*Lyssavirus*) es un virus ARN neurotrópico transmitido por la saliva de mamíferos infectados a través de mordeduras o contacto con mucosas. Tras la inoculación, el virus se replica en el miocito local y asciende por transporte axonal retrógrado a través de los nervios periféricos hacia el asta posterior de la médula y el encéfalo, causando una encefalomielitis letal con hidrofobia, espasmos laríngeos y paro cardiorrespiratorio.

Reglas MINSAL de profilaxis post-exposición antirrábica: 1.04.3.002

- **Animal doméstico conocido y ubicable (perro/gato):** se mantiene en **observación veterinaria estricta por 10 días**. Si el animal permanece sano tras los 10 días, NO se vacuna al paciente. Si el animal enferma, muere o desaparece, se inicia vacunación inmediata. 1.04.3.012
- **Animal desconocido, vagabundo o provocado:** se inicia **vacunación inmediata** (esquema de 5 dosis los días 0, 3, 7, 14 y 28).
- **Contacto con murciélago (quiróptero):** en Chile el reservorio silvestre endémico es el murciélago (*Tadarida brasiliensis*). **Todo contacto con murciélago (mordedura, manipulación a mano desnuda o despertar en una habitación con un murciélago)** se clasifica como exposición grave y exige **vacunación antirrábica completa inmediata + Inmunoglobulina antirrábica humana (IGH-R)**.

2. TÉTANOS: TOXINA TETÁNICA Y CUADRO CLÍNICO

Clostridium tetani es un bacilo Gram positivo anaerobio estricto formador de esporas omnipresentes en el suelo y heces animales. Las esporas germinan en tejidos desvitalizados, sucios o con bajo potencial redox (heridas punzantes, quemaduras, fracturas expuestas). 1.04.2.009

Produce la **tetanoespasmina**, una neurotoxina que asciende por transporte axonal retrógrado hacia las interneuronas inhibitorias de Renshaw en la médula espinal. La toxina degrada la sinaptobrevina, bloqueando la liberación de neurotransmisores inhibitorios (GABA y glicina). Esto produce una desinhibición motora masiva con **contracción muscular tónica sostenida y espasmos paroxísticos dolorosos**.

Clínica: trismus (espasmo del masetero), risa sardónica, opistótonos (arco dorsal rígido) y espasmos desencadenados por estímulos luminosos o sonoros. La mente permanece lúcida. La causa de muerte es el paro respiratorio por espasmo laríngeo o diafragmático. **(ver Imagen 2.2A y B)**

3. PROFILAXIS ANTITETÁNICA: LA REGLA DE LAS 3 DOSIS

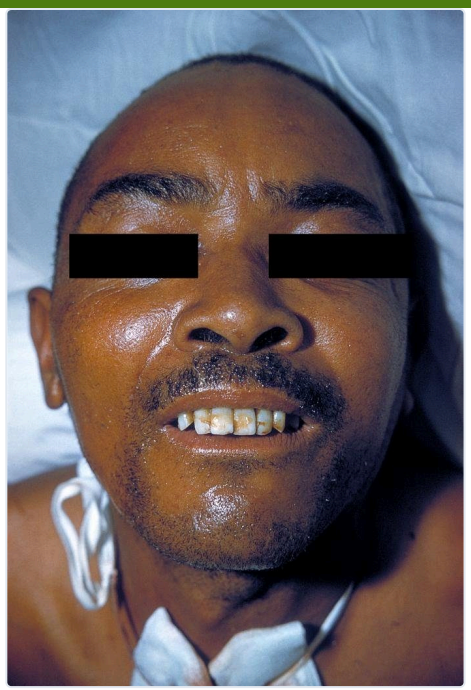
Ante cualquier herida, se debe evaluar: (1) las características de la herida (limpia vs sucia/tetanígena), y (2) el número de dosis previas de toxoide tetánico recibidas en la vida: 1.04.3.008

- **Herida limpia superficial:** requiere refuerzo con toxoide (vacuna dT) solo si han pasado **> 10 años** desde la última dosis. 1.04.3.008 | 1.04.3.002
- **Herida sucia o tetanígena** (contaminada con tierra, heces, saliva, punción profunda, mordedura, tejido desvitalizado): requiere refuerzo con toxoide si han pasado **> 5 años** desde la última dosis.
- **Esquema incompleto (< 3 dosis) o antecedente vacunal desconocido:** en herida sucia requiere **Vacuna (dT) + Inmunoglobulina antitetánica humana (IGH-T 250 UI IM)** en sitios anatómicos separados.

4. MORDEDURAS: MANEJO LOCAL Y VACUNAS ESPECIALES

Manejo local de la mordedura: lavar de inmediato con agua y jabón por 10–15 minutos, irrigar a presión con suero, retirar tejido desvitalizado y explorar estructuras profundas (tendones, articulaciones, hueso). **No se sutura** una herida punzante, con más de 8–12 horas o con signos de infección (la cara es la excepción, por estética y buena irrigación). Se indica **antibiótico profiláctico por 3–5 días** en mordedura de gato, de mano, profunda, humana, en inmunosuprimidos, asplénicos o hepatópatas: **amoxicilina-ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 h** (alérgicos: doxiciclina, o clindamicina + ciprofloxacino/TMP-SMX). Los gérmenes son *Pasteurella multocida* (infección en menos de 24 h), *Capnocytophaga canimorsus* (asplenia, alcoholismo), *S. aureus*, estreptococos y anaerobios; la mordedura humana agrega riesgo de VHB, VHC y VIH. Siempre se evalúa la profilaxis antitetánica y antirrábica (puntos anteriores), la observación del animal por 10 días y la notificación. 1.04.3.002

Vacunas especiales (fuera del esquema habitual, por riesgo): **neumococo** (adultos ≥ 65 años y de riesgo: asplenia, inmunosupresión, enfermedad crónica, fístula de LCR; esquema conjugada seguida de polisacárida), **influenza** anual (embarazadas, ≥ 65 años, crónicos, personal de salud, niños de 6 meses a 5.º básico), **hepatitis B** (personal de salud, hemodiálisis, VIH, contactos; esquema 0-1-6 meses), **hepatitis A** (hepatopatía crónica, viajeros, brotes), **meningococo** (asplenia, déficit de complemento, brotes, peregrinos), **varicela** (susceptibles de riesgo y personal de salud) y **rabia** (profilaxis preexposición en veterinarios y personal expuesto a murciélagos: 3 dosis los días 0, 7 y 21–28). Regla general: las vacunas **vivas atenuadas** (varicela, SRP, fiebre amarilla) están contraindicadas en el embarazo y en la inmunosupresión grave; las inactivadas son seguras. 1.04.3.012



A. RISA SARDÓNICA



B. OPISTÓTONOS

Imagen 2.2

TABLA 2.2 · MATRIZ DE CONDUCTA OFICIAL EN PROFILAXIS ANTITETÁNICA (MINSAL) `1.04.2.009, 1.04.3.008, 1.04.3.002, 1.04.3.012`

HISTORIA DE VACUNACIÓN PREVIA	HERIDA LIMPIA Y SUPERFICIAL	HERIDA SUCIA / TETANÍGENA / PUNZANTE
Incompleta (< 3 dosis) o Desconocida	Vacuna (dT) 3 dosis · Sin IGH-T	Vacuna (dT) 3 dosis + Inmunoglobulina (IGH-T 250 UI)
Completa (≥ 3 dosis) · Última < 5 años	No requiere nada	No requiere nada
Completa (≥ 3 dosis) · Última 5 a 10 años	No requiere nada	Solo refuerzo de Vacuna (dT) · Sin IGH-T
Completa (≥ 3 dosis) · Última > 10 años	Solo refuerzo de Vacuna (dT)	Solo refuerzo de Vacuna (dT) · Sin IGH-T

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Hombre de 32 años, campesino, sufre herida punzante profunda en la planta del pie derecho con un clavo oxidado en un establo. Refiere haber recibido vacunas en su infancia pero no recuerda ningún refuerzo en los últimos 15 años. Al examen: herida puntiforme de 1 cm con márgenes desvitalizados, dolor moderado y restos de barro en su interior.

Conducta oficial. Se trata de una herida claramente tetanígena (punzante profunda, contaminada con tierra y materia fecal animal). Dado que el paciente tiene antecedentes de vacunación infantil (≥ 3 dosis en el PNI) pero su último refuerzo fue hace más de 10 años, la conducta según la norma técnica es administrar de inmediato un refuerzo de toxoide tetánico (dT). NO requiere inmunoglobulina antitetánica pasiva (IGH-T), ya que esta última se reserva estrictamente para pacientes con esquema incompleto (< 3 dosis) o antecedente vacunal desconocido ante heridas sucias.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Rabia por perro/gato ubicable: observación por 10 días. Si el animal está sano al día 10, NO se vacuna al paciente.
- Rabia por murciélago: contacto = exposición grave = VACUNA INMEDIATA + INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA en el 100% de los casos.
- Tétanos: toxina bloquea la liberación de GABA y glicina en las interneuronas medulares inhibitorias.
- Herida limpia: refuerzo de toxoide si pasaron > 10 años. Herida sucia: refuerzo si pasaron > 5 años.
- Inmunoglobulina antitetánica (IGH-T): SOLO se administra si la herida es sucia/tetanígena Y el esquema es desconocido o < 3 dosis.
- Manejo de tétanos establecido: Ingreso a UCI en box oscuro y silencioso, Metronidazol EV (o Penicilina), IGH-T 3.000-6.000 UI, sedación y relajantes musculares.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Rabia y Tétanos

1. Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No presenta heridas evidentes ni recuerda haber sido mordido. ¿Cuál es la conducta inmediata recomendada?

A) Observar al paciente de forma ambulatoria y consultar solo si presenta fiebre o cefalea
B) Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato
C) Capturar al murciélago para observarlo vivo durante 10 días
D) Administrar profilaxis con amoxicilina y citar a curaciones diarias
E) Descartar el riesgo de rabia dado que no existen lesiones cortantes visibles

Banco de Preguntas Oficial · Rabia y Tétanos

2. Una mujer de 45 años consulta tras cortarse la mano con una lata oxidada en su patio. Su esquema de vacunación contra el tétanos está al día, habiendo recibido su última dosis de refuerzo hace 3 años. ¿Cuál es la indicación correcta?

A) Aseo quirúrgico local de la herida sin necesidad de vacuna ni inmunoglobulina
B) Administrar refuerzo con toxoide tetánico (dT)
C) Administrar inmunoglobulina antitetánica (IGH-T) en dosis de 250 UI
D) Administrar vacuna dT + inmunoglobulina antitetánica
E) Iniciar profilaxis antibiótica con ciprofloxacino por 10 días

Más preguntas online de Rabia y Tétanos →

2.3. IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.015 | 1.04.3.005 | 1.01.5.003 | 1.04.3.011 | 1.08.5.004 | 1.09.5.004

¿POR QUÉ?

Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) son un indicador directo de calidad asistencial y una causa mayor de morbimortalidad intrahospitalaria. El EUNACOM evalúa de forma repetitiva dos competencias prácticas: definir el tipo de aislamiento hospitalario que corresponde según el patógeno y la conducta diagnóstica y terapéutica ante una infección de catéter venoso central (CVC).

1. PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO HOSPITALARIO: TIPOS Y PATÓGENOS CLAVE

Todos los pacientes hospitalizados requieren **Precauciones Estándar** (higiene de manos con alcohol gel o agua y jabón antes y después del contacto, uso de EPP según riesgo de salpicadura y manejo seguro de cortopunzantes). Adicionalmente, se indican **Precauciones Específicas basadas en el mecanismo de transmisión**: 1.04.3.005

- **Aislamiento de Contacto:** bata limpia no estéril + guantes antes de entrar a la habitación. Para: microorganismos multirresistentes (SAMR, BLEE, enterococo resistente a vancomicina VRE), *Clostridioides difficile* (lavado de manos OBLIGATORIO con agua y jabón, el alcohol gel no destruye las esporas), rotavirus, sarna noruega e impétigo.
- **Aislamiento por Gotitas (partículas > 5 micrones, caen a < 1 metro):** mascarilla quirúrgica antes de entrar. Habitación compartida por cohorte o separada por > 1 metro. Para: Meningococo (*Neisseria meningitidis*), Influenza, Adenovirus, Coqueluche, Parotiditis y Rubéola.
- **Aislamiento Aéreo / Respiratorio (núcleos de gotitas < 5 micrones, flotan en el aire):** mascarilla de alta eficiencia N95 o FFP2 + **habitación individual con presión negativa** (mínimo 6-12 recambios de aire por hora) con puerta siempre cerrada. Para: **Tuberculosis pulmonar bacilífera activa, Sarampión y Varicela / Herpes zóster diseminado**.

2. INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADA A CATÉTER VENOSO CENTRAL (ITSCVC)

Se produce por migración de bacterias de la piel a lo largo del trayecto externo del catéter (vía extraluminal precoz < 10 días) o por contaminación del conector y soluciones de infusión (vía intraluminal tardía > 10 días). Patógenos causales: *Staphylococcus epidermidis* (coagulasa negativo, 40-50%), *Staphylococcus aureus* (20%), enterobacterias y *Candida spp.* 1.04.1.015

Diagnóstico microbiológico pareado: se toman **hemocultivos periféricos simultáneos con hemocultivos tomados a través de cada lumen del CVC**. Criterio diagnóstico de certeza: (1) Crecimiento del mismo microorganismo en ambos frascos con una diferencia de tiempo de positividad (DTP) > 2 horas antes en el CVC respecto al periférico, o (2) Cultivo cuantitativo con una proporción CVC/periférico ≥ 3:1.

3. CONDUCTA TERAPÉUTICA Y CRITERIOS DE RETIRO INMEDIATO DEL CVC

Antibioticoterapia empírica: Vancomicina EV (para cubrir SAMR y estafilococo coagulasa negativo) asociada a cobertura para bacilos Gram negativos (Cefepime, Piperacilina-Tazobactam o Amikacina) si el paciente está séptico o neutropénico. 1.04.1.015

Criterios mandatorios de RETIRO INMEDIATO del catéter:

1. Shock séptico o inestabilidad hemodinámica severa.
2. Infección del túnel subcutáneo o eritema/pus franco en el sitio de inserción.
3. Complicaciones metastásicas: endocarditis bacteriana, tromboflebitis séptica supurada o embolias sépticas pulmonares.
4. Microorganismos de alto riesgo: ***Staphylococcus aureus*, *Candida spp.*, *Pseudomonas aeruginosa* o bacterias multirresistentes**.
5. Persistencia de bacteriemia o fiebre tras 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico adecuado.

4. CATÉTER VENOSO CENTRAL, SONDA FOLEY Y USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS

Cateterismo venoso central (nivel «derivar»): se indica ante acceso periférico imposible o prolongado, vasopresores, nutrición parenteral, quimioterapia irritante, hemodiálisis o monitorización de la PVC. Lo instala un especialista (anestesiólogo, intensivista, cirujano), idealmente **guiado por ecografía**; el médico general lo indica, lo deriva y reconoce sus complicaciones. Sitio preferido: **yugular interna o subclavia** (la vía femoral tiene más infección y trombosis). Prevención de la bacteriemia asociada: higiene de manos, **barrera máxima estéril**, clorhexidina alcohólica > 0,5 %, apósito transparente y **retiro apenas deje de ser necesario**. Al terminar se confirma la posición (punta en vena cava superior) y se descarta **neumotórax** con una Rx de tórax; otras complicaciones: punción arterial, hemotórax, arritmia, embolia aérea y trombosis. 1.01.5.003 | 1.08.5.004

Instalación y cuidado de la sonda Foley (nivel «realizar»): se indica en retención urinaria aguda, control estricto de diuresis en el paciente crítico, cirugía, úlceras sacras con incontinencia y cuidados paliativos; **no por comodidad**. Técnica: asepsia, gel de lidocaína estéril, calibre 14–16 Fr en adultos, avanzar hasta la bifurcación y comprobar salida de orina antes de inflar el balón con 10 mL de agua destilada; sistema **cerrado**, bolsa bajo el nivel vesical y, en el varón, **reponer el prepucio** (evita parafimosis). Contraindicación: sospecha de lesión uretral (trauma pélvico, sangre en el meato, próstata ascendida), que exige uretrografía. Cada día de sonda aumenta 3–7 % el riesgo de **ITU asociada a catéter**: retirarla lo antes posible, no tomar urocultivo sin síntomas y no tratar la bacteriuria asintomática. 1.09.5.004

Uso racional de antibióticos: tomar cultivos antes de la primera dosis; elegir según el foco, la gravedad y la epidemiología local; dosis plenas; **reevaluar a las 48–72 h** con el cultivo y descalar el espectro; preferir vía oral si el paciente la tolera; y usar **cursos cortos** (la mayoría de las infecciones se tratan en 5–7 días). No se indican antibióticos en infecciones virales (resfrío, faringitis viral, bronquitis aguda), ni en la bacteriuria asintomática (salvo embarazo o antes de cirugía urológica), ni para colonización. El abuso selecciona resistencia (BLEE, SAMR, carbapenemasas) y favorece la infección por *Clostridioides difficile*. La profilaxis quirúrgica se da dentro de los 60 minutos previos a la incisión y no más de 24 h. 1.04.3.011

TABLA 2.3 · TIPOS DE AISLAMIENTO HOSPITALARIO EUNACOM: PATÓGENOS Y MEDIDAS OBLIGATORIAS 1.04.1.015, 1.04.3.005, 1.01.5.003, 1.04.3.011, 1.08.5.004, 1.09.5.004

TIPO DE AISLAMIENTO	MEDIDAS Y EPP OBLIGATORIO	HABITACIÓN REQUERIDA	PATÓGENOS CLÁSICOS EUNACOM
Contacto	Guantes + Pechera/Bata plástica al entrar	Individual o cohorte de misma bacteria	Clostridioides difficile, SAMR, VRE, BLEE, Sarna
Gotitas	Mascarilla quirúrgica al entrar al box	Separación > 1 metro entre camas	Meningococo, Influenza, Coqueluche, Parotiditis
Aéreo (Respiratorio)	Mascarilla N95 / FFP2 con sello hermético	Presión negativa + puerta cerrada obligatoria	Tuberculosis bacilífera, Sarampión, Varicela activa
Protector (Inverso)	Mascarilla quirúrgica + bata limpia + no flores	Presión positiva (flujo laminar)	Neutropenia severa (RAN < 500), Trasplante médula

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Hombre de 64 años hospitalizado en UCI por pancreatitis aguda grave, portador de catéter venoso central subclavio derecho desde hace 12 días, presenta bruscamente alza térmica hasta 39 °C con calofríos y taquicardia. El sitio de inserción del CVC se encuentra limpio, sin eritema ni secreción. Se toman hemocultivos pareados (periféricos y a través del CVC) y a las 14 horas el laboratorio informa crecimiento de Staphylococcus aureus meticilino-resistente (SAMR) en ambos frascos.

Conducta oficial. El paciente presenta una bacteriemia asociada a catéter venoso central por Staphylococcus aureus. A diferencia de las infecciones por estafilococo coagulasa negativo (donde en ocasiones seleccionadas se puede intentar sellado de catéter), la bacteriemia por S. aureus tiene una altísima propensión a causar siembras metastásicas (endocarditis en 20-30%, espondilodiscitis y abscesos esplénicos). La indicación categórica e inmediata es el RETIRO OBLIGATORIO del CVC, inicio de Vancomicina EV (ajustada a niveles plasmáticos de valle) y realización mandatoria de ecocardiograma transtorácico o transesofágico para descartar endocarditis infecciosa.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Clostridioides difficile requiere Aislamiento de Contacto y LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN (el alcohol no inactiva esporas).
- Tuberculosis activa, Sarampión y Varicela exigen Aislamiento AÉREO: mascarilla N95 y habitación con PRESIÓN NEGATIVA.
- Meningococo exige Aislamiento de GOTITAS (mascarilla quirúrgica) hasta cumplir 24 horas de antibióticos efectivos.
- Bacteriemia por catéter por Staphylococcus aureus o Candida: el CVC se debe RETIRAR SIEMPRE sin excepción.
- Diagnóstico de bacteriemia por CVC: crecimiento del mismo germen en CVC y periférico con diferencia de positividad > 2 horas a favor del CVC.
- Criterios de retiro de CVC: shock séptico, S. aureus, hongos (Candida), infección del trayecto tunelizado y bacteriemia persistente a las 72 h.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · IAAS y Aislamientos

1. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y que el personal de salud utilice mascarilla N95?

A) Meningitis aguda por Neisseria meningitidis
B) Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva
C) Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile
D) Coqueluche por Bordetella pertussis
E) Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae productora de BLEE

Banco de Preguntas Oficial · IAAS y Aislamientos

2. Un paciente de 58 años en hemodiálisis por fístula nativa en maduración es portador de un catéter tunelizado yugoslavo. Consulta por fiebre de 38.8 °C post-diálisis. Los hemocultivos periféricos y del catéter resultan positivos para Candida albicans. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto al catéter?

A) Mantener el catéter e iniciar fluconazol endovenoso con técnica de sellado de catéter
B) Retirar inmediatamente el catéter y administrar terapia antifúngica sistémica
C) Recambiar el catéter sobre una guía de alambre en el mismo sitio
D) Observar por 48 horas tras iniciar antifúngicos y retirar solo si persiste la fiebre
E) Instilar etanol al 70% por los lúmenes y mantener el catéter para diálisis

Más preguntas online de IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento →

2.4. Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.026 1.04.1.007 1.04.3.004

¿POR QUÉ?

Las toxicoinfecciones alimentarias y las diarreas mediadas por enterotoxinas (como el Cólera) se presentan como brotes epidémicos agudos. El examen EUNACOM evalúa de manera casi matemática la identificación del patógeno causal a través del período de incubación y el alimento vehículo, así como el reconocimiento de la parálisis flácida descendente del botulismo.

1. CRONOLOGÍA E INCUBACIÓN: LA CLAVE DIAGNÓSTICA EN TOXICOINFECCIONES

El tiempo transcurrido entre la ingesta del alimento sospechoso y el inicio de los síntomas permite diferenciar dos grandes mecanismos fisiopatológicos: 1.04.1.026

• **Toxinas preformadas en el alimento (incubación ultra-corta < 6 horas):** la bacteria ya produjo la enterotoxina en la comida antes de ser ingerida. Cursa típicamente con náuseas intensas y **vómitos incoercibles**, sin fiebre. Patógenos prototípicos: *Staphylococcus aureus* (asociado a mayonesas caseras, pasteles con crema, jamón y ensaladas de papa) y *Bacillus cereus* variedad emética (asociado a **arroz frito o recalentado**).

• **Toxinas producidas in vivo tras la ingesta (incubación intermedia 8 a 16 horas):** se ingiere la bacteria viable o sus esporas, las cuales colonizan el intestino delgado y secretan toxinas. Predominan los cólicos abdominales intensos y la diarrea acuosa profusa. Prototipos: *Clostridium perfringens* (carnes recalentadas, guisos, estofados) y *Bacillus cereus* variedad diarreica.

• **Invasión bacteriana o toxinas complejas (incubación larga > 16 a 48 horas):** cursan con fiebre, dolor abdominal inflamatorio y en ocasiones disentería. Prototipos: *Salmonella enteritidis* (huevos crudos, aves), *Campylobacter jejuni* (carne de pollo cruda, leche no pasteurizada) y *Escherichia coli* enterotoxigénica (diarrea del viajero).

2. CÓLERA (VIBRIO CHOLERAE): PATOGENIA Y DESHIDRATACIÓN FULMINANTE

Vibrio cholerae serogrupos O1 y O139 es transmitido por agua o mariscos bivalvos contaminados con heces humanas. Es una **Enfermedad de Notificación Obligatoria Inmediata**. 1.04.1.007

La bacteria secreta la **toxina colérica**, la cual se une al ganglíosido GM1 enterocítico y activa de forma irreversible la adenilato ciclasa mediante ADP-ribosilación de la subunidad Gs. Esto eleva masivamente el AMP cíclico intracelular, abriendo los canales CFTR de cloruro y bloqueando la absorción de sodio.

El resultado es una hipersecreción masiva de agua y electrolitos hacia el lumen intestinal, produciendo la clásica **diarrea acuosa en "agua de arroz"** (blanquecina, sin olor fétido ni sangre). Las pérdidas fecales pueden alcanzar 1 litro por hora, conduciendo a shock hipovolémico exanguinante y muerte en menos de 12 horas si no se rehidrata.



Deposiciones en "agua de arroz" del cólera

Tratamiento: la prioridad absoluta es la **rehidratación vigorosa** (Sales de Rehidratación Oral OMS si tolera, o Ringer Lactato EV masivo en shock). En casos moderados a severos se asocia antibiótico para acortar la duración: **Doxiciclina oral 300 mg en dosis única** (o Azitromicina 1 g dosis única en niños y embarazadas).

3. BOTULISMO (CLOSTRIDIUM BOTULINUM): LA PARÁLISIS FLÁCIDA DESCENDENTE

Clostridium botulinum es un bacilo anaerobio cuyas esporas contaminan conservas caseras mal esterilizadas (vegetales, pescados, embutidos en frascos de vidrio). 1.04.1.026

La **toxina botulínica** es la sustancia más letal conocida. Tras absorberse en el tubo digestivo, viaja por vía hematógena y destruye las proteínas SNARE (SNAP-25) en las terminaciones colinérgicas presinápticas, bloqueando la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y en el sistema nervioso autónomo.

Tríada clínica patognomónica: (1) Compromiso de pares craneanos (visión borrosa, diplopía, ptosis palpebral, disfagia y disartria), (2) **Parálisis motora flácida simétrica DESCENDENTE** (de cabeza a extremidades, sin compromiso sensitivo), y (3) Disautonomía (midriasis arreactiva, sequedad bucal, constipación e íleo paralítico).



Botulismo

Manejo: hospitalización inmediata en UCI por riesgo de paro respiratorio, soporte ventilatorio mecánico y administración precoz de **Antitoxina Botulínica Equina trivalente o heptavalente** (neutraliza la toxina libre circulante; no revierte la parálisis ya establecida).

5. PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES ENTÉRICAS

La prevención se basa en cortar la vía fecal-oral: **agua segura** (potable o clorada; hervir 1 minuto en emergencias), **lavado de manos con jabón** después de ir al baño y antes de comer o preparar alimentos, eliminación sanitaria de excretas y control de moscas. En los alimentos: cocción completa, evitar el contacto de crudos con cocidos, **cadena de frío** (refrigerar bajo 5 °C), lavado y desinfección de frutas y hortalizas (en Chile, regadas con aguas servidas, vehiculizan cólera, tifoidea, hepatitis A e hidatidosis) y **no consumir mariscos crudos** ni conservas caseras mal esterilizadas (botulismo; la miel está prohibida bajo 1 año). La vacunación complementa: hepatitis A, vacuna antitifoídica (Vi) para zonas endémicas o viajeros, vacuna oral anticolérica en brotes y viajeros de riesgo. Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos se notifican y se investigan; en el viajero se educa sobre «hervirlo, cocinarlo o pelarlo». 1.04.3.004

TABLA 2.4 · TOXICOINFECCIONES ALIMENTARIAS: GUÍA RÁPIDA POR ALIMENTO Y TIEMPO DE INCUBACIÓN

1.04.1.026, 1.04.1.007, 1.04.3.004

MICROORGANISMO	PERÍODO INCUBACIÓN	ALIMENTO PROTOTÍPICO	MANIFESTACIÓN CARDINAL
Staphylococcus aureus	1 a 6 horas (muy rápido)	Mayonesa casera, cremas, pastelería	Vómitos intensos incoercibles, sin fiebre
Bacillus cereus (emético)	1 a 5 horas	Arroz frito o recalentado chino	Náuseas y vómitos explosivos
Clostridium perfringens	8 a 16 horas	Carnes guisadas, estofados recalentados	Dolor cólico intenso y diarrea, sin vómitos
Salmonella no tifoidea	12 a 48 horas	Huevos crudos, mayonesa, pollo crudo	Fiebre alta, vómitos y diarrea con estrías
Vibrio cholerae	12 a 72 horas	Agua contaminada, mariscos crudos	Diarrea profusa en agua de arroz sin dolor
Clostridium botulinum	12 a 36 horas	Conservas caseras, vegetales enlatados	Parálisis flácida descendente + diplopía

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Cuatro miembros de una familia consultan en urgencias con náuseas y vómitos profusos de inicio explosivo hace 3 horas. Refieren haber almorzado hace 4 horas pastel de choclo y ensalada rusa con mayonesa casera preparada la noche anterior. Ninguno presenta fiebre, ni deposiciones diarreicas hasta el momento del ingreso. El examen físico destaca deshidratación leve y dolor epigástrico secundario a los esfuerzos de vómitos.

Conducta oficial. El período de incubación extremadamente corto (3 a 4 horas) con predominio absoluto de vómitos incoercibles y ausencia de fiebre es la presentación clásica de una intoxicación alimentaria por enterotoxina preformada de Staphylococcus aureus, típicamente asociada al consumo de mayonesas caseras o alimentos ricos en proteínas conservados a temperatura ambiente. El tratamiento es de soporte sintomático: rehidratación oral fraccionada o cristaloides EV y antieméticos (Ondansetrón). No se indican antibióticos ya que el cuadro es mediado por toxinas preformadas y es autolimitado (cede en 24 horas).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Incubación < 6 horas con vómitos predominantes y sin fiebre: enterotoxina preformada (S. aureus en mayonesas o B. cereus en arroz).
- Incubación de 8 a 16 horas con diarrea y cólicos: Clostridium perfringens (carnes y guisos recalentados).
- Incubación > 16 horas con fiebre: invasión bacteriana (Salmonella o Campylobacter).
- Cólera: diarrea acuosa masiva en "agua de arroz" con deshidratación fulminante; tratamiento es rehidratación agresiva + Doxiciclina dosis única.
- Botulismo: parálisis flácida simétrica descendente que inicia con diplopía, ptosis y disfagia tras consumir conservas caseras.
- El tratamiento del botulismo es soporte en UCI y ANTITOXINA BOTULÍNICA endovenosa precoz.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Intoxicación Alimentaria y Cólera

1. Un grupo de colegas de trabajo presenta náuseas y vómitos severos unas 3 horas después de compartir arroz frito recalentado en un almuerzo de oficina. No presentan fiebre ni deposiciones diarreicas. ¿Cuál es el patógeno causal más probable?

A) Salmonella enteritidis
B) Bacillus cereus (forma emética)
C) Clostridium perfringens
D) Escherichia coli enterotoxigénica
E) Campylobacter jejuni

Banco de Preguntas Oficial · Intoxicación Alimentaria y Cólera

2. Una mujer de 52 años es llevada a urgencias por presentar visión doble (diplopía), caída de los párpados y dificultad para tragar de inicio progresivo hace 24 horas, agregándose debilidad en extremidades superiores. Refiere haber consumido conservas caseras de espárragos el día anterior. Al examen físico se constata ptosis palpebral bilateral, midriasis arreactiva y tetraparesia flácida simétrica con reflejos osteotendíneos disminuidos. La sensibilidad es normal y está afebril. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata?

A) Iniciar infusión de plasmaféresis por sospecha de Síndrome de Guillain-Barré
B) Hospitalizar en UCI, monitorizar mecánica ventilatoria y administrar antitoxina botulínica
C) Administrar Ceftriaxona 2 g EV por sospecha de meningitis bacteriana
D) Indicar tratamiento con Piridostigmina oral por probable crisis miasténica
E) Administrar bolo de metilprednisolona EV por sospecha de esclerosis múltiple

Más preguntas online de Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Todo menor de 15 años contacto de TBC bacilífera recibe isoniazida de entrada, sin...	**El PPD solo se indica de rutina en menores de 15 años y pacientes VIH; en adultos sanos...**	—
Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Rabia por perro/gato ubicable: observación por 10 días. Si el animal está sano al día...	**Rabia por murciélago: contacto = exposición grave = VACUNA INMEDIATA + INMUNOGLOBULINA...**	—
IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	Clostridioides difficile requiere Aislamiento de Contacto y LAVADO DE MANOS CON AGUA Y...	**Tuberculosis activa, Sarampión y Varicela exigen Aislamiento AÉREO: mascarilla N95 y...**	El paciente presenta una bacteriemia asociada a catéter venoso central por...
Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	Incubación < 6 horas con vómitos predominantes y sin fiebre: enterotoxina preformada...	**Incubación de 8 a 16 horas con diarrea y cólicos: Clostridium perfringens (carnes y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Todo menor de 15 años contacto de TBC bacilífera recibe isoniazida de entrada, sin importar el PPD inicial.

El PPD solo se indica de rutina en menores de 15 años y pacientes VIH; en adultos sanos no se pide de rutina.

Duración de profilaxis TBC: adultos PPD > 10 mm = 6 meses; VIH PPD > 5 mm = 9 meses; menor de 15 años = 6 meses si vira o 3...

RN de madre con TBC: isoniazida 6 meses, diferir BCG, mantener lactancia materna con mascarilla.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El PPD solo se indica de rutina en menores de 15 años y pacientes VIH; en adultos sanos no se pide de rutina.
- Duración de profilaxis TBC: adultos PPD > 10 mm = 6 meses; VIH PPD > 5 mm = 9 meses; menor de 15 años = 6 meses si vira o 3 meses si persiste PPD (-).
- Rabia por murciélago: contacto = exposición grave = VACUNA INMEDIATA + INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA en el 100% de los casos.
- Tétanos: toxina bloquea la liberación de GABA y glicina en las interneuronas medulares inhibitorias.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Todo menor de 15 años contacto de TBC bacilífera recibe isoniazida de entrada, sin importar el PPD inicial.	Tema 2.1 →
Rabia por perro/gato ubicable: observación por 10 días. Si el animal está sano al día 10, NO se vacuna al paciente.	Tema 2.2 →
Clostridioides difficile requiere Aislamiento de Contacto y LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN (el alcohol no...	Tema 2.3 →
Incubación < 6 horas con vómitos predominantes y sin fiebre: enterotoxina preformada (S. aureus en mayonesas o B...	Tema 2.4 →

MANUAL EUNACOM DE INFECTOLOGÍA

BLOQUE 03 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

5	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
3.1	Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)	36
3.2	Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	39
3.3	Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	43
3.4	Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas	47
3.5	Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH	51

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.1.014, 3.01.1.031, 2.01.1.012	Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral	Específico	Completo	Completo
1.04.1.014, 1.05.1.029, 1.04.3.006, 1.04.1.005, 1.04.4.004, 1.06.1.012, 1.08.3.010, 1.04.4.001	Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	Específico	Inicial	Derivar
1.04.1.028, 1.05.1.036, 1.05.1.013, 1.05.1.037, 4.03.1.016	Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	Específico	Completo	Completo
1.04.1.023, 1.04.1.010, 1.04.4.016, 6.01.1.008, 6.01.2.012, 6.01.4.007	Infecciones de Transmisión Sexual	Específico	Completo	Completo
1.04.1.010, 4.01.1.058, 3.01.3.010, 1.04.3.003, 1.04.5.004, 4.03.3.004	Infecciones de Transmisión Sexual	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 03 · INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Ley del SIDA: test de VIH es voluntario, confidencial y requiere consentimiento informado firmado.
- **! TRAMPA** · El diagnóstico definitivo en Chile lo realiza EXCLUSIVAMENTE el Instituto de Salud Pública (ISP); nunca rotular con un test rápido local.
- Estrategia actual: TARV universal e inmediata a todo paciente confirmado, sin importar el nivel de CD4.
- Esquema preferente de primera línea en Chile: Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir (TDF/3TC/DTG) en dosis única diaria.
- Dolutegravir es un inhibidor de integrasa con alta barrera genética y rápida supresión viral.
- Indetectable = Intransmisible (I=I): si la carga viral es < 50 copias/mL por 6 meses continuos, el riesgo de transmisión sexual es cero.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral	EUNACOM Julio 2024 · #62 · EUNACOM Julio 2024 · #56 · EUNACOM Diciembre 2024 · #99 · EUNACOM Agosto 2021 · #25
Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	EUNACOM Julio 2024 · #62 · EUNACOM Julio 2024 · #56 · EUNACOM Diciembre 2024 · #99 · EUNACOM Julio 2024 · #57
Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	EUNACOM Diciembre 2025 · #116 · EUNACOM Julio 2025 · #21 · EUNACOM Julio 2024 · #105 · EUNACOM Enero 2023 · #91
Infecciones de Transmisión Sexual	EUNACOM Julio 2025 · #36 · EUNACOM Julio 2025 · #37 · EUNACOM Diciembre 2025 · #52 · EUNACOM Julio 2024 · #2
Infecciones de Transmisión Sexual	EUNACOM Julio 2025 · #36 · EUNACOM Julio 2025 · #37 · EUNACOM Diciembre 2025 · #52 · EUNACOM Enero 2023 · #40

3.1. Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.014 3.01.1.031 2.01.1.012

¿POR QUÉ?

El VIH es una de las áreas más reglamentadas del EUNACOM. Todo médico debe dominar la Ley del SIDA (consentimiento informado, confirmación exclusiva por el ISP), la estrategia Test & Treat universal independiente del recuento de CD4 y el régimen preferente GES de una pastilla al día con inhibidor de integrasa.

1. DIAGNÓSTICO NACIONAL SEGÚN LEY 19.779

Por ley chilena, el test de VIH es **voluntario, confidencial y exige consentimiento informado firmado**. 1.04.1.014 2.01.1.012

Algoritmo en dos etapas: 1) Tamizaje local mediante ELISA de 4ª generación (Ag p24 + Ac) o test rápido; 2) **Confirmación obligatoria por el ISP**: ante resultado reactivo, se envía una segunda muestra venosa al Instituto de Salud Pública (único organismo legalmente facultado). Nunca se comunica positividad sin confirmación del ISP.

2. TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (TARV) GES 2026

Todo caso confirmado ingresa a la **Garantía GES N° 18** con cobertura gratuita integral. 1.04.1.014 2.01.1.012

Estrategia Test & Treat: la TARV se inicia de inmediato a todo paciente confirmado, sin importar los CD4 ni la carga viral. Esquema de 1ª línea coformulado en 1 pastilla al día: **Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Dolutegravir (DTG)**. El dolutegravir ofrece alta barrera genética y rápida supresión viral.

3. ETAPIFICACIÓN Y CONCEPTO I = I

Se clasifica según recuento de CD4 (≥ 500, 200–499, < 200/mm³) y clínica (A: asintomático; B: sintomático no SIDA como muguet; C: SIDA). **Etapa SIDA:** CD4 < 200/mm³ o presencia de patología marcadora (Pneumocystis, Criptococo, TBC extrapulmonar, Sarcoma de Kaposi). 1.04.1.014 2.01.1.012

Indetectable = Intransmisible (I = I): carga viral < 50 copias/mL por > 6 meses anula el riesgo de transmisión sexual.

4. VIH Y EMBARAZO: PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL

Sin intervención, la transmisión madre-hijo del VIH es de 15–40 %; con el programa completo baja a **menos de 2 %**. Pilares: (1) **tamizaje obligatorio** con test de VIH en el primer control prenatal, repetido en el tercer trimestre en mujeres de riesgo; (2) **TARV para toda gestante con VIH, lo antes posible y sin esperar el CD4**, con esquema que incluya dolutegravir (por ejemplo tenofovir + emtricitabina/lamivudina + dolutegravir), con meta de **carga viral indetectable** y control a las 34–36 semanas; (3) vía del parto: **cesárea electiva a las 38 semanas** si la carga viral es > 1.000 copias/mL o desconocida, y zidovudina EV intraparto en ese caso; con carga viral < 1.000 copias/mL se permite el parto vaginal; (4) recién nacido con **zidovudina oral por 4 semanas** (profilaxis ampliada si el riesgo es alto) y diagnóstico con PCR; (5) **suspender la lactancia materna** y entregar fórmula láctea (cubierta por GES). Se deriva a policlínico de VIH y obstetricia de alto riesgo, y se estudian otras ITS (sífilis, hepatitis B). 3.01.1.031

FIGURA 3.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE VIH EN CHILE



TABLA 3.1 · ETAPIFICACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO DEL VIH (CDC)

1.04.1.014, 3.01.1.031, 2.01.1.012

RECUENTO LINFOCITOS CD4+	CATEGORÍA A (ASINTOMÁTICO / SRA)	CATEGORÍA B (SINTOMÁTICO NO A NI C)	CATEGORÍA C (CONDICIÓN SIDA)
≥ 500 células/mm³ (≥ 26%)	Etapa A1	Etapa B1	Etapa C1 (SIDA)
200 a 499 células/mm³ (14–25%)	Etapa A2	Etapa B2	Etapa C2 (SIDA)
< 200 células/mm³ (< 14%)	Etapa A3 (SIDA por CD4)	Etapa B3 (SIDA por CD4)	Etapa C3 (SIDA clínico y lab)
Enfermedades Prototípicas	Linfadenopatía persistente, SRA	Candidiasis oral (muguet), leucoplasia oral vellosa, herpes zóster recurrente	Pneumocystis, Toxoplasmosis cerebral, Criptococo, TBC extrapulmonar, Sarcoma Kaposi

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.1

Hombre de 29 años consulta en APS por astenia y candidiasis orofaríngea (muguet) recurrente. Se realiza test rápido visual para VIH en el CESFAM que resulta reactivo. El paciente se angustia severamente y pregunta si ya tiene SIDA y si debe informar a su familia.

Conducta oficial. Un test rápido o ELISA reactivo en APS es solo un resultado preliminar. Por la Ley del SIDA chilena, el paciente NO tiene confirmación diagnóstica aún. La conducta médica inmediata consiste en contener al paciente, explicar que el test es presuntivo, tomar una segunda muestra de sangre venosa y remitirla al Instituto de Salud Pública (ISP) para confirmación oficial. Una vez confirmado por el ISP, se activa la Garantía GES N° 18, se solicitan CD4 y Carga Viral basales y se inicia de inmediato el tratamiento antirretroviral triconjugado con Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Ley del SIDA: test de VIH es voluntario, confidencial y requiere consentimiento informado firmado.
- El diagnóstico definitivo en Chile lo realiza EXCLUSIVAMENTE el Instituto de Salud Pública (ISP); nunca rotular con un test rápido local.
- Estrategia actual: TARV universal e inmediata a todo paciente confirmado, sin importar el nivel de CD4.
- Esquema preferente de primera línea en Chile: Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir (TDF/3TC/DTG) en dosis única diaria.
- Dolutegravir es un inhibidor de integrasa con alta barrera genética y rápida supresión viral.
- Indetectable = Intransmisible (I=I): si la carga viral es < 50 copias/mL por 6 meses continuos, el riesgo de transmisión sexual es cero.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Infección por VIH

1. Un joven de 24 años se realiza un test rápido visual para VIH en una campaña universitaria, el cual resulta reactivo. ¿Cuál es la conducta médica normativa que se debe seguir en el sistema de salud chileno?

A) Informar al paciente que tiene infección por VIH confirmada e iniciar de inmediato el tratamiento con antirretrovirales
B) Tomar una segunda muestra de sangre venosa y derivarla al Instituto de Salud Pública (ISP) para confirmación
C) Solicitar carga viral para VIH y dar por confirmado el diagnóstico si esta supera las 1.000 copias/mL
D) Repetir el test rápido visual en 3 meses para descartar el período de ventana
E) Derivar a infectología con diagnóstico de SIDA etapa C3

Banco de Preguntas Oficial · Infección por VIH

2. ¿Cuál es el esquema antirretroviral de primera línea preferente para el inicio de tratamiento en pacientes adultos con diagnóstico confirmado de infección por VIH en Chile según la guía ministerial vigente?

A) Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina
B) Tenofovir disoproxilo + Lamivudina + Dolutegravir
C) Abacavir + Emtricitabina + Lopinavir/Ritonavir
D) Efavirenz + Zidovudina + Atazanavir
E) Tenofovir alafenamida en monoterapia

Más preguntas online de Infección por VIH →

3.2. Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 | 1.04.1.014 | 1.05.1.029 | 1.04.3.006 | 1.04.1.005 | 1.04.4.004 | 1.06.1.012 | 1.08.3.010 | 1.04.4.001

¿POR QUÉ?

Las infecciones oportunistas definen la etapa SIDA y son la principal causa de muerte en personas con diagnóstico tardío de VIH. En el EUNACOM se evalúan los puntos de corte exactos de linfocitos CD4 para iniciar profilaxis primaria (Cotrimoxazol con CD4 < 200 y Azitromicina con CD4 < 50), el manejo de la neumonía por Pneumocystis jirovecii (con uso de corticoides) y el diagnóstico diferencial de masas cerebrales.

1. NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII (CD4 < 200/MM³)

1.04.1.014 1.05.1.029

Es la infección oportunista pulmonar definitoria de SIDA más frecuente. *P. jirovecii* es un hongo atípico que coloniza los alvéolos, produciendo un exudado espumoso intraalveolar rico en fibrina que bloquea el intercambio gaseoso. **(ver Imagen 3.2A)**

Clínica: disnea progresiva subaguda de semanas de evolución, tos seca no productiva, fiebre y desaturación marcada durante el ejercicio (desaturación al caminar). Radiografía de tórax: **infiltrados intersticiales bilaterales perihiliares difusos en "alas de mariposa"** con LDH sérica marcadamente elevada (> 400-500 UI/L).

Tratamiento: Cotrimoxazol (Trimetoprim-Sulfametoxazol) EV en dosis altas (TMP 15-20 mg/kg/día dividido cada 6-8 h) por 21 días.

Regla de oro con Corticoides: si presenta insuficiencia respiratoria moderada a severa definida por **PaO2 < 70 mmHg en gases arteriales o Gradiente Alvéolo-Arterial (A-a) ≥ 35 mmHg**, se debe administrar **Prednisona oral o Metilprednisolona EV antes o junto con el Cotrimoxazol** (reduce la inflamación alveolar masiva causada por la lisis del hongo y disminuye la mortalidad a la mitad).

2. TOXOPLASMOSIS CEREBRAL VS LINFOMA PRIMARIO DEL SNC (CD4 < 100/MM³)

1.04.1.014

Toxoplasma gondii se reactiva a partir de quistes tisulares latentes cuando los CD4 caen bajo 100/mm³. Es la **causa número uno de masa cerebral focal con déficit neurológico** en pacientes con VIH.

Clínica e imágenes: cefalea, confusión, fiebre y signos de focalidad neurológica motora. La TAC o RMN con contraste revela **múltiples lesiones nodulares redondeadas con realce periférico en anillo**, con marcada predilección por los **ganglios basales** y la unión córtico-subcortical, asociadas a intenso edema perilesional.

Conducta diagnóstica: ante paciente con VIH avanzado y lesiones en anillo en neuroimagen, se asume Toxoplasmosis y se inicia **prueba terapéutica empírica por 10 a 14 días con Sulfadiazina + Pirimetamina (o Cotrimoxazol EV a dosis alta) + Ácido Folínico**. Si a los 14 días las lesiones reducen de tamaño, se confirma el diagnóstico. Si no hay mejoría clínica o radiológica, la sospecha pasa a **Linfoma Primario del SNC** (asociado a Virus Epstein-Barr) y se indica biopsia cerebral estereotáxica. **(ver Imagen 3.2B)**

3. MENINGITIS POR CRIPTOCOCO Y PROFILAXIS PRIMARIA POR UMBRALES CD4

1.04.1.014 1.04.4.004

Meningitis Criptococócica (*Cryptococcus neoformans* - CD4 < 100/mm³): levadura encapsulada inhalada que disemina al SNC. Cursa con cefalea insidiosa progresiva, náuseas y fiebre, a menudo con escasa o nula rigidez de nuca. Diagnóstico: LCR con presión de apertura muy elevada (> 30 cm H2O), tinción con **Tinta China (visualiza levaduras con halo refringente por la cápsula)** y detección de **Antígeno Criptococócico (CrAg)** en sangre y LCR. Tratamiento: inducción con **Anfotericina B liposomal + Flucitosina por 2 semanas**, seguido de consolidación y mantención prolongada con Fluconazol oral.

4. CANDIDIASIS, DIARREA, ANTIGENEMIA DE CMV, CRIPTOCOCO Y PREVENCIÓN EN EL INMUNOSUPRIMIDO

1.04.1.005

Candidiasis oral y esofágica: la oral (muguet) son placas blanquecinas desprendibles sobre mucosa eritematosa, frecuentes con CD4 < 300; se trata con **nistatina** en suspensión o **fluconazol 100–200 mg/día por 7–14 días**. La esofágica (odinofagia, disfagia retroesternal; define etapa SIDA) se trata con **fluconazol 200–400 mg/día por 14–21 días**; si no responde se hace endoscopía con biopsia para descartar *Candida* resistente, CMV o herpes. Se deriva a infectología para el control del VIH y el inicio o ajuste de TARV. **(ver Imagen 3.2C)**

1.06.1.012

Diarrea en el inmunosuprimido: además de los agentes habituales (*Salmonella*, *Campylobacter*, *Giardia*, *C. difficile*) deben buscarse ***Cryptosporidium*, *Cystoisospora* y microsporidios** (CD4 < 100–200, diarrea acuosa crónica), **CMV** (colitis, CD4 < 50, dolor y hematoquezia) y complejo *Mycobacterium avium*. Estudio: coprocultivo, parasitológico seriado con tinción de Ziehl-Neelsen modificada, toxina de *C. difficile* y, si persiste, colonoscopía con biopsia. Manejo: rehidratación, tratamiento etiológico (cotrimoxazol para *Cystoisospora*, nitazoxanida para *Cryptosporidium*, ganciclovir para CMV) y, sobre todo, **TARV**, que restaura la inmunidad y es el tratamiento de la criptosporidiosis. Se deriva.

1.04.4.001

Antigenemia de CMV (nivel «interpreta y emplea»): detecta la proteína **pp65** en leucocitos de sangre periférica y se informa como número de células positivas por 200.000 leucocitos. Indica **replicación viral activa** y se emplea para monitorizar a trasplantados y a pacientes con VIH y CD4 < 50 y para guiar la **terapia anticipada** (iniciar ganciclovir antes de que aparezca la enfermedad); la PCR cuantitativa para CMV cumple la misma función. Tiene tres limitaciones: **infección no es enfermedad** (una antigenemia positiva no basta para diagnosticar retinitis, colitis o neumonitis, que requieren clínica, fondo de ojo o biopsia con «células en ojo de búho»); la IgG positiva solo indica exposición previa; y es poco confiable en neutropenia. El tratamiento es ganciclovir 5 mg/kg cada 12 h EV (valganciclovir oral en enfermedad leve), 14–21 días.

1.04.4.004

Interpretación del antígeno de *Cryptococcus* y la tinta china: el **antígeno criptocócico** (látex o inmunocromatografía) en LCR o suero tiene sensibilidad > 95 %; la **tinta china** muestra levaduras encapsuladas con halo claro, pero es menos sensible (70–90 % en VIH) y un resultado negativo no descarta. Un antígeno **sérico positivo** en un paciente con CD4 < 100 indica criptococosis diseminada y obliga a una **punción lumbar** aunque no haya síntomas neurológicos; en el LCR se mide la presión de apertura (> 25 cmH_2O requiere punciones evacuadoras repetidas) y se siembra en agar Sabouraud para confirmar. El título del antígeno sigue la carga fúngica, pero no se usa para decidir suspender el tratamiento.

1.04.3.006

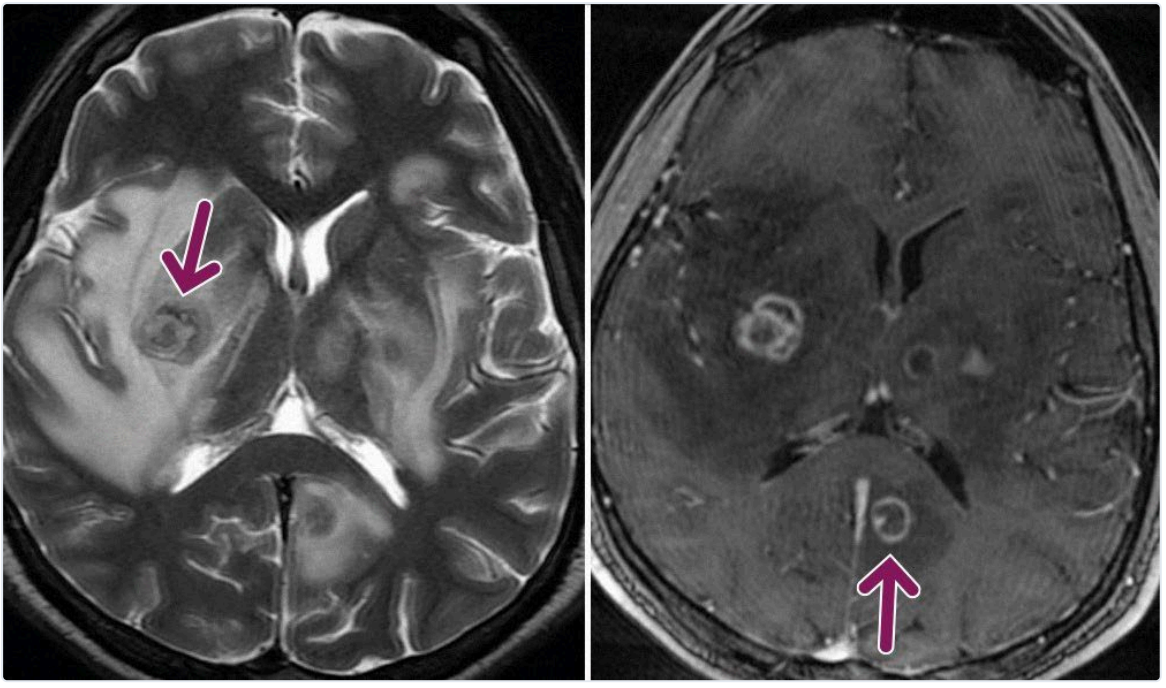
Prevención de infecciones oportunistas en VIH: cotrimoxazol 160/800 mg al día cuando el CD4 es < 200/mm³ (o hay candidiasis oral), que previene *Pneumocystis* y, con IgG positiva para *Toxoplasma*, la toxoplasmosis cerebral (CD4 < 100); se suspende con CD4 > 200 por más de 3 meses con TARV. Con PPD ≥ 5 mm o contacto bacilífero y TBC activa descartada: **isoniacida por 6–9 meses**. La profilaxis para *M. avium* (azitromicina 1.200 mg semanal, CD4 < 50) ya no se recomienda si se inicia TARV. Además: TARV precoz, vacunas inactivadas (neumococo, influenza, hepatitis B, VPH), evitar vivas con CD4 < 200 y medidas higiénicas.

1.08.3.010

Prevención de infecciones en inmunosuprimidos en general (neutropenia, trasplante, quimioterapia, corticoides, asplenia): higiene de manos del paciente, cuidadores y equipo; evitar contacto con enfermos y obras de construcción (esporas de *Aspergillus*); alimentos bien cocidos y lácteos pasteurizados (listeria), agua segura; precaución con mascotas (gatos y toxoplasma, reptiles y *Salmonella*); control dental; **vacunas inactivadas** y vacunación de los contactos; evitar vacunas vivas en inmunosupresión grave; profilaxis farmacológica según el riesgo (cotrimoxazol, aciclovir en trasplante, antifúngicos en leucemias) y aislamiento protector en neutropenia profunda.



A. SARCOMA DE KAPOSI



B. TOXOPLASMOSIS CEREBRAL



C. CANDIDIASIS ORAL

Imagen 3.2

TABLA 3.2 · PROFILAXIS PRIMARIA DE INFECCIONES OPORTUNISTAS EN VIH SEGÚN UMBRAL DE CD4

1.04.1.014, 1.05.1.029, 1.04.3.006, 1.04.1.005, 1.04.4.004, 1.06.1.012, 1.08.3.010, 1.04.4.001

NIVEL DE LINFOCITOS CD4+	PATÓGENO BLANCO	FÁRMACO PROFILÁCTICO DE ELECCIÓN	CRITERIO DE SUSPENSIÓN
CD4 < 200 células/mm³ (o < 14%)	Pneumocystis jirovecii	Cotrimoxazol fuerte (TMP/SMX 160/800 mg) 1 comp/día	CD4 > 200 por ≥ 3 meses continuos con TARV
CD4 < 100 células/mm³ + IgG (+)	Toxoplasma gondii	Cotrimoxazol fuerte 1 comp/día (misma dosis que PCP)	CD4 > 200 por ≥ 3 meses continuos con TARV
CD4 < 50 células/mm³	Mycobacterium avium complex (MAC)	Azitromicina 1.200 mg oral una vez por semana	CD4 > 100 por ≥ 3 meses continuos con TARV
Cualquier CD4 con PPD ≥ 5 mm	Mycobacterium tuberculosis	Isoniazida 300 mg/día + Piridoxina por 9 meses	Al completar los 9 meses de quimioprofilaxis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.2

Hombre de 34 años con infección por VIH diagnosticada hace 4 años con abandono de TARV ingresa por tos seca de 3 semanas, disnea progresiva que actualmente se presenta a mínimos esfuerzos y fiebre vespertina. Al examen: T° 38.2 °C, FC 110 lpm, FR 28 rpm, saturación de oxígeno 86% al aire ambiente. Radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales de predominio perihiliar y basal en vidrio esmerilado. Gases arteriales con FiO2 21%: pH 7.46, PaO2 54 mmHg, PaCO2 31 mmHg, gradiente alvéolo-arterial 52 mmHg. Recuento de CD4: 68 células/mm³.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a una Neumonía por Pneumocystis jirovecii (PCP) grave en paciente con SIDA (CD4 < 200). La presencia de insuficiencia respiratoria severa con PaO2 < 70 mmHg (54 mmHg) y gradiente alvéolo-arterial ≥ 35 mmHg (52 mmHg) constituye una indicación formal e inmediata de asociar CORTICOIDES SISTÉMICOS (Prednisona oral 40 mg cada 12 h o Metilprednisolona EV) iniciando 15-30 minutos antes o junto con el Cotrimoxazol EV a dosis plenas (TMP 15-20 mg/kg/día). Omitir los corticoides aumenta drásticamente la mortalidad por el deterioro ventilatorio agudo secundario a la lisis masiva del microorganismo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Pneumocystis jirovecii: tos seca, disnea subaguda, infiltrado intersticial bilateral en alas de mariposa y LDH elevada.
- Tratamiento de Pneumocystis: Cotrimoxazol a dosis altas por 21 días.
- CORTICOIDES en Pneumocystis: obligatorios si PaO2 < 70 mmHg o Gradiente A-a ≥ 35 mmHg.
- Masa cerebral con realce en anillo en paciente VIH: Toxoplasmosis cerebral (ganglios basales); iniciar prueba terapéutica con Sulfadiazina + Pirimetamina.
- Meningitis por Cryptococcus neoformans: Tinta China (+) en LCR; tratamiento con Anfotericina B + Flucitosina.
- Profilaxis con Cotrimoxazol 1 comp/día: obligatoria en todo paciente con CD4 < 200/mm³ (protege contra Pneumocystis y Toxoplasma).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Oportunistas

1. Un paciente de 38 años con VIH y recuento de CD4 de 85 células/mm³ es diagnosticado de neumonía por Pneumocystis jirovecii. Los gases arteriales respirando aire ambiental muestran una PaO2 de 58 mmHg. Además del tratamiento antimicrobiano con Cotrimoxazol a dosis altas, ¿cuál de las siguientes medidas farmacológicas reduce la mortalidad?

A) Iniciar infusión de N-acetilcisteína como antioxidante alveolar
B) Administrar corticoides sistémicos (Prednisona) antes o junto con el antibiótico
C) Indicar tratamiento concomitante con Azitromicina para cobertura de bacterias atípicas
D) Asociar Ganciclovir por probable coinfección con Citomegalovirus
E) Iniciar diuréticos de asa para reducir el edema alveolar

Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Oportunistas

2. Hombre de 31 años con VIH y abandono de terapia presenta cefalea holocraneana y hemiparesia faciobraquial derecha de 5 días de evolución. Su recuento de CD4 es de 45 células/mm³. La RMN cerebral con contraste muestra tres lesiones nodulares con captación en anillo y edema circundante localizadas en el tálamo y ganglios basales izquierdos. ¿Cuál es la conducta médica inicial más adecuada?

A) Indicar biopsia estereotáxica urgente de la lesión talámica
B) Iniciar radioterapia holocraneana por sospecha de linfoma primario del SNC
C) Iniciar tratamiento empírico para Toxoplasmosis con Sulfadiazina + Pirimetamina y evaluar respuesta en 10-14 días
D) Administrar anfotericina B liposomal en monoterapia EV
E) Indicar tratamiento antituberculoso con 4 fármacos por 12 meses

Más preguntas online de Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA →

3.3. Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.028 | 1.05.1.036 | 1.05.1.013 | 1.05.1.037 | 4.03.1.016

¿POR QUÉ?

La Tuberculosis (TBC) es una de las prioridades sanitarias de Chile. Aunque la forma pulmonar es la más contagiosa, el EUNACOM evalúa exhaustivamente el diagnóstico de las formas extrapulmonares (pleural con ADA, ganglionar, meníngea y renal), la interpretación del test molecular GeneXpert y la toxicidad de los cuatro fármacos de primera línea.

1. PATOGENIA Y FORMAS EXTRAPULMONARES FRECUENTES

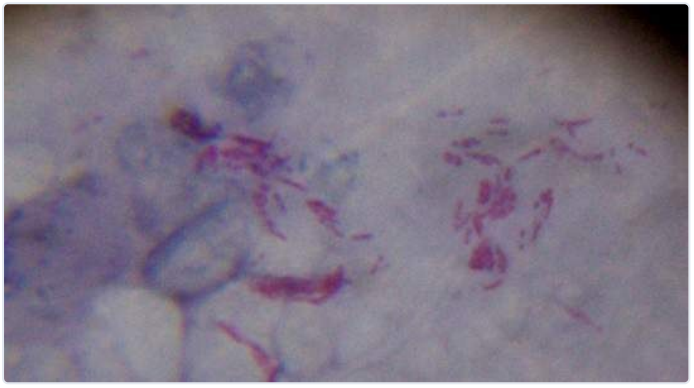
Mycobacterium tuberculosis es un bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR) aerobio estricto. Tras la infección primaria, los bacilos pueden diseminar por vía linfohematógena y permanecer latentes durante décadas. **(ver Imagen 3.3A)** 1.05.1.036

Las formas extrapulmonares representan el 20-25% de los casos en inmunocompetentes y más del 50% en personas con VIH: 1.04.1.028

- **Pleuresía tuberculosa:** derrame pleural exudativo unilateral, típicamente con recuento linfocítico > 80% y **Adenosina Deaminasa (ADA) marcadamente elevada (> 40 UI/L)**. El ADA > 40 en contexto clínico compatible tiene valor diagnóstico confirmativo. 1.04.1.028 1.05.1.013
- **Tuberculosis ganglionar (Escrófula):** localización extrapulmonar más frecuente. Afecta típicamente a ganglios cervicales anteriores (supraclaviculares/yugulares), formando masas indoloras frías que coalescen y pueden fistulizar a la piel drenando material caseoso.
- **Meningitis tuberculosa:** presentación subaguda en la base del encéfalo, provocando parálisis de pares craneanos (III y VI) y citoquímico de LCR con hipoglucorraquia severa, hiperproteinorraquia muy alta (> 200-500 mg/dL) y pleocitosis linfocítica.
- **Mal de Pott (Espondilodiscitis TBC):** compromiso de la columna torácica o lumbar con destrucción del disco intervertebral y cuerpos vertebrales adyacentes, provocando cifosis angular y compresión medular. **(ver Imagen 3.3B y C)**

2. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO Y MOLECULAR (GENEXPERT)

- **Baciloscopía (Tinción de Ziehl-Neelsen o Fluorescencia con Auramina):** método tradicional para detectar BAAR. Rápido y económico, pero requiere > 5.000 bacilos/mL de muestra. 1.05.1.036
- **Cultivo en medio Lowenstein-Jensen (sólido) o MGIT (líquido):** sigue siendo el gold standard diagnóstico y permite realizar antibiograma de susceptibilidad.
- **GeneXpert MTB/RIF (PCR en tiempo real automatizada):** es la técnica molecular de elección en la Norma Técnica chilena. Detecta el ADN del complejo *M. tuberculosis* y simultáneamente **determina la mutación del gen rpoB que confiere resistencia a Rifampicina** en menos de 2 horas. Se indica como prueba inicial en sospecha de TBC en niños, personas con VIH, contactos de casos resistentes y personal de salud.



Baciloscopía con tinción de Ziehl-Neelsen

3. ESQUEMA TERAPÉUTICO NACIONAL Y TOXICIDADES FARMACOLÓGICAS

El tratamiento del caso nuevo pan-sensible en Chile consta del esquema diario directamente observado (DOTS): 1.05.1.036

- **Fase Diaria Inicial (2 meses): 4 fármacos (2 RHZE):** Rifampicina (R) + Isoniazida (H) + Pirazinamida (Z) + Etambutol (E) por 50 dosis (lunes a viernes).
- **Fase de Continuación (4 meses): 2 fármacos (4 RH):** Rifampicina + Isoniazida por 80 dosis.

Toxicidades clásicas de memoria EUNACOM:

- **Isoniazida (H): hepatotoxicidad** y **neuropatía periférica** por depleción de piridoxina (se previene coadministrando Vitamina B6 25-50 mg/día).
- **Rifampicina (R):** tinción anaranjada/rojiza de orina y lágrimas (benigna), hepatitis colestásica e **inducción potente del citocromo P450** (reduce niveles de anticonceptivos, warfarina, antirretrovirales).
- **Pirazinamida (Z):** fármaco más hepatotóxico del esquema e **hiperuricemia** (puede gatillar crisis de gota).
- **Etambutol (E): neuritis óptica retrobulbar** dosis-dependiente (pérdida de la agudeza visual y de la discriminación de colores verde-rojo; contraindicado en niños pequeños que no pueden colaborar con el examen oftalmológico).

4. FRACASO DE TRATAMIENTO, TBC MULTIRRESISTENTE Y TBC GENITOURINARIA

Fracaso del tratamiento de la TBC: persistencia de baciloscopía o cultivo positivo a partir del 5.º mes de un esquema bien tomado (o reaparición posterior). La causa más frecuente es la **mala adherencia**; también resistencia, malabsorción, errores de dosis, VIH y reinfección. Conducta: confirmar adherencia, solicitar **cultivo con pruebas de sensibilidad y GeneXpert** y **derivar al equipo de TBC**; nunca agregar un solo fármaco a un esquema que falla. La **TBC multirresistente** (resistencia a isoniacida y rifampicina) se sospecha en retratamientos, contactos de casos MDR, VIH y migrantes de zonas endémicas; se trata en centro especializado con esquemas de 6 meses con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino o regímenes largos individualizados, siempre con tratamiento directamente observado. 1.05.1.037

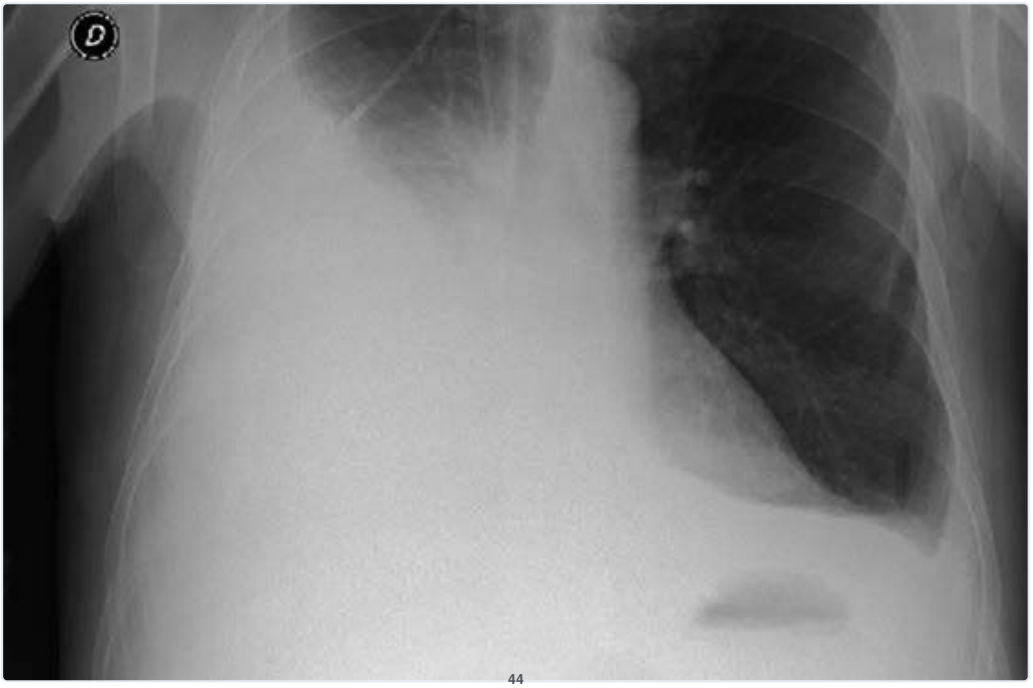
TBC genitourinaria: es una forma extrapulmonar por reactivación, años después de la primoinfección. En el riñón da **piuria ácida con urocultivo corriente negativo** («piuria estéril»), hematuria microscópica, disuria y polaquiuria crónicas y dolor lumbar; evoluciona a estenosis ureteral y vejiga contraída. En el varón compromete epidídimo (masa indurada con fístula escrotal) y próstata; en la mujer, las trompas (infertilidad). Diagnóstico: **cultivo de Koch en orina matinal de 3 días seguidos**, PCR, y urografía/UroTAC (calcificaciones, estenosis, «riñón en masilla»). Se trata como el resto de las TBC extrapulmonares con el esquema estándar de 6 meses; se deriva para manejo urológico de las complicaciones. 4.03.1.016



A. MAL DE POTT



B. ESCRÓFULA



C. PLEURESÍA: DERRAME UNILATERAL

Imagen 3.3

TABLA 3.3 · FARMACOLOGÍA ANTITUBERCULOSA DE PRIMERA LÍNEA: MECANISMOS Y EFECTOS ADVERSOS 1.04.1.028, 1.05.1.036, 1.05.1.013, 1.05.1.037, 4.03.1.016

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	EFECTO ADVERSO PRINCIPAL	MANEJO / PREVENCIÓN
Isoniazida (H)	Inhibe síntesis de ácido micólico	Neuropatía periférica y hepatitis	Coadministrar Piridoxina (Vitamina B6)
Rifampicina (R)	Inhibe ARN polimerasa bacteriana	Secreciones naranjas e inducción CYP450	Educar al paciente sobre orina naranja
Pirazinamida (Z)	Disrumpe potencial de membrana	Hepatotoxicidad severa e hiperuricemia	Monitorizar función hepática y ácido úrico
Etambutol (E)	Inhibe arabinosil transferasa	Neuritis óptica (discromatopsia rojo-verde)	Control de agudeza visual; suspender de inmediato

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.3

Hombre de 48 años en tratamiento antituberculoso hace 5 semanas con esquema 2RHZE consulta por visión borrosa bilateral y dificultad para distinguir las luces del semáforo. Al examen oftalmológico se constata agudeza visual 20/60 en ambos ojos y alteración marcada en el test de Ishihara para los colores verde y rojo. El fondo de ojo es normal.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a una Neuritis Óptica Retrobulbar por Etambutol, el efecto adverso clásico y más temido de este fármaco. El etambutol inhibe la arabinosil-transferasa afectando la vaina de mielina del nervio óptico. La conducta médica inmediata e ineludible es la SUSPENSIÓN INMEDIATA Y DEFINITIVA del Etambutol. Si se suspende de forma precoz, la alteración visual suele ser reversible en semanas a meses; de continuar el fármaco, la ceguera puede volverse permanente.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Pleuritis TBC: derrame pleural exudado linfocítico con ADA > 40 UI/L (valor diagnóstico confirmatorio).
- GeneXpert: PCR en tiempo real que confirma M. tuberculosis y detecta resistencia a Rifampicina en < 2 horas.
- Esquema primario estándar en Chile: 2 meses de 4 fármacos (RHZE) seguidos de 4 meses de 2 fármacos (RH).
- Isoniazida causa neuropatía periférica por déficit de vitamina B6; se previene con Piridoxina oral.
- Etambutol causa neuritis óptica retrobulbar con pérdida de la visión de colores verde-rojo; exige suspensión inmediata.
- Rifampicina tiñe secreciones corporales de color anaranjado y es un potente inductor de enzimas microsomales hepáticas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Tuberculosis

1. Un paciente de 35 años consulta por dolor torácico pleurítico y disnea. La toracocentesis diagnóstica obtiene un líquido pleural de aspecto cetrino con recuento de 2.400 leucocitos/mm³, 88% mononucleares, glucosa 48 mg/dL, proteínas 4.8 g/dL y nivel de Adenosina Deaminasa (ADA) de 54 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Empiema paraneumónico complicado por Streptococcus pneumoniae
B) Pleuritis tuberculosa
C) Derrame pleural por insuficiencia cardíaca descompensada
D) Mesotelioma pleural maligno
E) Lupus eritematoso sistémico con serositis

Banco de Preguntas Oficial · Tuberculosis

2. Un paciente de 28 años que inició tratamiento antituberculoso hace 3 semanas consulta alarmado porque su orina y saliva se han tornado de color anaranjado intenso. No refiere molestias urinarias, fiebre ni prurito. Las pruebas hepáticas son normales. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Suspender de inmediato todo el esquema antituberculoso por sospecha de falla hepática
B) Tranquilizar al paciente, explicar que es un efecto farmacológico benigno de la rifampicina y continuar el esquema
C) Reemplazar la rifampicina por levofloxacino
D) Solicitar sedimento de orina y urocultivo por sospecha de hematuria macroscópica
E) Reducir la dosis de isoniazida a la mitad

Más preguntas online de Tuberculosis →

3.4. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.023 | 1.04.1.010 | 1.04.4.016 | 6.01.1.008 | 6.01.2.012 | 6.01.4.007

¿POR QUÉ?

La sífilis presenta un incremento epidémico continuo en Chile. En el EUNACOM se evalúa de manera estricta la interpretación serológica (diferencia entre pruebas no treponémicas cuantitativas y pruebas treponémicas cicatriciales), los esquemas exactos de Penicilina Benzatina según el tiempo de evolución y la conducta obligatoria en la embarazada.

1. ETAPAS CLÍNICAS DE LA SÍFILIS

1.04.1.010 | 6.01.1.008

Treponema pallidum se transmite por contacto sexual o vía transplacentaria.

1.04.1.023 | 1.04.1.010 | 6.01.1.008

Primaria: chancro sifilítico (úlcera genital **única, indurada e INDOLORA**, fondo limpio) y adenopatías duras indoloras; cura en 3–6 semanas. **Secundaria: roseola sifilítica** (exantema maculopapular con **compromiso palmo-plantar**), **condilomas planos** perianales y micropoliadenopatías. **Latente:** asintomática (precoz < 1 año vs tardía > 1 año). **Terciaria:** gomas, aortitis y **neurosífilis**. **(ver Imagen 3.4A, B y C)**

2. INTERPRETACIÓN SEROLÓGICA: VDRL VS TREPONÉMICAS

1.04.4.016 | 6.01.4.007

• **Pruebas No Treponémicas (VDRL, RPR):** cuantitativas (diluciones 1:2, 1:4, 1:16...). Evalúan **actividad y respuesta al tratamiento** (curación: caída de ≥ 4 veces o 2 diluciones a los 6–12 meses).

• **Pruebas Treponémicas (FTA-ABS, MHA-TP, ELISA IgG):** cualitativas. Sirven para **confirmar el diagnóstico**. Permanecen positivas de por vida (**cicatriz serológica**) en el 90 %; NO evalúan respuesta ni reinfección.

3. TRATAMIENTO ESTÁNDAR CON PENICILINA BENZATINA

1.04.1.023 | 1.04.1.010 | 6.01.1.008

• **Sífilis Precoz (< 1 año): Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM dosis única**.

• **Sífilis Tardía (> 1 año o desconocida): Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM semanal por 3 semanas consecutivas** (total 7.2 MU).

1.04.1.023

• **Embarazada alérgica a penicilina: desensibilización obligatoria en UCI** y tratamiento con penicilina (la doxiciclina está estrictamente contraindicada). La reacción de Jarisch-Herxheimer es benigna y se maneja con paracetamol.

4. SÍFILIS CONGÉNITA Y ENFOQUE SINDRÓMICO DE LAS ITS

6.01.2.012 | 1.04.1.023

Sífilis congénita: transmisión transplacentaria (riesgo máximo con sífilis materna reciente y no tratada). El tamizaje con VDRL se hace en el primer control, a las 28 semanas y al parto (GES). **Precoz** (< 2 años): hepatoesplenomegalia, rinitis sanguinolenta («snuffles»), lesiones ampollares palmoplantares (pénfigo sifilítico), condilomas planos, osteocondritis con pseudoparálisis de Parrot, ictericia, anemia y trombocitopenia. **Tardía**: tríada de Hutchinson (dientes de Hutchinson, queratitis intersticial y sordera), nariz en silla de montar, tibias en sable. Un recién nacido de madre con sífilis no tratada, tratada con otro antibiótico o con penicilina menos de 4 semanas antes del parto, o con VDRL ≥ 4 veces el materno, se estudia (VDRL, LCR, Rx de huesos largos) y se trata con **penicilina G sódica EV por 10 días**; se deriva a neonatología. La prevención es tratar a la gestante con penicilina benzatina al menos 30 días antes del parto y a su pareja.



Dientes de Hutchinson en la sífilis congénita tardía

1.04.1.010 | 6.01.1.008

Enfoque sindrómico de las ITS: se actúa por síndrome y no por agente: **úlcera genital** (sífilis, herpes, chancroide, linfogranuloma), **secreción uretral** (gonococo, *Chlamydia*), **flujo vaginal**, **dolor abdominal bajo (EPI)**, **bubón inguinal** y verrugas genitales (véase Tema 3.5). En todo paciente con una ITS se ofrece estudio de VIH, hepatitis B y sífilis, se da consejería y uso de preservativo, se trata y estudia a las parejas de los últimos 60–90 días y se **notifica**. La sífilis facilita la transmisión y adquisición de VIH, y en coinfectados la neurosífilis es más frecuente.



A. CHANCRO



B. SÍFILIS SECUNDARIA



C. CONDILOMAS PLANOS

Imagen 3.4

FIGURA 3.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y SEROLÓGICO DE SÍFILIS

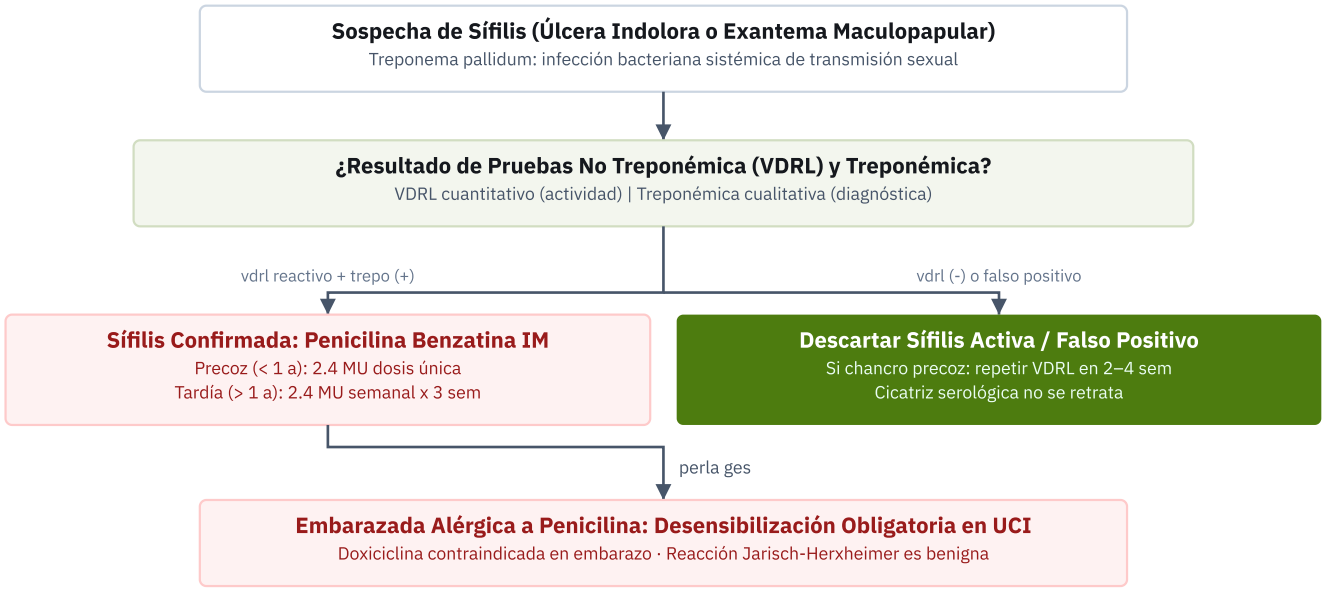


TABLA 3.4 · INTERPRETACIÓN DE ALGORITMOS SEROLÓGICOS DE SÍFILIS

1.04.1.023, 1.04.1.010, 1.04.4.016, 6.01.1.008, 6.01.2.012, 6.01.4.007

PRUEBA NO TREPONÉMICA (VDRL/RPR)	PRUEBA TREPONÉMICA (FTA-ABS/ELISA)	INTERPRETACIÓN CLÍNICA	CONDUCTA RECOMENDADA
Reactivo (ej. 1:16)	Reactiva	Sífilis activa confirmada	Tratar según tiempo de evolución
Reactivo (ej. 1:2)	No Reactiva	Falso positivo biológico	No tratar; causas: autoinmune, embarazo, edad
No Reactivo	Reactiva	Cicatriz serológica o sífilis primaria muy precoz	Si tratado previamente: observar; si no: evaluar
No Reactivo	No Reactiva	Paciente no infectado (o período de ventana)	Repetir en 3 semanas si hay chancro sospechoso

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.4

Hombre de 26 años consulta por lesión ulcerada indolora en el glande de 10 días de evolución. Al examen: úlcera de 1.5 cm de diámetro, bordes regulares sobreelevados, base limpia e indurada al tacto, sin dolor a la palpación, asociada a adenopatía inguinal derecha no dolorosa. El VDRL resulta reactivo en dilución 1:32.

Conducta oficial. El cuadro clínico de úlcera genital única, indurada e indolora con adenopatía regional indolora y VDRL 1:32 es la presentación prototípica de Sífilis Primaria (Chancro duro). Por tratarse de una sífilis precoz (< 1 año de evolución), el tratamiento normativo de primera línea es Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI por vía intramuscular en DOSIS ÚNICA. Además, se debe solicitar serología para VIH y hepatitis B, indicar estudio y tratamiento simultáneo a todos los contactos sexuales de los últimos 90 días, y programar control serológico con VDRL cuantitativo a los 6 y 12 meses.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Chancro sifilítico (primaria): úlcera única, base indurada, fondo limpio e INDOLORA.
- Secundarismo sifilítico: exantema maculopapular con compromiso palmo-plantar y condilomas planos perianales.
- VDRL/RPR es cuantitativo y sirve para evaluar actividad y respuesta al tratamiento (cura = caída de 4 veces los títulos).
- Las pruebas treponémicas (FTA-ABS) quedan positivas de por vida ("cicatriz serológica") y confirman el diagnóstico.
- Sífilis precoz (< 1 año): Penicilina Benzatina 2.4 MU IM en DOSIS ÚNICA.
- Sífilis tardía (> 1 año o desconocida): Penicilina Benzatina 2.4 MU IM semanal por 3 SEMANAS CONSECUTIVAS.
- En embarazada alérgica a penicilina: DESENSIBILIZACIÓN CON PENICILINA obligatoria (doxiciclina contraindicada).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

1. Un hombre de 24 años consulta por un exantema eritematoso difuso en tronco que compromete francamente las palmas de las manos y las plantas de los pies, sin prurito, de 1 semana de evolución. Hace 2 meses recuerda haber tenido una úlcera indolora en el pene que desapareció espontáneamente. El VDRL es reactivo 1:64. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única
B) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM semanal por 3 semanas consecutivas
C) Ceftriaxona 1 g EV diario por 14 días
D) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas oral por 7 días
E) Azitromicina 1 g oral en dosis única

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

2. Una mujer de 26 años con embarazo de 14 semanas presenta un VDRL de tamizaje reactivo 1:16, confirmado mediante FTA-ABS reactivo. La paciente refiere ser alérgica confirmada a la penicilina (presentó shock anafiláctico previo). ¿Cuál es la conducta médica indicada para prevenir la sífilis congénita?

A) Indicar tratamiento con Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días
B) Hospitalizar para desensibilización oral a la penicilina y luego administrar Penicilina Benzatina
C) Administrar Eritromicina oral 500 mg cada 6 horas por 14 días
D) Diferir todo tratamiento antibiótico hasta después del parto para evitar teratogenia
E) Administrar Ceftriaxona 1 g diario intramuscular por 10 días

Más preguntas online de Infecciones de Transmisión Sexual →

3.5. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.010 | 4.01.1.058 | 3.01.3.010 | 1.04.3.003 | 1.04.5.004 | 4.03.3.004

¿POR QUÉ?

El manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual en Atención Primaria es un clásico del EUNACOM. La regla es clara: toda uretritis o cervicitis se trata de entrada con doble cobertura empírica (Neisseria gonorrhoeae + Chlamydia trachomatis) y las úlceras genitales se discriminan entre sífilis, herpes simple y chancroide.

1. SÍNDROME DE DESCARGA URETRAL Y CERVICITIS MUCOPURULENTA

La uretritis se manifiesta por disuria, prurito meatal y secreción uretral. Se divide en dos grupos etiológicos mayores: 1.04.1.010

• **Uretritis Gonocócica (UG - *Neisseria gonorrhoeae*):** secreción típicamente **abundante, espesa, purulenta y amarillo-verdosa**, con incubación corta (2 a 7 días). El frotis directo con tinción de Gram revela **diplococos Gram negativos intracelulares en polimorfonucleares** (sensibilidad > 95% en varones). 1.04.1.010 1.04.5.004

• **Uretritis No Gonocócica (UNG - *Chlamydia trachomatis* serovares D-K en 40-50%, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis*):** secreción más escasa, serosa o mucoide, a menudo matinal ("gota matinal"), con incubación más prolongada (1 a 3 semanas). El Gram solo muestra PMN sin bacterias visibles.



Uretritis gonocócica

Regla de oro terapéutica del manejo sindrómico: debido a que la coinfección gonococo-clamidia ocurre en el 20-40% de los casos, **TODA URETRITIS SE TRATA CON DOBLE COBERTURA OBLIGATORIA:** 1.04.1.010

• **Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única** (cobertura para *N. gonorrhoeae*) + **Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral por 7 días** (o Azitromicina 1 g oral dosis única) para cubrir *C. trachomatis*.

• Tratamiento simultáneo a todas las parejas sexuales recientes y abstinencia sexual por 7 días.

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ÚLCERAS GENITALES

El enfrentamiento de las úlceras genitales es un pilar evaluativo en el EUNACOM: 1.04.1.010

• **Herpes Genital (VHS-2 > VHS-1):** es la causa más frecuente de úlcera genital. Cursa con **vesículas agrupadas en racimo sobre base eritematosa que se rompen formando úlceras superficiales dolorosas**. Típicamente recurrente, precedida de pródromos de ardor o parestesias. Tratamiento: **Aciclovir oral 400 mg cada 8 horas por 7 a 10 días** (acorta los días de síntomas y diseminación viral; no erradica el virus del ganglio sensitivo sacro).

• **Chancro duro (Sífilis primaria):** úlcera **única, base indurada, fondo limpio e INDOLORA**, adenopatía indolora.

• **Chancro blando o Chancroide (*Haemophilus ducreyi*):** úlcera **múltiple, fondo sucio con exudado necrótico purulento, bordes deshilachados e INTENSAMENTE DOLOROSA**, asociada a adenopatía inguinal dolorosa inflamatoria con tendencia a fistulizar (bubón). Tratamiento: Azitromicina 1 g oral dosis única o Ceftriaxona 250 mg IM. **(ver Imagen 3.5A, B y C)**

3. VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH): VERRUGAS VS ONCOGÉNESIS

• **VPH de bajo riesgo oncogénico (genotipos 6 y 11):** causan los **Condilomas acuminados** (verrugas anogenitales exofíticas "en cresta de gallo" en glande, vulva o perianal). Tratamiento: Podofilotoxina tópica al 0.5%, Imiquimod al 5% o crioterapia. 1.04.1.010 4.01.1.058

• **VPH de alto riesgo oncogénico (genotipos 16 y 18 causan el 70% del cáncer cervical):** provocan displasia intraepitelial asintomática. Tamizaje GES en Chile: citología cervical (PAP) cada 3 años entre los 25 y 64 años, o test molecular de ADN-VPH cada 5 años.

4. PREVENCIÓN DE LAS ITS Y TINCIÓN DE GRAM URETRAL

Prevención de las ITS: educación sexual, postergar el inicio de la vida sexual, reducir parejas y uso **correcto y consistente del preservativo** (muy eficaz contra VIH, gonococo y *Chlamydia*; protege menos contra herpes, VPH y sífilis, que se transmiten por piel). Vacunas: **VPH** (niñas y niños en 4.º y 5.º básico) y hepatitis B. Tamizaje periódico (clamidia en mujeres sexualmente activas < 25 años, VIH, sífilis), consejería, **tratamiento oportuno y de las parejas** con abstinencia hasta 7 días después de completarlo, profilaxis preexposición (PrEP) en alto riesgo y profilaxis postexposición. Factores de riesgo: inicio precoz, múltiples parejas, no uso de preservativo, ITS previa, pareja con ITS, hombres que tienen sexo con hombres, trabajo sexual, alcohol y drogas, y abuso sexual. 3.01.3.010 1.04.3.003 4.03.3.004

Tinción de Gram uretral (nivel «realizar»): se toma la secreción con tórula o asa, de preferencia la **primera gota matinal** o al menos 2 horas sin orinar; se rueda (no se frota) en un portaobjetos, se seca al aire y se fija con calor. Tinción: cristal violeta (1 min) → lugol (1 min) → decolorante alcohol-acetona (5–10 s) → safranina (30–60 s) → lavar y secar; se observa a 1.000×. La uretritis se confirma con **≥ 5 leucocitos polimorfonucleares por campo**; los **diplococos gramnegativos intracelulares** confirman gonorrea (sensibilidad > 90 % en el varón sintomático). Si hay polimorfonucleares sin diplococos se trata como uretritis no gonocócica (*Chlamydia*, *Mycoplasma*, *Ureaplasma*, *Trichomonas*). En la mujer el Gram endocervical es poco sensible: se prefieren PCR o cultivo. 1.04.5.004



A. CHANCROIDE



B. HERPES GENITAL



C. CHANCRO SIFILÍTICO

Imagen 3.5

TABLA 3.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ÚLCERAS GENITALES EN EUNACOM

1.04.1.010, 4.01.1.058, 3.01.3.010, 1.04.3.003, 1.04.5.004, 4.03.3.004

CARACTERÍSTICA	HERPES GENITAL (VHS-2)	SÍFILIS PRIMARIA (CHANCRO DURO)	CHANCROIDE (CHANCRO BLANDO)
Etiología	Virus Herpes Simplex tipo 2 (o 1)	Treponema pallidum	Haemophilus ducreyi
Número de lesiones	Múltiples vesículas agrupadas en racimo	Habitualmente única	Múltiples (autoinoculables)
Dolor local	Muy dolorosas	Completamente indolora	Intensamente dolorosa
Fondo de la úlcera	Eritematoso limpio tras romperse	Limpio con base indurada y firme	Sucio, purulento y necrótico
Adenopatía regional	Sensible bilateral	Indolora, firme y bilateral	Dolorosa con tendencia a fistulizar (bubón)
Tratamiento de elección	Aciclovir oral 400 mg c/8h x 7-10 d	Penicilina Benzatina 2.4 MU IM x 1	Azitromicina 1 g oral o Ceftriaxona 250 mg IM

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.5

Hombre de 22 años sexualmente activo consulta por cuadro de 4 días de disuria intensa y abundante secreción matinal purulenta amarillenta por el meato uretral. En el box de urgencias se toma frotis de la secreción uretral con tinción de Gram que revela abundantes polimorfonucleares con presencia de diplococos Gram negativos intracelulares.

Conducta oficial. El hallazgo de diplococos Gram negativos intracelulares en un hombre con secreción purulenta confirma el diagnóstico de Uretritis Gonocócica por Neisseria gonorrhoeae. Sin embargo, la norma nacional e internacional de manejo de ITS exige administrar SIEMPRE tratamiento combinado que cubra simultáneamente N. gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, dada la altísima tasa de coinfección (hasta 40%). El esquema de elección es Ceftriaxona 500 mg IM dosis única + Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral por 7 días (o Azitromicina 1 g oral). Se debe tratar a los contactos sexuales de los últimos 60 días y abstenerse de relaciones sexuales por 7 días.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Uretritis gonocócica: secreción purulenta abundante; Gram con diplococos Gram negativos intracelulares.
- Uretritis no gonocócica (Chlamydia): secreción serosa o escasa, incubación larga, Gram sin bacterias visibles.
- Toda uretritis exige tratamiento combinado empírico: Ceftriaxona 500 mg IM (gonococo) + Doxiciclina 100 mg c/12h x 7 días (clamidia).
- Úlcera dolorosa en racimo sobre base eritematosa: Herpes genital (tratar con Aciclovir oral).
- Úlcera indolora, base indurada y limpia: Sífilis primaria (tratar con Penicilina Benzatina dosis única).
- Úlcera dolorosa, fondo sucio y purulento con bubón fistulizado: Chancroide (Haemophilus ducreyi).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

1. Un hombre de 25 años consulta por disuria y secreción uretral purulenta abundante. La tinción de Gram de la secreción demuestra diplococos Gram negativos intracelulares. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?

A) Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única en monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única + Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral por 7 días
C) Ciprofloxacino 500 mg oral en dosis única
D) Azitromicina 500 mg diarios por 3 días
E) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

2. Una mujer de 22 años consulta por intenso dolor vulvar y ardor al orinar de 3 días de evolución. Al examen ginecológico se aprecian múltiples vesículas agrupadas y pequeñas úlceras superficiales eritematosas muy sensibles en ambos labios mayores, con adenopatías inguinales dolorosas bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento indicado?

A) Chancroide / Ceftriaxona IM
B) Sífilis primaria / Penicilina Benzatina IM
C) Herpes genital primario / Aciclovir oral
D) Linfogranuloma venéreo / Doxiciclina oral
E) Candidiasis vulvovaginal / Fluconazol oral

Más preguntas online de Infecciones de Transmisión Sexual →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)	Ley del SIDA: test de VIH es voluntario, confidencial y requiere consentimiento...	**El diagnóstico definitivo en Chile lo realiza EXCLUSIVAMENTE el Instituto de Salud...**	—
Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	Pneumocystis jirovecii: tos seca, disnea subaguda, infiltrado intersticial bilateral en...	**Tratamiento de Pneumocystis: Cotrimoxazol a dosis altas por 21 días.**	—
Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	Pleuritis TBC: derrame pleural exudado linfocítico con ADA > 40 UI/L (valor diagnóstico...	**GeneXpert: PCR en tiempo real que confirma M. tuberculosis y detecta resistencia a...**	—
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas	Chancro sifilítico (primaria): úlcera única, base indurada, fondo limpio e INDOLORA.	**Secundarismo sifilítico: exantema maculopapular con compromiso palmo-plantar y...**	En embarazada alérgica a penicilina: DESENSIBILIZACIÓN CON PENICILINA obligatoria...
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH	Uretritis gonocócica: secreción purulenta abundante; Gram con diplococos Gram negativos...	**Uretritis no gonocócica (Chlamydia): secreción serosa o escasa, incubación larga, Gram...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Ley del SIDA: test de VIH es voluntario, confidencial y requiere consentimiento informado firmado.

El diagnóstico definitivo en Chile lo realiza EXCLUSIVAMENTE el Instituto de Salud Pública (ISP); nunca rotular con un test...

Estrategia actual: TARV universal e inmediata a todo paciente confirmado, sin importar el nivel de CD4.

Esquema preferente de primera línea en Chile: Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir (TDF/3TC/DTG) en dosis única diaria.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El diagnóstico definitivo en Chile lo realiza EXCLUSIVAMENTE el Instituto de Salud Pública (ISP); nunca rotular con un test rápido local.
- Estrategia actual: TARV universal e inmediata a todo paciente confirmado, sin importar el nivel de CD4.
- Tratamiento de Pneumocystis: Cotrimoxazol a dosis altas por 21 días.
- CORTICOIDES en Pneumocystis: obligatorios si PaO2 < 70 mmHg o Gradiente A-a ≥ 35 mmHg.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Ley del SIDA: test de VIH es voluntario, confidencial y requiere consentimiento informado firmado.	Tema 3.1 →
Pneumocystis jirovecii: tos seca, disnea subaguda, infiltrado intersticial bilateral en alas de mariposa y LDH...	Tema 3.2 →
Pleuritis TBC: derrame pleural exudado linfocítico con ADA > 40 UI/L (valor diagnóstico confirmatorio).	Tema 3.3 →
Chancro sifilítico (primaria): úlcera única, base indurada, fondo limpio e INDOLORA.	Tema 3.4 →
Uretritis gonocócica: secreción purulenta abundante; Gram con diplococos Gram negativos intracelulares.	Tema 3.5 →

MANUAL EUNACOM DE INFECTOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

6	14	MINSAL
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

4.1	Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)	57
4.2	Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica	61
4.3	Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	64
4.4	Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	68
4.5	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	71
4.6	Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)	74

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.2.008	Síndrome Pulmonar por Hantavirus	Sospecha	Inicial	Derivar
1.04.4.016, 1.01.1.020	Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica	Específico	Completo	Completo
1.04.1.008, 1.04.1.018	Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	Específico	Inicial	Derivar
1.04.1.013, 1.04.1.027, 4.01.1.037, 1.05.1.020	Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	Específico	Completo	Completo
1.04.1.004, 1.04.1.017, 1.04.1.012, 2.01.1.013	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Específico	Completo	Completo
1.04.1.003	Ántrax	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
14 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Reservorio de Hantavirus en Chile: Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga); contagio por inhalación de orina/heces secas.
- Tríada de sospecha en hemograma: Trombocitopenia + Hemoconcentración (Hto alto) + Inmunoblastos > 10%.
- Mialgias muy intensas con predilección por muslos y región lumbar.
- **! TRAMPA** · Regla terapéutica de oro: MANEJO RESTRICTIVO DE FLUIDOS para evitar inundación alveolar por fuga capilar.
- Soporte avanzado de rescate: ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) veno-arterial.
- Es una Enfermedad de Notificación Obligatoria (ENO) de carácter INMEDIATO.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 6 TEMAS

Síndrome Pulmonar por Hantavirus	EUNACOM Julio 2025 · #7
Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica	EUNACOM Julio 2024 · #2 · EUNACOM Julio 2024 · #70 · EUNACOM Julio 2024 · #3 · EUNACOM Diciembre 2022 · #119
Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	EUNACOM Julio 2019 · #147
Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	EUNACOM Diciembre 2025 · #56 · EUNACOM Diciembre 2025 · #11 · EUNACOM Enero 2023 · #88 · EUNACOM Diciembre 2022 · #56
Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	EUNACOM Diciembre 2025 · #57 · EUNACOM Diciembre 2024 · #6 · EUNACOM Diciembre 2024 · #137 · EUNACOM Enero 2023 · #23

4.1. Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.04.2.008

¿POR QUÉ?

El Hantavirus (Virus Andes) es una zoonosis de alta letalidad (30–35%) transmitida por el ratón colilargo. En el EUNACOM se evalúa de manera estricta la tríada patognomónica del hemograma, la notificación ENO inmediata y la regla de oro terapéutica: restricción estricta de fluidos y traslado precoz a centro con ECMO.

1. EPIDEMIOLOGÍA Y MECANISMO DE TRANSMISIÓN

El agente causal en Chile es el **Virus Andes**, cuyo reservorio natural es el roedor silvestre *Oligoryzomys longicaudatus* **(ratón colilargo)**, presente desde Coquimbo hasta Aysén. **(ver Imagen 4.1A)** 1.04.2.008

El contagio ocurre por **inhalación de aerosoles** de excretas secas en recintos cerrados (cabañas, bodegas, leñeras). El virus infecta el endotelio pulmonar causando **fuga capilar masiva** (edema pulmonar no cardiogénico) y **depresión miocárdica intrínseca severa**.

2. FASES CLÍNICAS Y LA TRÍADA CARDINAL DEL HEMOGRAMA

• **Fase Prodrómica (3–6 días):** fiebre alta, cefalea y **mialgias intensas en muslos y región lumbar**. No hay coriza ni tos inicial. 1.04.2.008

• **Fase Cardiopulmonar:** tos seca, disnea rápidamente progresiva y shock cardiogénico fulminante. **(ver Imagen 4.1B)**

Tríada Cardinal en Hemograma:

1) **Trombocitopenia marcada (< 100.000/mm³)**.

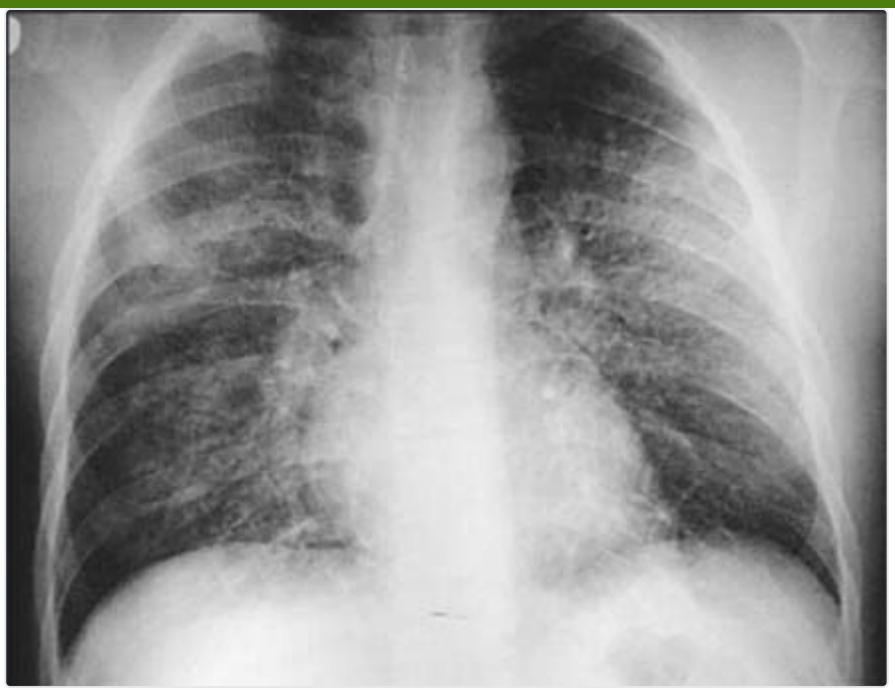
2) **Hemoconcentración severa (Hematocrito > 45–50%)** por extravasación plasmática.

3) **Inmunoblastos (linfocitos atípicos) > 10%** en frotis.

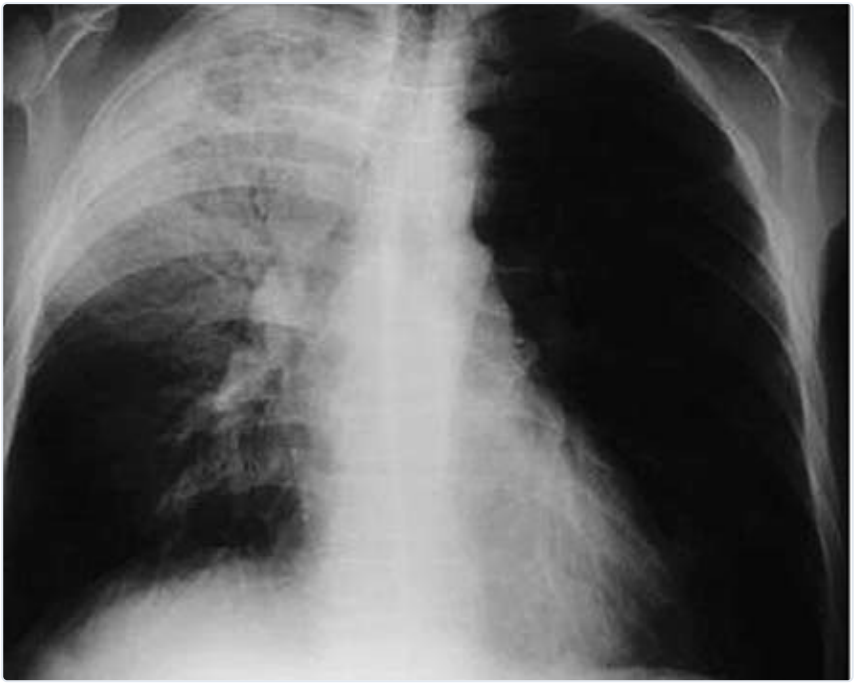
3. PILARES DE MANEJO Y REGLA DE RESTRICCIÓN DE FLUIDOS

Diagnóstico: IgM específica para Hantavirus (test rápido o ELISA ISP). ENO obligatoria inmediata. 1.04.2.008

Reglas de oro terapéuticas: 1) **RESTRICCIÓN HÍDRICA ESTRICTA**: cualquier sobrecarga de cristaloides inunda los alvéolos y causa muerte por asfixia; 2) Vasopresor precoz: **Noradrenalina**; 3) **Derivación precoz a centro con ECMO** veno-arterial en la fase inicial de disnea.



A. INICIO



B. FASE CARDIOPULMONAR

Imagen 4.1

FIGURA 4.1 · ENFRENTAMIENTO Y MANEJO DE EMERGENCIA EN HANTAVIRUS (SCPH)

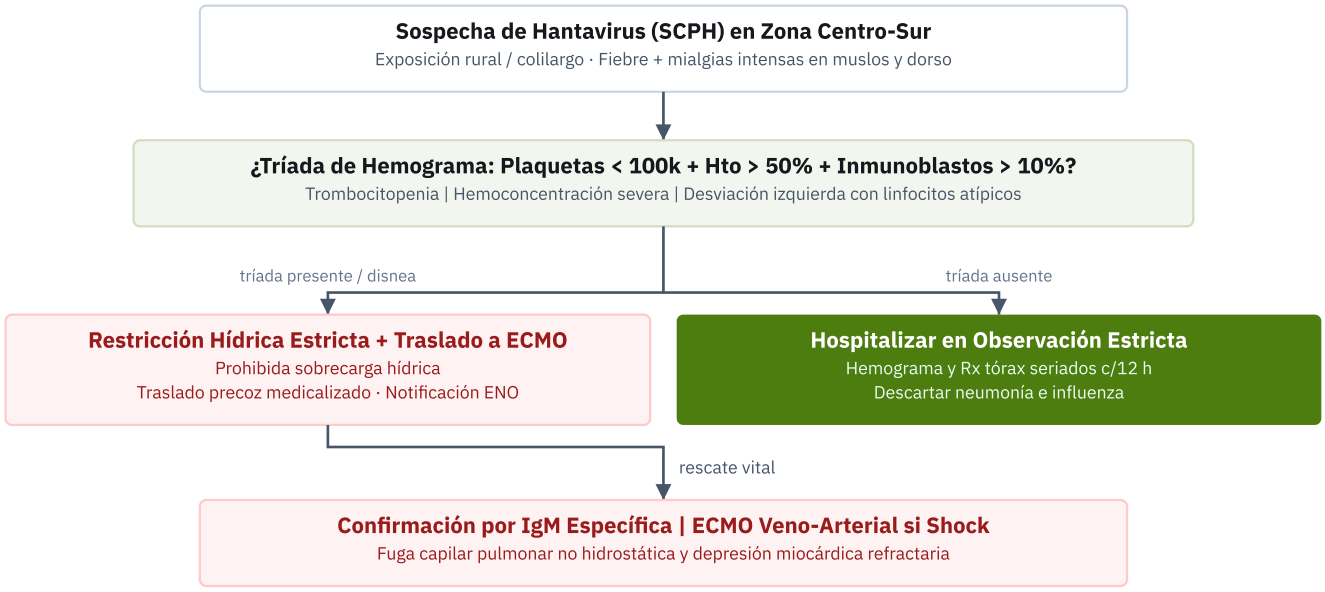


TABLA 4.1 · HANTAVIRUS (SCPH) VS NEUMONÍA GRAVE VS SEPSIS BACTERIANA 1.04.2.008

PARÁMETRO	HANTAVIRUS (SCPH)	NEUMONÍA GRAVE COMUNITARIA	SHOCK SÉPTICO CLÁSICO
Antecedente clave	Ruralidad, cabaña cerrada, colilargo	Brote comunitario invernal	Foco infeccioso evidente (piel, ITU)
Mialgias	Intensas en muslos y dorso lumbar	Mialgias generalizadas leves	Variable, no predominante
Hemograma patognomónico	Plaquetas < 100k + Hto > 50% + Inmunoblastos	Leucocitosis con neutrofilia, Hto normal	Leucocitosis con neutrofilia y desviación
Manejo de fluidos	RESTRICCIÓN ESTRICTA (evitar sobrecarga)	Aporte hídrico estándar según balance	Carga agresiva inicial (30 mL/kg)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.1

Hombre de 38 años, trabajador agrícola de la Región del Maule, consulta en el servicio de urgencia por 4 días de fiebre de 39 °C, cefalea holocraneana y mialgias intensas en la espalda y muslos. En las últimas 6 horas agrega tos seca y disnea de esfuerzo progresiva. Refiere haber limpiado una bodega de herramientas deshabitada hace 2 semanas. Al examen: T° 38.3 °C, PA 90/60 mmHg, FC 115 lpm, FR 28 rpm, saturación 89% con aire ambiental. Radiografía de tórax muestra infiltrados alveolares bilaterales perihiliares difusos sin cardiomegalia. Hemograma: Hematocrito 54%, Leucocitos 18.500/mm³ con 14% de linfocitos atípicos (inmunoblastos) y Plaquetas 42.000/mm³.

Conducta oficial. El antecedente ocupacional rural de exposición a bodegas cerradas sumado a la tríada de laboratorio patognomónica (trombocitopenia severa < 50.000, hemoconcentración con Hto > 50% y presencia de inmunoblastos > 10%) en un paciente con síndrome febril y disnea progresiva es diagnóstico de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH). La conducta inmediata consiste en notificar de urgencia a la autoridad sanitaria (ENO), evitar la sobrecarga con cristaloides (aporte hídrico restrictivo), instalar oxígeno suplementario y coordinar el traslado inmediato en ambulancia medicalizada hacia un centro de alta complejidad que cuente con disponibilidad de soporte con ECMO.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Reservorio de Hantavirus en Chile: Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga); contagio por inhalación de orina/heces secas.
- Tríada de sospecha en hemograma: Trombocitopenia + Hemoconcentración (Hto alto) + Inmunoblastos > 10%.
- Mialgias muy intensas con predilección por muslos y región lumbar.
- Regla terapéutica de oro: MANEJO RESTRICTIVO DE FLUIDOS para evitar inundación alveolar por fuga capilar.
- Soporte avanzado de rescate: ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) veno-arterial.
- Es una Enfermedad de Notificación Obligatoria (ENO) de carácter INMEDIATO.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Hantavirus

1. Un trabajador forestal de 32 años consulta en un hospital de baja complejidad por cuadro de 3 días de fiebre alta, dolor muscular severo en muslos y sensación de falta de aire. El hemograma muestra Hematocrito de 52%, leucocitos de 16.000/mm³ con 12% de inmunoblastos y recuento de plaquetas de 48.000/mm³. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas está formalmente contraindicada o debe evitarse?

A) Carga masiva de cristaloides con 30 mL/kg en bolo
B) Oxigenoterapia con mascarilla de no reinhalación
C) Monitoreo estricto de diuresis horaria
D) Traslado en ambulancia avanzada con médico
E) Toma de serología para IgM específica

Banco de Preguntas Oficial · Hantavirus

2. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente del virus Hanta en Chile según la epidemiología nacional?

A) Picadura del mosquito Aedes aegypti
B) Inhalación de aerosoles contaminados con excretas de ratón colilargo
C) Consumo de carne cruda de cerdo
D) Mordedura directa de murciélago silvestre
E) Contacto sexual con personas asintomáticas

Más preguntas online de Síndrome Pulmonar por Hantavirus →

4.2. Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.04.4.016 1.01.1.020

¿POR QUÉ?

La Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis americana) es una zoonosis endémica en Chile entre la I y VI Región. En el examen EUNACOM se evalúa de forma reiterada la diferencia diagnóstica entre la fase aguda (exámenes parasitológicos directos como microhematocrito) y la fase crónica (serología IgG), el tamizaje perinatal universal en embarazadas y las complicaciones viscerales (bloqueo completo de rama derecha y megacolon).

1. CICLO BIOLÓGICO, TRANSMISIÓN Y VECTOR EN CHILE

Causada por el protozoo hemoflagelado *Trypanosoma cruzi*. En Chile, el vector biológico clásico fue la vinchuca domiciliaria (*Triatoma infestans*), la cual fue declarada interrumpida en su transmisión vectorial intradomiciliaria en 1999. **(ver Imagen 4.2C)**



Vinchuca

Hoy en día, las principales vías de transmisión en Chile son: 1.04.4.016

• **Vía congénita / transplacentaria (vertical):** es la **vía de transmisión predominante actual**. Por ello, el MINSAL establece **tamizaje serológico obligatorio universal con IgG en el control prenatal** a toda embarazada que resida o haya nacido desde la Región del Libertador Bernardo O'Higgins hacia el norte (y a todas las extranjeras provenientes de zonas endémicas de Sudamérica).

• **Vía vectorial silvestre:** por vinchucas silvestres (*Mepraia spinolai*) en zonas rurales del norte chico (Coquimbo, Valparaíso). El insecto defeca durante la picadura; el prurito hace que el rascado inocule los tripomastigotes metacíclicos en la herida o conjuntiva.

2. FASES CLÍNICAS: AGUDA, CRÓNICA INDETERMINADA Y DETERMINADA

• **Fase Aguda (parásitos en sangre):** habitualmente asintomática en adultos. En niños puede cursar con síndrome febril prolongado, hepatoesplenomegalia y signos de puerta de entrada: **Signo de Romaña** (edema bipalpebral unilateral indoloro con adenopatía preauricular) o **Chagoma de inoculación**. 1.01.1.020

• **Fase Crónica Indeterminada (latente):** serología IgG positiva sin síntomas, con ECG y radiografías normales. Dura décadas; el 70% de los pacientes nunca progresa.

• **Fase Crónica Determinada (30% de los infectados):** destrucción de plexos nerviosos mioentéricos y fibrosis miocárdica:

1. **Cardiopatía chagásica:** arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca y el hallazgo clásico en el ECG: **Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD) asociado a Hemibloqueo Anterior Izquierdo (HBAI)**.
2. **Forma digestiva: Megacolon** (constipación severa de semanas, fecalomas recurrentes y vólvulo de sigmoides) y **Megaesófago** (disfagia progresiva y regurgitación similar a acalasia). **(ver Imagen 4.2A y B)**

3. DIAGNÓSTICO POR ETAPAS Y TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO

Regla de oro diagnóstica según la fase: 1.04.4.016

• **Fase Aguda y Recién Nacido de madre con Chagas:** la parasitemia es alta; se realiza **diagnóstico PARASITOLÓGICO DIRECTO** (Microhematocrito o gota gruesa) o PCR. *La IgG no sirve en el recién nacido porque cruza la placenta y refleja los anticuerpos de la madre.*

• **Fase Crónica:** la parasitemia es indetectable; se realiza **diagnóstico SEROLÓGICO** mediante **dos pruebas serológicas IgG diferentes positivas (ELISA IgG + IFI / HAI)** confirmadas por el ISP.

Tratamiento: Nifurtimox (8-10 mg/kg/día por 60 días) o Benznidazol (5-7 mg/kg/día por 60 días). Indicación absoluta: en fase aguda, Chagas congénito, niños y adultos jóvenes en fase indeterminada (< 50 años). En embarazo el tratamiento está contraindicado durante la gestación (se trata a la madre post-parto y lactancia).

4. MIOCARDIOPATÍAS: LA CARDIOPATÍA CHAGÁSICA Y OTRAS FORMAS

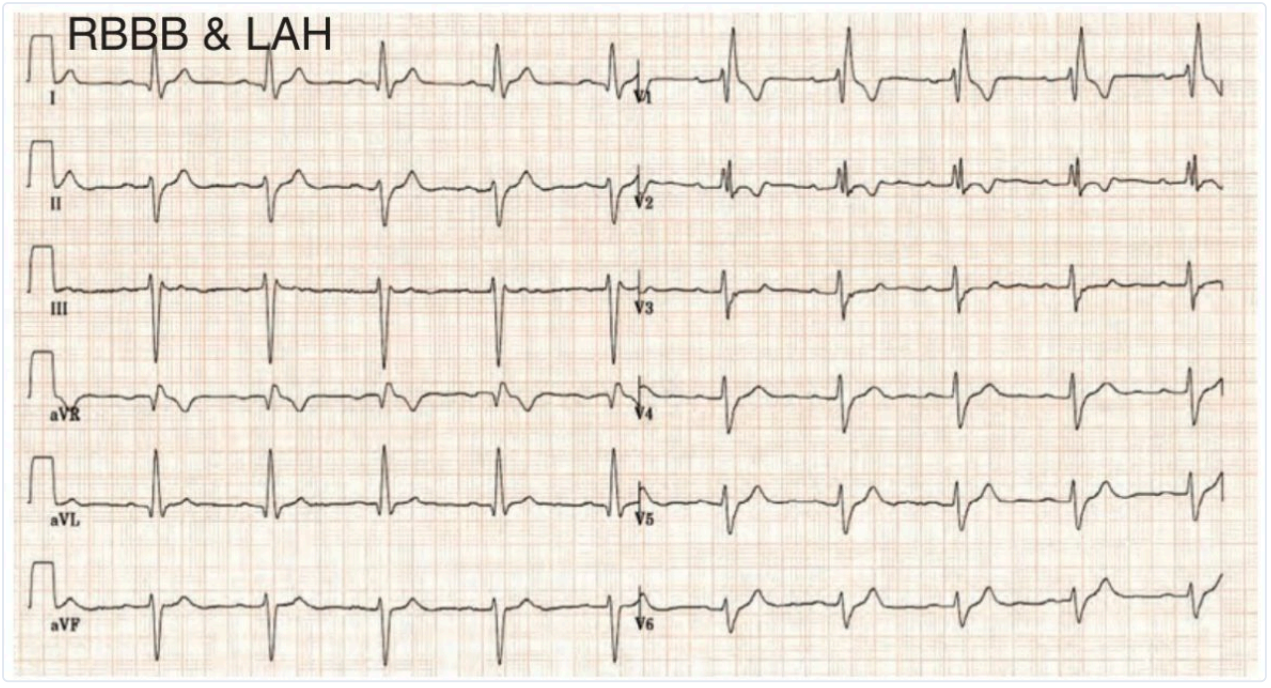
Las miocardiopatías son enfermedades del músculo cardíaco con disfunción mecánica o eléctrica. 1.01.1.020 **Dilatada** (FEVI < 40 %): idiopática, alcohol, viral, periparto, antraciclinas, taquicardiomiopatía y **Chagas** (bloqueo de rama derecha + hemibloqueo anterior izquierdo, aneurisma apical). **Hipertrófica** (septo ≥ 15 mm, hereditaria): soplo sistólico que aumenta con Valsalva, síncope de esfuerzo y **muerte súbita en jóvenes deportistas**; se maneja con betabloqueo, evitando deshidratación, vasodilatadores y deporte competitivo. **Restrictiva** (amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis): insuficiencia cardíaca derecha con ventrículos pequeños y aurículas grandes. Se sospecha ante disnea, edema, fatiga, síncope o arritmia con ECG, Rx de tórax y ecocardiograma anormales; el médico general inicia el manejo de la insuficiencia cardíaca (IECA/ARA-II, betabloqueador, espironolactona, diurético) y **deriva a cardiología**.



A. SIGNO DE ROMAÑA



B. MEGAESÓFAGO



C. ECG

Imagen 4.2

TABLA 4.2 · DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS SEGÚN LA FASE CLÍNICA 1.04.4.016, 1.01.1.020

FASE CLÍNICA	MÉTODO DIAGNÓSTICO DE ELECCIÓN	MANIFESTACIÓN TÍPICA	INDICACIÓN DE FÁRMACO ANTIPARASITARIO
Aguda / Congénita	Parasitológico directo (Microhematocrito) / PCR	Signo de Romaña o asintomático en RN	Indicación absoluta: Nifurtimox o Benznidazol
Crónica Indeterminada	Serología IgG por 2 técnicas (ELISA + IFI)	Completamente asintomático (ECG normal)	Indicado en < 50 años para prevenir progresión
Cardiopatía Chagásica	Serología IgG + ECG + Ecocardiograma	BCRD + HBAI, arritmias ventriculares, IC	Manejo de IC / Marcapasos (parasiticida discutido)
Megacolon / Megaesófago	Serología IgG + Rx baritada / TAC	Constipación pertinaz, fecalomas, disfagia	Manejo de la constipación, cirugía de resección

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.2

Recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional, hijo de madre de 28 años con Chagas crónico asintomático confirmado durante el control prenatal. El lactante nace vigoroso, afebril, sin visceromegalias ni alteraciones al examen físico.

Conducta oficial. En un recién nacido hijo de madre con Enfermedad de Chagas, la conducta protocolizada por el MINSAL consiste en realizar de inmediato al nacer un estudio parasitológico directo en sangre de cordón o punción venosa periférica mediante Microhematocrito (o PCR). La serología IgG está formalmente contraindicada para confirmar el diagnóstico al nacer porque refleja el paso transplacentario de anticuerpos maternos (falsos positivos). Si el microhematocrito inicial es positivo, se inicia tratamiento inmediato con Nifurtimox o Benznidazol (con tasas de curación > 95% en el lactante). Si resulta negativo, se repite a los 3 meses o se solicita serología IgG después de los 9-12 meses (cuando los anticuerpos maternos ya han desaparecido).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Vía de transmisión más frecuente actual en Chile: vertical / congénita transplacentaria.
- Tamizaje prenatal con serología IgG: universal y obligatorio en zonas endémicas (desde O'Higgins al norte).
- Diagnóstico en recién nacido / fase aguda: método PARASITOLÓGICO DIRECTO (microhematocrito) o PCR.
- Diagnóstico en fase crónica: SEROLOGÍA (dos técnicas IgG positivas: ELISA + IFI).
- Cardiopatía chagásica: Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD) + Hemibloqueo Anterior Izquierdo (HBAI).
- Megacolon y megaesófago: por destrucción parasitaria de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach.
- Tratamiento de elección: Nifurtimox o Benznidazol por 60 días (contraindicados en el embarazo).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedad de Chagas

1. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar o descartar la transmisión congénita de la Enfermedad de Chagas en un recién nacido hijo de madre seropositiva durante sus primeros días de vida?

A) Serología ELISA IgG en sangre del recién nacido
B) Examen parasitológico directo mediante microhematocrito en sangre fresca
C) Western Blot específico para anticuerpos IgM anti-Trypanosoma cruzi
D) Radiografía de tórax y ecocardiograma neonatal
E) Esperar a los 15 años de vida para realizar tamizaje serológico

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedad de Chagas

2. Un hombre de 60 años originario de la Región de Coquimbo consulta por constipación crónica pertinaz de años de evolución que se ha agravado en los últimos meses, requiriendo enemas evacuantes periódicos. El enema baritado muestra marcada dilatación del colon sigmoides y recto. El electrocardiograma revela bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer de colon izquierdo estenosante
B) Enfermedad de Chagas en fase crónica determinada
C) Enfermedad de Hirschsprung del adulto
D) Colitis ulcerosa de larga data
E) Síndrome de colon irritable variante constipación

Más preguntas online de Enfermedad de Chagas →

4.3. Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.008 1.04.1.018

¿POR QUÉ?

Las enfermedades transmitidas por mosquitos (arbovirosis y malaria) representan las principales causas de fiebre en viajeros procedentes del trópico que consultan en Chile. En el EUNACOM se evalúa el reconocimiento inmediato de los signos de alarma del Dengue (dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas, fuga plasmática) y el frotis/gota gruesa para Malaria, así como la profilaxis antes de viajar.

1. DENGUE (FLAVIVIRUS - VECTOR AEDES AEGYPTI)

1.04.1.008

El virus del dengue presenta 4 serotipos (DENV-1 a 4). En Chile continental el vector no es endémico, pero sí existe en Isla de Pascua (Rapa Nui) y con hallazgos recientes en el extremo norte (Arica y Tarapacá). La gran mayoría de los casos son importados de países vecinos (Brasil, Bolivia, Perú, Argentina). **(ver Imagen 4.3B)**

Fisiopatología: la infección por un serotipo genera inmunidad homóloga de por vida, pero solo inmunidad cruzada temporal contra los otros 3 serotipos. La infección secundaria por un serotipo diferente puede desencadenar una **amplificación mediada por anticuerpos (ADE)**, generando una tormenta de citoquinas y fuga capilar masiva (Dengue Grave).

Fases clínicas:

• **Fase febril (días 1 a 3):** fiebre alta súbita, cefalea retroorbitaria intensa ("dolor detrás de los ojos"), mialgias y artralgias intensas ("fiebre quebrantahuesos") y exantema eritematoso con islas blancas de piel sana.

• **Fase crítica (días 3 a 7, al caer la fiebre):** período de máximo peligro por fuga plasmática.

SIGNOS DE ALARMA DE DENGUE GRAVE (exigen hospitalización inmediata):

1. Dolor abdominal intenso y continuo.
2. Vómitos persistentes.
3. Acumulación clínica de fluidos (ascitis, derrame pleural).
4. Sangrado de mucosas (epistaxis, gingivorragia).
5. Letargia o irritabilidad extrema.
6. Hepatomegalia > 2 cm.
7. **Laboratorio: aumento progresivo del hematocrito concurrente con caída rápida de plaquetas (< 100.000/mm³)**.

Tratamiento: soporte hemodinámico vigoroso con cristaloides. **CONTRAINDICADOS formalmente los AINEs y la Aspirina** por riesgo de hemorragia grave; analgesia exclusivamente con Paracetamol. **(ver Imagen 4.3C)**

2. MALARIA / PALUDISMO (PLASMODIUM SPP. - MOSQUITO ANOPHELES)

1.04.1.018

Transmitida por la hembra del mosquito *Anopheles*. Causada por protozoos del género *Plasmodium*: *P. falciparum* (el más letal, responsable de la malaria cerebral y hemólisis masiva), *P. vivax* y *P. ovale* (forman hipnozoítos latentes en el hígado que causan recidivas meses después) y *P. malariae*. **(ver Imagen 4.3A)**

Clínica: accesos palúdicos paroxísticos con la tríada: calofrío intenso con temblor incontrolable $ ightarrow$ fiebre alta de 40 °C con cefalea $ ightarrow$ diaforesis profusa y descenso térmico. El ciclo se repite cada 48 horas (fiebre terciana en *P. falciparum/vivax*) o cada 72 horas (fiebre cuartana en *P. malariae*). Cursa con **anemia hemolítica e ictericia**.

Diagnóstico de certeza: Frotis sanguíneo y Gota gruesa teñidos con Giemsa tomados preferentemente durante el pico febril (permite visualizar trofozoítos en anillo y cuantificar la parasitemia).

Tratamiento:

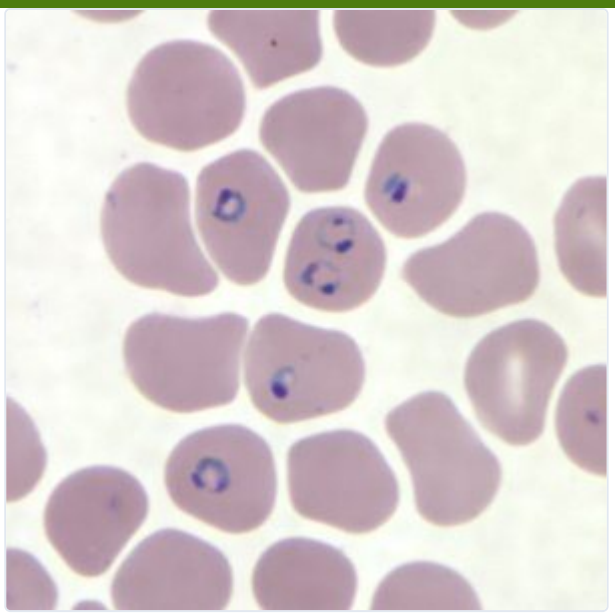
• *P. falciparum:* terapia combinada basada en artemisininas (Arteméter-Lumefantrina).

• *P. vivax / P. ovale:* **Cloroquina** (elimina formas sanguíneas) + **Primaquina por 14 días** (obligatoria para erradicar los hipnozoítos intrahepáticos y prevenir recaídas; contraindicada en déficit de G6PD por riesgo de hemólisis).

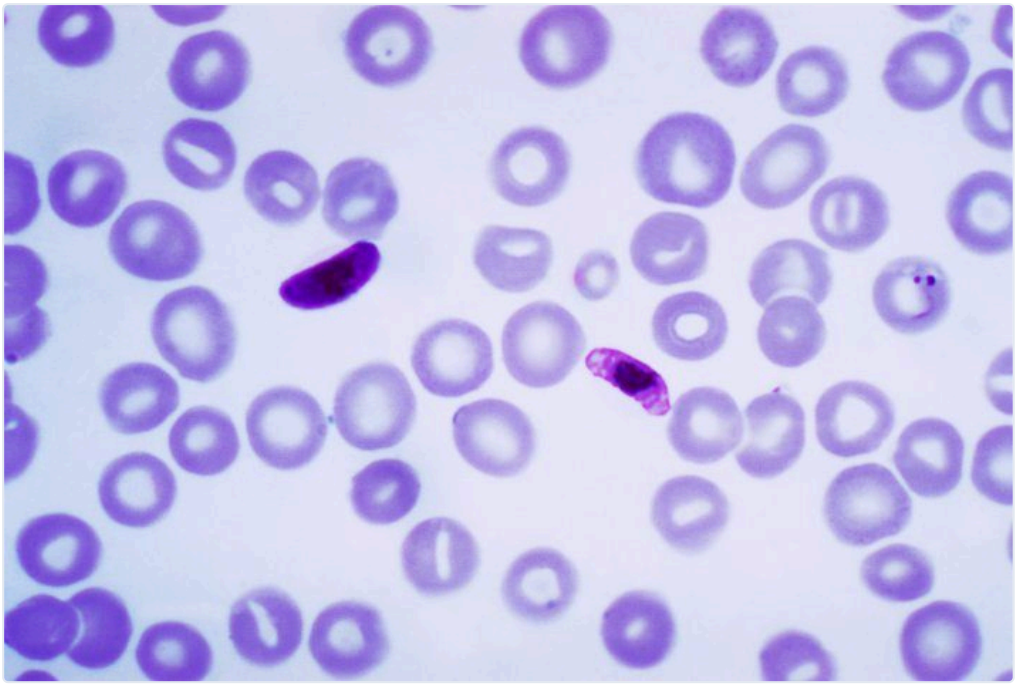
3. FIEBRE AMARILLA Y VACUNACIÓN DEL VIAJERO

Flavivirus transmitido por mosquitos en zonas selváticas de Sudamérica y África. Cursa con fiebre, bradicardia relativa (signo de Faget), ictericia fulminante y sangrado digestivo ("vómito negro"). Letalidad > 20-50%.

Vacuna antiamarílica (virus vivo atenuado cepa 17D): altamente eficaz, otorga inmunidad de por vida con 1 sola dosis. Debe administrarse **al menos 10 días antes de viajar** a zonas endémicas. Contraindicada en embarazadas, lactantes < 9 meses y pacientes con timoma o inmunosupresión severa.



A. ANILLOS DE FALCIPARUM



B. GAMETOCITOS



C. EXANTEMA DEL DENGUE

Imagen 4.3

TABLA 4.3 · ENFERMEDADES FEBRILES TROPICALES DEL VIAJERO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EUNACOM 1.04.1.008, 1.04.1.018

ENFERMEDAD	VECTOR Y PATÓGENO	CLÍNICA PROTOTÍPICA	EXAMEN CONFIRMATORIO	TERAPIA DE ELECCIÓN
Dengue	Aedes aegypti · Flavivirus	Dolor retroorbitario + mialgias + exantema	Antígeno NS1 (< 5 d) / IgM (> 5 d)	Soporte con hidratación EV (prohibido AINEs)
Malaria (P. falciparum)	Anopheles hembra · Plasmodium	Paroxismos febriles + anemia + ictericia	Gota gruesa y frotis sanguíneo	Derivados de Artemisinina (Arteméter)
Malaria (P. vivax)	Anopheles · Plasmodium vivax	Accesos febriles cada 48 h (terciana)	Gota gruesa (trofozoítos en anillo)	Cloroquina + Primaquina (cura hipnozoítos)
Fiebre Amarilla	Haemagogus / Aedes · Flavivirus	Fiebre + ictericia intensa + hemorragias	Serología IgM / PCR viral	Soporte intensivo en UCI (vacuna preventiva)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.3

Joven de 26 años consulta por cuadro de 4 días de fiebre alta hasta 39.5 °C, dolor retroorbitario intenso que empeora con los movimientos oculares, mialgias generalizadas y artralgias severas. Refiere haber regresado hace 5 días de un viaje turístico al noreste de Brasil. Al examen: T° 38.8 °C, PA 110/70 mmHg, FC 92 lpm. Se aprecia exantema eritematoso difuso en tronco que respeta pequeñas zonas redondeadas de piel sana. No presenta dolor abdominal a la palpación ni signos de sangrado.

Conducta oficial. El antecedente de viaje reciente a zona endémica tropical de Sudamérica (Brasil) sumado a la clínica de fiebre aguda, cefalea retroorbitaria intensa ("dolor detrás de los ojos"), mialgias ("fiebre quebrantahuesos") y exantema macular eritematoso con "islas blancas en un mar rojo" es patognomónico de Dengue Clásico sin signos de alarma. La conducta médica correcta es confirmar con prueba de Antígeno NS1 o serología IgM, educar sobre los signos de alarma que obligan a reconsultar de urgencia (dolor abdominal continuo, sangrado mucoso, vómitos) e indicar manejo ambulatorio con hidratación oral abundante y PARACETAMOL para la fiebre. Se debe advertir explícitamente la contraindicación de Aspirina, Ibuprofeno o Ketoprofeno por el riesgo de inducir hemorragias graves.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Dengue: dolor retroorbitario + mialgias severas ("quebrantahuesos") + exantema con islas de piel sana.
- Signos de alarma de Dengue: dolor abdominal persistente, vómitos, sangrado mucoso, letargia y aumento del Hto con caída de plaquetas.
- En Dengue están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS los AINEs y la Aspirina por riesgo de hemorragia; solo usar Paracetamol.
- Malaria: sospechar en viajero procedente de zona endémica con accesos febriles paroxísticos, anemia hemolítica e ictericia.
- Diagnóstico de certeza de Malaria: GOTA GRUESA y frotis teñido con Giemsa.
- P. vivax y P. ovale requieren PRIMAQUINA por 14 días para erradicar los hipnozoítos hepáticos y prevenir recidivas.
- Vacuna contra Fiebre Amarilla: virus vivo atenuado; se aplica al menos 10 días antes de viajar y dura de por vida.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

1. Un hombre de 30 años consulta en urgencias por fiebre de 39 °C, cefalea y artralgias intensas tras regresar hace 4 días de un viaje por el Amazonas. El médico sospecha clínicamente infección por virus dengue. ¿Cuál de los siguientes fármacos analgésicos está formalmente contraindicado administrar a este paciente?

A) Paracetamol
B) Ketoprofeno
C) Dipirona
D) Tramadol
E) Codeína

Banco de Preguntas Oficial · Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

2. Una mujer de 29 años presenta accesos febriles con calofríos intensos y sudoración profusa cada 48 horas tras regresar de un viaje por el sudeste asiático. La gota gruesa confirma la presencia de trofozoítos de Plasmodium vivax. Tras el tratamiento inicial con Cloroquina y desaparición de los parásitos en sangre, ¿cuál es la conducta necesaria para prevenir recaídas tardías?

A) Administrar Primaquina oral durante 14 días
B) Continuar Cloroquina en dosis profiláctica por 6 meses
C) Indicar tratamiento con Doxiciclina por 21 días
D) Administrar vacuna antimalárica de refuerzo
E) No requiere fármacos adicionales dado que la cloroquina es curativa

Más preguntas online de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos →

4.4. Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.013 1.04.1.027 4.01.1.037 1.05.1.020

¿POR QUÉ?

La hidatidosis y la triquinosis son zoonosis parasitarias de alto impacto en zonas rurales y ganaderas de Chile. En el EUNACOM se evalúa de forma clásica la imagen ecográfica del quiste hidatídico (signo del camalote, membranas desprendidas), el riesgo de shock anafiláctico ante su rotura y la tríada clínica de triquinosis tras el consumo de cecinas o carne de cerdo clandestina.

1. HIDATIDOSIS (ECHINOCOCCUS GRANULOSUS)

La equinococosis quística es causada por la fase larvaria del cestodo *Echinococcus granulosus*. El hospedero definitivo es el perro (alberga el gusano adulto en su intestino), y los hospederos intermediarios son los ovinos, caprinos y bovinos. El ser humano es un hospedero intermediario accidental al ingerir huevos eliminados en las heces de perros que fueron alimentados con vísceras crudas con quistes. 1.04.1.013

Localizaciones: Hígado (65-75%, lóbulo derecho más frecuente) y **Pulmón (15-25%**, bases pulmonares). 1.04.1.013 4.01.1.037 1.05.1.020

Diagnóstico: ecografía abdominal (clasificación de Gharbi / OMS). Signos ecográficos clásicos: quiste con vesículas hijas en su interior (imagen en rueda de carreta) o desprendimiento de la membrana germinativa interna (**Signo del Camalote o del Nenúfar**). La serología (Arqueo 5 / ELISA IgG) tiene valor de apoyo. 1.04.1.013

Complicaciones y Manejo: rotura traumática o espontánea con **shock anafiláctico grave por liberación de líquido hidatídico** y siembra peritoneal secundaria. Tratamiento: **Albendazol oral (10-15 mg/kg/día)** asociado a punción-aspiración-inyección-reaspiración (**PAIR**) con agente escolicida (suero salino hipertónico o alcohol al 95%) o cirugía conservadora (periquistectomía). 1.04.1.013 4.01.1.037 1.05.1.020

2. TRIQUINOSIS (TRICHINELLA SPIRALIS)

Causada por el nematodo *Trichinella spiralis*. Se adquiere por el **consumo de carne de cerdo o subproductos (cecinas, longanizas, jamón casero) crudos o mal cocidos** provenientes de faenamiento clandestino sin inspección veterinaria (triquinoscopía). 1.04.1.027

Las larvas enquistadas se liberan en el estómago, maduran en el intestino delgado y las hembras liberan larvas recién nacidas que penetran la circulación y migran hacia el **músculo estriado esquelético de alta actividad metabólica** (diafragma, maseteros, lengua, bíceps), enquistándose.

Tríada clínica clásica patognomónica:

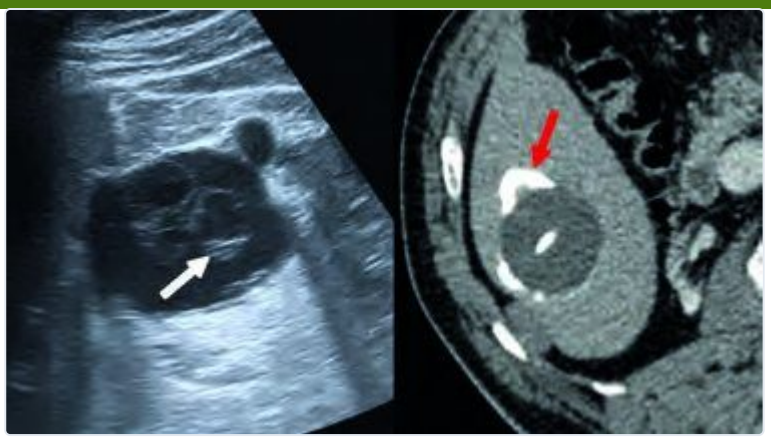
1. **Edema bipalpebral y facial bilateral simétrico** (a menudo con hemorragias subconjuntivales y en astilla bajo las uñas).
2. **Mialgias intensas generalizadas** (dolor al masticar, deglutir o respirar).
3. **Fiebre alta persistente** (39-40 °C).

Hallazgo de laboratorio cardinal: EOSINOFILIA MARCADAMENTE ELEVADA (> 20-50% del recuento leucocitario total) junto con elevación de enzimas musculares (CPK y LDH).

Tratamiento: Albendazol (400 mg cada 12 h por 10 a 14 días) o Mebendazol + analgésicos. En casos severos con miocarditis o toxicidad sistémica, se asocian corticoides (Prednisona).

3. HIDATIDOSIS PULMONAR

El pulmón es la **segunda localización** del quiste hidatídico (10–25 %) y la primera en niños. Muchos son hallazgos radiológicos: **imagen redonda, homogénea, de bordes nítidos** (múltiples: «bolas de cañón»). Se manifiesta con tos, dolor torácico, disnea y hemoptisis. La complicación característica es la **ruptura a bronquio**: vómica de líquido claro («agua de roca»), expectoración de membranas (hidatidoptisis) y, en la imagen, el **signo del camalote** (membrana flotando sobre el líquido) o del doble arco; la ruptura a pleura da neumotórax o empiema y puede causar **anafilaxia**. Diagnóstico por Rx y TAC; la serología (ELISA, IFI) es menos sensible que en el hígado. **Nunca se punciona** un quiste (riesgo de anafilaxia y diseminación). Tratamiento: **cirugía** (quistectomía con conservación del parénquima) con **albendazol** 10–15 mg/kg/día antes y después. Se sospecha, se inicia el estudio y se deriva a cirugía torácica; la prevención es el control del perro (antiparasitario periódico, no alimentarlo con vísceras crudas) y lavar las verduras. **(ver Imagen 4.4A y B)** 4.01.1.037 1.05.1.020



A. QUISTE HIDATÍDICO EN LA ECOGRAFÍA



B. QUISTE HIDATÍDICO (TC)

Imagen 4.4

TABLA 4.4 · HIDATIDOSIS VS TRIQUINOSIS: CUADRO RESUMEN EUNACOM `1.04.1.013, 1.04.1.027, 4.01.1.037, 1.05.1.020`

CARACTERÍSTICA	HIDATIDOSIS (ECHINOCOCCUS GRANULOSUS)	TRIQUINOSIS (TRICHINELLA SPIRALIS)
Fuente de contagio	Contacto con heces de perro / agua con huevos	Carne de cerdo o cecinas caseras crudas
Órgano blanco principal	Hígado (70%) y Pulmón (20%)	Músculo estriado (diafragma, maseteros)
Manifestación cardinal	Masa quística indolora / hallazgo ecográfico	Edema bipalpebral + mialgias + fiebre
Hallazgo clave de laboratorio	Imagen en camalote / serología IgG	Eosinofilia masiva (> 20-50%) + CPK elevada
Complicación más temida	Rotura de quiste con shock anafiláctico	Miocarditis o encefalitis por migración
Fármaco antiparasitario	Albendazol + procedimiento PAIR o Cirugía	Albendazol oral + Corticoides si severo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.4

Hombre de 44 años acude a urgencias por fiebre de 39 °C, mialgias severas en brazos y piernas que le dificultan caminar y masticar, e hinchazón en los ojos de 4 días de evolución. Refiere que hace 10 días participó en un asado familiar donde consumieron carne de cerdo y longanizas artesanales faenadas en el campo. Al examen físico destaca marcado edema bipalpebral bilateral y periorbitario con hiperemia conjuntival y dolor exquisito a la palpación de las masas musculares de pantorrillas y bíceps. El hemograma informa: leucocitos 16.200/mm³ con 42% de eosinófilos (absolutos 6.800/mm³), CPK total 890 UI/L.

Conducta oficial. El antecedente epidemiológico de consumo reciente de cecinas o carne de cerdo casera no inspeccionada, sumado a la tríada clínica de fiebre, edema bipalpebral bilateral y mialgias severas con una eosinofilia masiva (> 40%) y elevación de enzimas musculares (CPK), es la presentación clásica e inequívoca de Triquinosis aguda (fase de invasión muscular por Trichinella spiralis). La conducta médica consiste en notificar de inmediato el brote a la SEREMI de Salud (ENO) para decomisar el alimento fuente, e iniciar tratamiento con Albendazol 400 mg cada 12 horas oral por 10 a 14 días asociado a AINEs o corticoides para controlar la respuesta inflamatoria sistémica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Hidatidosis: el perro es el hospedero definitivo; el humano se contagia al ingerir huevos de las heces caninas.
- Quiste hidatídico hepático: imagen ecográfica clásica de membranas desprendidas (Signo del Camalote).
- Rotura de quiste hidatídico: provoca SHOCK ANAFILÁCTICO y diseminación secundaria (peritoneal).
- Triquinosis: antecedente de consumo de cecinas o carne de cerdo casera sin inspección sanitaria.
- Tríada de Triquinosis: Edema bipalpebral bilateral + Mialgias severas + Fiebre.
- Laboratorio patognomónico de Triquinosis: EOSINOFILIA MASIVA (> 20-50%) y CPK elevada.
- Tratamiento de elección en ambas entidades: Albendazol oral.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Zoonosis Chilenas

1. Un paciente de 35 años consulta por fiebre de 38.8 °C, dolor muscular difuso y marcado edema bipalpebral bilateral tras asistir hace dos semanas a una faena clandestina de cerdos donde consumió embutidos artesanales. El hemograma muestra leucocitosis con 38% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Triquinosis
B) Hidatidosis hepática complicada
C) Fiebre tifoidea
D) Dengue con signos de alarma
E) Enfermedad de Chagas aguda

Banco de Preguntas Oficial · Zoonosis Chilenas

2. Durante la realización de una ecografía abdominal de rutina a un campesino de 50 años asintomático, se identifica en el lóbulo hepático derecho una masa quística redondeada de 7 cm de diámetro con tabiques internos y desprendimiento de la membrana germinativa (signo del camalote). ¿Cuál es la complicación aguda más grave que puede presentar este paciente?

A) Rotura espontánea o traumática con shock anafiláctico grave
B) Transformación a colangiocarcinoma metastásico en menos de 1 año
C) Desarrollo de hipertensión portal con cirrosis hepática descompensada
D) Perforación gástrica con hemorragia digestiva alta masiva
E) Fístula aortoentérica exanguinante

Más preguntas online de Zoonosis Chilenas Endémicas →

4.5. Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.004 1.04.1.017 1.04.1.012 2.01.1.013

¿POR QUÉ?

Las bacteriosis zoonóticas y entéricas cursan como síndromes febriles prolongados con compromiso multisistémico. El examen EUNACOM evalúa el nexo causal específico: el consumo de quesos de cabra artesanales no pasteurizados en Brucelosis (fiebre ondulante y espondilodiscitis), el contacto con aguas estancadas contaminadas con orina de roedores en Leptospirosis (Síndrome de Weil) y la disociación pulso-temperatura en Fiebre Tifoidea.

1. BRUCELOSIS (FIEBRE ONDULANTE O DE MALTA)

Zoonosis bacteriana causada por cocobacilos Gram negativos intracelulares facultativos del género *Brucella*: *B. melitensis* (cabras y ovejas, la más invasora y frecuente en Chile) y *B. abortus* (bovinos). 1.04.1.004

Vía de transmisión: consumo de **leche cruda no pasteurizada o quesillos de cabra artesanales**, o contacto ocupacional de veterinarios y matarifes con fetos abortados y placentas de animales infectados.

Clínica: Fiebre ondulante vespertina o nocturna asociada a diaforesis profusa con **olor característico a "paja húmeda"**, astenia intensa, hepatoesplenomegalia y artralgias. Su complicación focal más frecuente e invalidante es la **sacroileítis y la espondilodiscitis lumbar**.

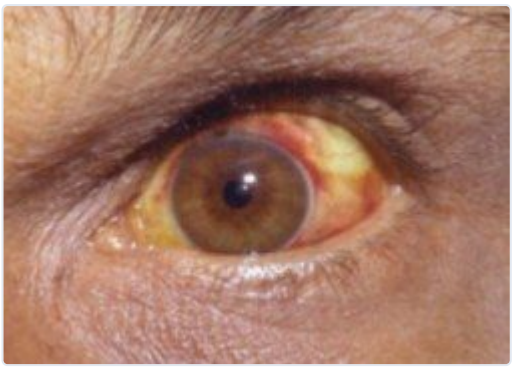
Diagnóstico y Tratamiento: serología mediante Rosa de Bengala (tamizaje rápido) y aglutinación en tubo (confirmación por títulos). Gold standard: mielocultivo (médula ósea) o hemocultivo en medios bifásicos prolongados (Ruiz-Castañeda). Tratamiento combinado obligatorio para evitar recaídas: **Doxiciclina 100 mg c/12h oral + Rifampicina 600-900 mg/día oral por 6 semanas consecutivas** (o Doxiciclina + Gentamicina las primeras 2 semanas).

2. LEPTOSPIROSIS Y SÍNDROME DE WEIL

Espiroqueta aerobia estricta (*Leptospira interrogans*) que coloniza los túbulos renales de roedores silvestres y urbanos (ratas), eliminándose en su orina. 1.04.1.017

Transmisión: contacto de la piel erosionada o mucosas con **aguas estancadas, barro, inundaciones o alcantarillados contaminados** (trabajadores de saneamiento, pescadores, bañistas en lagunas).

Forma anictérica (90%): síndrome febril bifásico agudo con **sufusión conjuntival bilateral sin secreción (eritema conjuntival en vidrio esmerilado)** y dolor exquisito a la compresión de las pantorrillas (músculos gastrocnemios).



Sufusión conjuntival en leptospirosis

Síndrome de Weil (Forma ictérica grave - 10%): tríada de **Ictericia rubínica + Falla renal aguda con hipokalemia + Diátesis hemorrágica** (hemorragia pulmonar letal). Diagnóstico: Microaglutinación (MAT). Tratamiento: **Penicilina G sódica EV (o Ceftriaxona EV) en casos graves**; Doxiciclina oral en formas leves.

3. FIEBRE TIFOIDEA (SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHI)

Bacilo Gram negativo entérico de reservorio exclusivamente humano. Transmisión fecal-oral por agua o alimentos contaminados por manipuladores portadores crónicos en vesícula biliar. 1.04.1.012 2.01.1.013

Clínica por semanas:

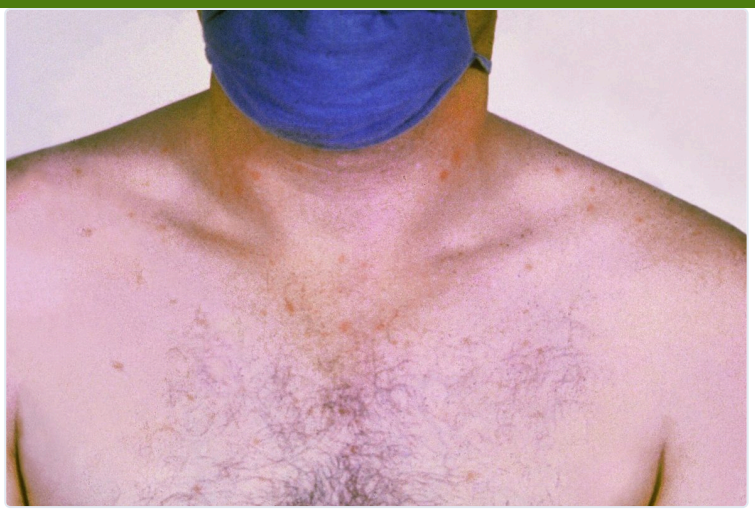
• Semana 1: fiebre que asciende "en escalera", cefalea intensa, dolor abdominal sordo y constipación inicial.

• Semana 2: fiebre en meseta continua (39-40 °C) con **Bradicardia relativa para el nivel térmico (Signo de Faget o disociación esfigmotérmica)**, hepatoesplenomegalia, "manchas rosadas" en abdomen (roséola tífica) y diarrea en puré de arvejas.

• Semana 3: riesgo de complicaciones graves: **perforación ileal en las placas de Peyer** (abdomen agudo) y hemorragia digestiva baja masiva. **(ver Imagen 4.5)**

Diagnóstico: Hemocultivos (positivos en 80-90% en la 1ª semana); Coprocultivo (positivo desde la 2ª-3ª semana); Mielocultivo (el de mayor sensibilidad > 95% incluso con antibióticos previos). El test de Widal no tiene valor confirmatorio actual.

Tratamiento: Ceftriaxona 2 g/día EV por 7 a 14 días (fármaco de elección por alta tasa de curación y clearance bacteriano) o Azitromicina 1 g/día oral por 7 días. El Ciprofloxacino se reserva si se confirma susceptibilidad.



ROSÉOLA TÍFICA

Imagen 4.5

TABLA 4.5 · BACTERIOSIS ZOONÓTICAS: FACTORES DE EXPOSICIÓN Y SIGNOS CARDINALES EUNACOM

1.04.1.004, 1.04.1.017, 1.04.1.012, 2.01.1.013

ENFERMEDAD	AGENTE Y FUENTE DE EXPOSICIÓN	SIGNO CLÍNICO PATOGNOMÓNICO	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Brucelosis	Brucella spp. · Quesos de cabra no pasteurizados	Fiebre ondulante + sudor olor paja + sacroileítis	Doxiciclina + Rifampicina por 6 semanas
Leptospirosis (Weil)	Leptospira · Aguas estancadas y orina de rata	Sufusión conjuntival + dolor pantorrillas + ictericia	Penicilina G sódica EV o Ceftriaxona
Fiebre Tifoidea	Salmonella Typhi · Agua y comida contaminada	Disociación esfigmotérmica (Faget) + roséola tífica	Ceftriaxona EV por 7-14 días o Azitromicina

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.5

Hombre de 42 años, criador de cabras en la precordillera de la Región de Coquimbo, consulta por cuadro de 5 semanas de fiebre vespertina de hasta 38.8 °C con calofríos, astenia severa y sudoración profusa nocturna. Hace 10 días agrega dolor lumbar bajo intenso que se irradia a glúteo derecho y empeora con la marcha. Al examen físico destaca hepatomegalia sensible de 2 cm bajo el reborde costal y dolor exquisito a la maniobra de Fabere en la articulación sacroilíaca derecha. Refiere consumir habitualmente leche y queso de cabra artesanal producido en su predio.

Conducta oficial. El antecedente del consumo habitual de productos lácteos caprinos no pasteurizados en zona rural del norte chico sumado a la clínica de síndrome febril ondulante prolongado con sudoración nocturna y compromiso articular focal lumbar/sacroilíaco (sacroileítis/espondilodiscitis) es la presentación característica de Brucelosis crónica por Brucella melitensis. La confirmación se realiza mediante Rosa de Bengala de tamizaje y aglutinación sérica o hemocultivos en medio Ruiz-Castañeda. La conducta terapéutica ineludible es el tratamiento antimicrobiano combinado prolongado con Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral asociada a Rifampicina 600 a 900 mg al día por un mínimo de 6 semanas continuas para evitar recaídas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Brucelosis: antecedente de consumo de quesos de cabra no pasteurizados; fiebre ondulante y sudoración con olor a paja húmeda.
- Complicación osteoarticular más frecuente de brucelosis: Sacroileítis y Espondilodiscitis lumbar.
- Tratamiento de Brucelosis: Doxiciclina + Rifampicina por 6 semanas completas (biterapia obligatoria).
- Leptospirosis: contacto con aguas estancadas/inundaciones contaminadas con orina de roedores; cursa con sufusión conjuntival y mialgias en pantorrillas.
- Síndrome de Weil: ictericia + falla renal oligúrica hipokalémica + hemorragia pulmonar; tratar con Penicilina G o Ceftriaxona EV.
- Fiebre tifoidea: disociación esfigmotérmica (Signo de Faget: fiebre alta con bradicardia relativa); tratamiento de elección es Ceftriaxona.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Brucelosis y Leptospirosis

1. Un trabajador agrícola de 38 años consulta por fiebre de 39 °C, cefalea intensa y marcado dolor en las pantorrillas de 5 días de evolución, posterior a realizar labores de limpieza en un canal de regadío con aguas estancadas. Al examen se observa ictericia en escleras y marcada inyección conjuntival bilateral sin secreción purulenta (sufusión conjuntival). El laboratorio muestra Bilirrubina total 8.5 mg/dL de predominio directo, Creatinina 3.2 mg/dL y gases con acidosis metabólica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leptospirosis ictérica (Síndrome de Weil)
B) Hepatitis viral aguda tipo A
C) Colangitis aguda supurada
D) Fiebre tifoidea complicada
E) Malaria por Plasmodium vivax

Banco de Preguntas Oficial · Brucelosis y Leptospirosis

2. ¿Cuál es el esquema antibiótico de primera línea recomendado para el tratamiento de la Brucelosis en un paciente adulto inmunocompetente?

A) Ciprofloxacino oral en monoterapia por 14 días
B) Doxiciclina oral asociada a Rifampicina oral durante 6 semanas
C) Amoxicilina / Ácido Clavulánico por 10 días
D) Ceftriaxona intramuscular en dosis única
E) Azitromicina oral por 5 días

Más preguntas online de Bacteriosis Zoonóticas →

4.6. Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.003

¿POR QUÉ?

El carbunco o ántrax es una zoonosis bacteriana mayor causada por Bacillus anthracis con potencial de uso como agente de bioterrorismo. En el EUNACOM se evalúa de forma clásica la identificación visual de la pústula maligna cutánea (escara necrótica negra, indolora y no supurativa rodeada de vesículas y edema no foveolar) y el tratamiento de elección con Ciprofloxacino.

1. AGENTE ETIOLÓGICO Y FACTORES DE VIRULENCIA

Bacillus anthracis es un bacilo Gram positivo formador de esporas, aerobio o anaerobio facultativo, encapsulado e inmóvil. 1.04.1.003
Sus esporas son extremadamente resistentes al calor, desecación y desinfectantes químicos comunes, permaneciendo viables en el suelo durante décadas.

Posee dos factores de virulencia mayores codificados en plásmidos:
• Cápsula antifagocítica de ácido poli-D-glutámico.
• Complejo exotoxínico tripartito compuesto por: **Antígeno Protector (PA)**, **Factor Edematógeno (EF**, adenilato ciclasa que causa edema masivo) y **Factor Letal (LF**, metaloproteinasa que induce necrosis tisular y colapso macrofágico).

2. FORMAS CLÍNICAS: CARBUNCO CUTÁNEO VS CARBUNCO POR INHALACIÓN

• **Carbunco Cutáneo ("Pústula maligna" - 95% de los casos):** se adquiere por inoculación de esporas a través de microtraumatismos en la piel de personas en contacto con ganado (bovino, ovino, caprino) o productos animales contaminados (lana, cueros, huesos). 1.04.1.003
Comienza como una pápula pruriginosa indolora que evoluciona a una vesícula y luego a una **úlcera necrótica con escara negra central ("carbón") rodeada de una corona de vesículas y edema gelatinoso circundante no foveolar muy extenso**. Es **TÍPICAMENTE INDOLORA Y NO PRODUCE PUS** (a menos que sufra sobreinfección bacteriana secundaria).
• **Carbunco Respiratorio o por Inhalación ("Enfermedad de los cardadores de lana"):** inhalación de bioaerosoles de esporas. Cursa como un cuadro gripal que evoluciona bruscamente a disnea fulminante, cianosis y shock tóxico. Radiografía de tórax patognomónica: **ensanchamiento mediastínico marcado** secundario a linfadenitis y mediastinitis hemorrágica necrotizante. **(ver Imagen 4.6)**



Carbunco inhalatorio



Loxoscelismo cutáneo



Ectima gangrenoso

3. DIAGNÓSTICO Y TERAPIA ANTIMICROBIANA

Confirmación: Gram de la lesión vesicular o cultivo (bacilos Gram positivos en caña de bambú) y confirmación por PCR en el Instituto de Salud Pública (ISP). Notificación inmediata obligatoria. 1.04.1.003

Tratamiento de elección: Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h oral (o Levofloxacino) por 60 días, o **Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral**. En el carbunco sistémico/respiratorio se utiliza triterapia EV (Ciprofloxacino + Clindamicina + Meropenem). NUNCA realizar desbridamiento quirúrgico de la escara cutánea, ya que la manipulación mecánica favorece la diseminación bacteriana y bacteriemia letal.



CARBUNCO CUTÁNEO

Imagen 4.6

TABLA 4.6 · CARBUNCO CUTÁNEO VS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE ESCARAS NEGRAS 1.04.1.003

PATOLOGÍA	AGENTE CAUSAL	CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN	DOLOR LOCAL
Ántrax (Carbunco)	Bacillus anthracis	Escara negra seca con vesículas y gran edema	Típicamente INDOLORA y sin pus
Aracnoidismo cutáneo	Loxosceles laeta (araña de rincón)	Placa livedoide violácea con necrosis y flictena	Intensamente dolorosa (quemante)
Ectima gangrenoso	Pseudomonas aeruginosa	Úlcera necrótica con halo eritematoso en neutropénico	Dolor moderado a severo
Tularemia	Francisella tularensis	Úlcera dolorosa asociada a gran adenopatía supurada	Muy dolorosa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.6

Hombre de 52 años, curtidor de cueros y lanares en una estancia rural, consulta por una lesión en el antebrazo derecho de 5 días de evolución. Refiere que inició como una picadura que no le dolía y que fue aumentando de volumen. Al examen físico se aprecia una placa ulcerada central de 2 cm cubierta por una escara negruzca seca, rodeada por un anillo de pequeñas vesículas serosas y un extenso halo de edema duro que compromete todo el antebrazo. La lesión es completamente indolora a la palpación y no presenta exudado purulento. El paciente está afebril y en buenas condiciones generales.

Conducta oficial. El antecedente ocupacional de manipulación de cueros y lanas sin procesar sumado al hallazgo físico clásico de una escara necrótica negruzca central seca, rodeada de vesículas y un extenso edema no foveolar ("gelatinoso") que es típicamente INDOLORA y no supurativa, es patognomónico de Carbunco Cutáneo (Ántrax) por Bacillus anthracis. La conducta correcta es tomar muestra del líquido de las vesículas para tinción de Gram y cultivo/PCR, notificar de inmediato a la SEREMI de Salud (ENO inmediata) e iniciar tratamiento antimicrobiano de primera línea con Ciprofloxacino oral (500 mg cada 12 horas) durante 60 días. Se debe enfatizar la contraindicación absoluta de realizar aseo quirúrgico o curetaje de la escara.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Ántrax (Bacillus anthracis): bacilo Gram positivo esporulado; transmisión por contacto con ganado o cueros/lanas.
- Pústula maligna cutánea: escara necrótica negra central rodeada de vesículas y edema masivo.
- Signo clave: la lesión de carbunco cutáneo es TÍPICAMENTE INDOLORA y NO supurativa (sin pus).
- Carbunco por inhalación: mediastinitis hemorrágica con ensanchamiento mediastínico en radiografía de tórax.
- Antibiótico de primera línea: Ciprofloxacino oral (o Doxiciclina) por 60 días.
- Contraindicación formal: NO realizar desbridamiento quirúrgico de la lesión por riesgo de bacteriemia sistémica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Ántrax

1. Un trabajador de una fábrica procesadora de cueros importados consulta por una lesión en el dorso de la mano izquierda de 4 días de evolución. Al examen se observa una escara negruzca central de consistencia dura, rodeada por vesículas con líquido claro y un marcado edema indurado en toda la mano, sin dolor a la palpación ni secreción purulenta. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?

A) Ciprofloxacino oral
B) Cefazolina endovenosa
C) Flucloxacilina oral
D) Aciclovir tópico
E) Corticoides sistémicos a dosis altas

Banco de Preguntas Oficial · Ántrax

2. ¿Cuál de las siguientes conductas está formalmente CONTRAINDICADA en el manejo de una lesión cutánea sospechosa de carbunco (ántrax) por Bacillus anthracis?

A) Toma de frotis de líquido vesicular para tinción de Gram
B) Desbridamiento y resección quirúrgica amplia de la escara necrótica
C) Notificación obligatoria inmediata a la autoridad sanitaria
D) Inicio precoz de tratamiento con quinolonas
E) Aislamiento de contacto del paciente con la lesión cubierta

Más preguntas online de Ántrax →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.6

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)	Reservorio de Hantavirus en Chile: Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga)...	**Tríada de sospecha en hemograma: Trombocitopenia + Hemoconcentración (Hto alto) +...**	Regla terapéutica de oro: MANEJO RESTRICTIVO DE FLUIDOS para evitar inundación alveolar...
Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica	Vía de transmisión más frecuente actual en Chile: vertical / congénita transplacentaria.	**Tamizaje prenatal con serología IgG: universal y obligatorio en zonas endémicas (desde...**	Tratamiento de elección: Nifurtimox o Benznidazol por 60 días (contraindicados en el...
Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	Dengue: dolor retroorbitario + mialgias severas ("quebrantahuesos") + exantema con...	**Signos de alarma de Dengue: dolor abdominal persistente, vómitos, sangrado mucoso...**	En Dengue están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS los AINEs y la Aspirina por riesgo de...
Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	Hidatidosis: el perro es el hospedero definitivo; el humano se contagia al ingerir...	**Quiste hidatídico hepático: imagen ecográfica clásica de membranas desprendidas (Signo...**	—
Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Brucelosis: antecedente de consumo de quesos de cabra no pasteurizados; fiebre...	**Complicación osteoarticular más frecuente de brucelosis: Sacroileítis y...**	El antecedente del consumo habitual de productos lácteos caprinos no pasteurizados en...
Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)	Ántrax (Bacillus anthracis): bacilo Gram positivo esporulado; transmisión por contacto...	**Pústula maligna cutánea: escara necrótica negra central rodeada de vesículas y edema...**	Contraindicación formal: NO realizar desbridamiento quirúrgico de la lesión por riesgo...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Reservorio de Hantavirus en Chile: Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga); contagio por inhalación de orina/heces...

Tríada de sospecha en hemograma: Trombocitopenia + Hemoconcentración (Hto alto) + Inmunoblastos > 10%.

Mialgias muy intensas con predilección por muslos y región lumbar.

Regla terapéutica de oro: MANEJO RESTRICTIVO DE FLUIDOS para evitar inundación alveolar por fuga capilar.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Tríada de sospecha en hemograma: Trombocitopenia + Hemoconcentración (Hto alto) + Inmunoblastos > 10%.
- Mialgias muy intensas con predilección por muslos y región lumbar.
- Tamizaje prenatal con serología IgG: universal y obligatorio en zonas endémicas (desde O'Higgins al norte).
- Diagnóstico en recién nacido / fase aguda: método PARASITOLÓGICO DIRECTO (microhematocrito) o PCR.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Reservorio de Hantavirus en Chile: Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga); contagio por inhalación de...	Tema 4.1 →
Vía de transmisión más frecuente actual en Chile: vertical / congénita transplacentaria.	Tema 4.2 →
Dengue: dolor retroorbitario + mialgias severas ("quebrantahuesos") + exantema con islas de piel sana.	Tema 4.3 →
Hidatidosis: el perro es el hospedero definitivo; el humano se contagia al ingerir huevos de las heces caninas.	Tema 4.4 →
Brucelosis: antecedente de consumo de quesos de cabra no pasteurizados; fiebre ondulante y sudoración con olor a...	Tema 4.5 →
Ántrax (Bacillus anthracis): bacilo Gram positivo esporulado; transmisión por contacto con ganado o cueros/lanas.	Tema 4.6 →

MANUAL EUNACOM DE INFECTOLOGÍA

BLOQUE 05 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

05

BLOQUE TEMÁTICO
6 clases

INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

6	23	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
5.1	Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis	80
5.2	Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH	84
5.3	Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki	88
5.4	Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster	93
5.5	Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	97
5.6	Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)	100

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.1.006, 6.01.2.003, 4.01.1.055, 2.01.1.011, 1.04.5.001, 6.01.1.021, 6.01.2.002, 6.01.4.003	Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis	Específico	Completo	Completo
1.04.1.025, 2.01.1.016, 2.01.1.127, 2.01.1.018, 2.01.1.030, 1.04.4.010	Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH	Específico	Completo	Completo
2.01.1.009, 2.01.1.008, 2.01.1.058	Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki	Específico	Completo	Completo
1.04.1.011, 1.04.2.010, 6.01.2.007	Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster	Específico	Completo	Completo
1.04.1.020, 1.04.1.019, 2.01.1.034, 1.04.1.024	Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	Específico	Inicial	Derivar
1.04.1.016, 1.04.1.029, 2.01.2.144	Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 05 · INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
23 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Erisipela: dermis superficial; Streptococcus pyogenes; placa rojo vivo con BORDES NETOS SOBREELEVADOS.
- Celulitis: tejido celular subcutáneo profundo; S. aureus y S. pyogenes; eritema con BORDES DIFUSOS Y MAL DELIMITADOS.
- Siempre buscar la puerta de entrada: tinea pedis interdigital (intertrigo micótico) es la causa más común de celulitis de extremidades.
- Conducta obligatoria: marcar con lápiz los bordes de la lesión para evaluar progresión o regresión objetiva.
- Tratamiento oral de elección en Chile: Cefadroxilo (o Cefalexina o Flucloxacilina) por 7 a 10 días.
- Si se sospecha SAMR comunitario (abscesos, forúnculos recurrentes, fracaso de betalactámicos): usar Cotrimoxazol o Clindamicina.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis	EUNACOM Julio 2025 · #111 · EUNACOM Diciembre 2025 · #55 · EUNACOM Diciembre 2024 · #74 · EUNACOM Enero 2023 · #28
Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH	EUNACOM Diciembre 2025 · #54 · EUNACOM Julio 2025 · #18 · EUNACOM Diciembre 2025 · #68 · EUNACOM Diciembre 2025 · #153
Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki	EUNACOM Julio 2025 · #13 · EUNACOM Diciembre 2025 · #136 · EUNACOM Julio 2025 · #11 · EUNACOM Diciembre 2025 · #135
Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster	EUNACOM Enero 2023 · #116 · EUNACOM Diciembre 2022 · #170 · EUNACOM Julio 2019 · #158 · EUNACOM Diciembre 2018 · #127
Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	EUNACOM Diciembre 2025 · #58 · EUNACOM Julio 2019 · #132 · EUNACOM Diciembre 2018 · #124 · EUNACOM Julio 2017 · #40
Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19	EUNACOM Agosto 2021 · #36 · EUNACOM Julio 2015 · #141 · EUNACOM Julio 2013 · #156

5.1. Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.006 | 6.01.2.003 | 4.01.1.055 | 2.01.1.011 | 1.04.5.001 | 6.01.1.021 | 6.01.2.002 | 6.01.4.003

¿POR QUÉ?

Las infecciones bacterianas de piel y partes blandas son motivo de consulta diario en atención primaria y urgencias. En el EUNACOM se evalúa de manera constante la discriminación clínica entre erisipela (superficial, bordes netos sobreelevados, Streptococcus pyogenes) y celulitis (profunda, bordes mal definidos, Staphylococcus aureus), así como la elección del antibiótico antiestafilocócico de primera línea.

1. ERISIPELA VS CELULITIS: FISIOPATOLOGÍA Y PROFUNDIDAD ANATÓMICA

• **Erisipela:** infección bacteriana superficial que compromete la **dermis superior y los vasos linfáticos superficiales**. El agente causal casi exclusivo (> 90%) es *Streptococcus pyogenes* (Estreptococo betahemolítico grupo A). Clínicamente se caracteriza por una placa eritematosa de color rojo brillante, caliente, indurada ("en piel de naranja"), con **BORDES NETOS BIEN DELIMITADOS Y SOBREELEVADOS** que la diferencian claramente de la piel sana. Es de inicio súbito, con fiebre alta y calofríos precoces. Localizaciones típicas: extremidades inferiores y cara (mejillas en alas de mariposa). 1.04.1.006 6.01.2.003 2.01.1.011

• **Celulitis:** infección más profunda que compromete la **dermis profunda y el tejido celular subcutáneo**. Los agentes etiológicos son *Staphylococcus aureus* (meticilino-sensible o resistente SAMR) y *Streptococcus pyogenes*. Clínicamente se presenta con eritema, calor local y edema con fóvea, pero con **BORDES DIFUSOS, MAL DELIMITADOS Y NO SOBREELEVADOS**. Suele haber una puerta de entrada identificable (micosis interdigital por tinea pedis, úlcera venosa, traumatismo menor o picadura). **(ver Imagen 5.1A y B)**

2. INFECCIONES DEL FOLÍCULO PILOSO: FOLICULITIS, FORÚNCULO Y ÁNTRAX ESTAFILOCÓCICO

Producidas casi siempre por *Staphylococcus aureus*: 4.01.1.055

• **Foliculitis:** inflamación superficial circunscrita al ostium folicular con pequeña pústula indolora centrada en un vello. Tratamiento: aseo local con jabón de clorhexidina o mupirocina tópica al 2%. (Si antecedente de baño en hidromasaje o piscina temperada pensar en *Pseudomonas aeruginosa* "foliculitis de las tinas calientes", autolimitada). 2.01.1.011 1.04.5.001 6.01.1.021

• **Forúnculo:** nódulo inflamatorio profundo, muy doloroso y eritematoso que involucra todo el folículo piloso y el tejido perifolicular adyacente, con posterior necrosis central y salida de pus ("clavo"). Tratamiento: calor local y drenaje espontáneo o quirúrgico; antibióticos sistémicos solo si hay celulitis perilesional o signos sistémicos.

• **Carbunco estafilocócico / Ántrax benigno (furunculosis múltiple):** conglomerado coalescente de múltiples forúnculos interconectados por tractos fistulosos en el tejido subcutáneo, típicamente en la nuca o espalda de pacientes diabéticos. Exige drenaje quirúrgico y antibióticos EV.



Foliculitis



Forúnculo / ántrax estafilocócico

3. TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: DEL MANEJO AMBULATORIO A LA HOSPITALIZACIÓN

Regla de oro de delimitación: ante toda sospecha de celulitis o erisipela, se debe **delimitar con lápiz marcador indeleble el borde del eritema** para monitorizar objetivamente la respuesta clínica a las 24 y 48 horas. 1.04.1.006 6.01.2.003 2.01.1.011

Esquemas ambulatorios (vía oral por 7 a 10 días):

• **Cefadroxilo oral (500 mg c/12h) o Cefalexina (500 mg c/6h) o Flucloxacilina (500 mg c/8h):** fármacos de primera línea en Chile (cubren tanto S. aureus como S. pyogenes).

• **Alergia a betalactámicos:** Clindamicina (300 mg c/8h oral) o Cotrimoxazol forte (1 comp c/12h oral si sospecha de SAMR comunitario).

Criterios de hospitalización y terapia endovenosa (Cefazolina 1 g c/8h EV o Cloxacilina 1-2 g c/4-6h EV): toxicidad sistémica (SIRS/sepsis), progresión rápida a pesar de antibióticos orales por 48 horas, comorbilidades descompensadas (diabetes, cirrosis, inmunosupresión) o celulitis facial por riesgo de trombosis del seno cavernoso.

4. ÁNTRAX ESTAFILOCÓCICO, PIODERMIAS, GRAM Y CULTIVO, Y DRENAJE DE ABSCESOS

Ántrax estafilocócico: infección profunda de varios folículos vecinos (conglomerado de forúnculos) con drenaje por múltiples orificios, en nuca, espalda y muslos de diabéticos y obesos; da fiebre y compromiso general. Se trata con **drenaje quirúrgico y antibiótico** (cloxacilina o cefadroxilo; si hay sospecha de SAMR, TMP-SMX, clindamicina o doxiciclina). No confundir con el carbunco por *B. anthracis* (escara negra indolora, Tema 4.6). Otras piodermias: **impétigo** (mupirocina tópica; cefadroxilo si es extenso), ectima, paroniquia, **hidradenitis supurativa** (nódulos dolorosos recurrentes en axila, ingle y submamario; clindamicina + rifampicina, derivar) y síndrome de piel escaldada estafilocócica (niños, signo de Nikolsky). Las piodermias estreptocócicas pueden complicarse con glomerulonefritis. **(ver Imagen 5.1C)** 6.01.2.002 6.01.1.021

Gram y cultivo de lesiones cutáneas: están indicados cuando hay **pus o absceso**, mal resultado del antibiótico, sospecha de SAMR, inmunosupresión o enfermedad sistémica; en la celulitis sin pus el cultivo de la piel es poco rentable (se piden hemocultivos si hay fiebre). La muestra se toma del pus aspirado o del contenido del absceso, no de una costra superficial colonizada. El Gram orienta: cocos grampositivos en **racimos** (*Staphylococcus*), en **cadenas** (*Streptococcus*), bacilos gramnegativos (pie diabético, *Pseudomonas*); el cultivo con antibiograma identifica la resistencia a oxacilina (SAMR). Se interpreta junto con la clínica: un cultivo de herida sin signos de infección es colonización y no se trata. 6.01.4.003

Drenaje de absceso superficial (nivel «realizar»): el drenaje 1.04.5.001 es el **tratamiento principal**. Se indica ante fluctuación (eco si hay duda; no drenar una masa pulsátil). Técnica: consentimiento, antisepsia, anestesia local con lidocaína infiltrada alrededor, **incisión lineal amplia sobre el punto más fluctuante** siguiendo las líneas de tensión, romper las lóculos con pinza, evacuar el pus (enviar cultivo), irrigar y dejar una mecha o taponamiento por 24–48 h, con curaciones diarias. Se agrega antibiótico si hay celulitis extensa (> 5 cm), fiebre o SIRS, inmunosupresión, diabetes, abscesos múltiples o localización en cara, manos o genitales. Se verifica la profilaxis antitetánica.



A. ERISIPELA



B. CELULITIS



C. IMPÉTIGO

Imagen 5.1

TABLA 5.1 · ERISIPELA VS CELULITIS: CUADRO COMPARATIVO EUNACOM

1.04.1.006, 6.01.2.003, 4.01.1.055, 2.01.1.011, 1.04.5.001, 6.01.1.021, 6.01.2.002, 6.01.4.003

CARACTERÍSTICA	ERISIPELA	CELULITIS
Profundidad anatómica	Dermis superficial y linfáticos	Dermis profunda y tejido celular subcutáneo
Etiología principal	Streptococcus pyogenes (> 90%)	Staphylococcus aureus y S. pyogenes
Bordes de la lesión	BORDES NETOS, bien delimitados y sobreelevados	BORDES DIFUSOS, irregulares y mal definidos
Inicio de los síntomas	Brusco y agudo, con fiebre alta precoz	Insidioso y progresivo en 24 a 48 horas
Puerta de entrada	A menudo imperceptible o maceración retroauricular	Tinea pedis, úlcera, laceración cutánea visible
Tratamiento oral 1ª línea	Penicilina oral o Cefadroxilo / Flucloxacilina	Cefadroxilo o Cefalexina o Flucloxacilina

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.1

Mujer de 58 años, portadora de linfedema crónico en extremidad inferior derecha secundario a safenectomía, consulta por cuadro de inicio súbito hace 12 horas de calofríos intensos, fiebre de 39 °C y dolor ardiente en la pierna afectada. Al examen físico se aprecia en la cara anterior de la pierna derecha una placa eritematosa extensa de color rojo brillante, indurada y dolorosa, con bordes perfectamente nítidos y sobreelevados que la diferencian con claridad de la piel sana adyacente. No se palpan colecciones ni fluctuación.

Conducta oficial. El cuadro clínico de placa eritematosa de color rojo fuego, indurada y con bordes netos, claramente delimitados y sobreelevados, de inicio brusco con fiebre alta y calofríos en una paciente con factor predisponente clásico (linfedema), es patognomónico de Erisipela por Streptococcus pyogenes. La conducta médica inmediata es delimitar el borde con marcador, iniciar reposo con extremidad elevada y administrar tratamiento antimicrobiano antiestreptocócico: en pacientes ambulatorios Cefadroxilo oral (o Penicilina V o Flucloxacilina); si presenta mala tolerancia oral o compromiso del estado general, se indica hospitalización para Cefazolina o Penicilina G sódica EV.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Erisipela: dermis superficial; Streptococcus pyogenes; placa rojo vivo con BORDES NETOS SOBREELEVADOS.
- Celulitis: tejido celular subcutáneo profundo; S. aureus y S. pyogenes; eritema con BORDES DIFUSOS Y MAL DELIMITADOS.
- Siempre buscar la puerta de entrada: tinea pedis interdigital (intertrigo micótico) es la causa más común de celulitis de extremidades.
- Conducta obligatoria: marcar con lápiz los bordes de la lesión para evaluar progresión o regresión objetiva.
- Tratamiento oral de elección en Chile: Cefadroxilo (o Cefalexina o Flucloxacilina) por 7 a 10 días.
- Si se sospecha SAMR comunitario (abscesos, forúnculos recurrentes, fracaso de betalactámicos): usar Cotrimoxazol o Clindamicina.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Infección de Piel y Partes Blandas

1. Una mujer de 64 años consulta por fiebre de 38.6 °C y dolor en la pierna izquierda. Al examen se observa una placa eritematosa caliente en la cara anteromedial de la pierna, con bordes sobreelevados, nítidos y bien delimitados respecto a la piel sana circundante. ¿Cuál es el microorganismo causal más probable?

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Streptococcus pyogenes
C) Staphylococcus epidermidis
D) Clostridium perfringens
E) Escherichia coli

Banco de Preguntas Oficial · Infección de Piel y Partes Blandas

2. ¿Cuál de los siguientes esquemas antimicrobianos por vía oral es el de primera línea para el tratamiento ambulatorio de una celulitis no complicada de extremidad inferior en un paciente adulto sin alergias?

A) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas
B) Cefadroxilo 500 mg cada 12 horas
C) Metronidazol 500 mg cada 8 horas
D) Gentamicina oral 80 mg cada 8 horas
E) Doxiciclina 100 mg cada 24 horas

Más preguntas online de Infecciones de Piel Comunitarias →

5.2. Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.025 | 2.01.1.016 | 2.01.1.127 | 2.01.1.018 | 2.01.1.030 | 1.04.4.010

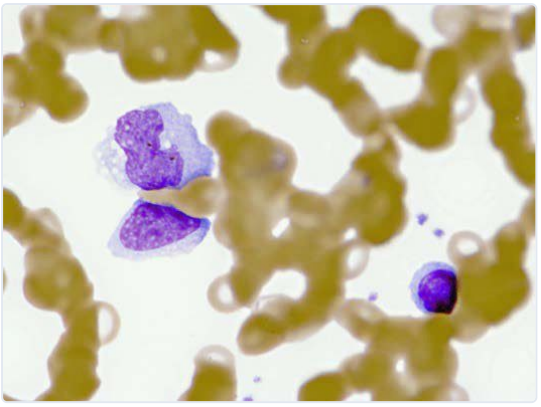
¿POR QUÉ?

El Síndrome Mononucleósico es la causa clásica de faringoamigdalitis exudativa refractaria con adenopatías y esplenomegalia en jóvenes. En el EUNACOM se evalúa de manera casi obligada el exantema inducido por amoxicilina (que simula alergia), la serología para Virus Epstein-Barr (anticuerpos heterófilos / IgM VCA) y el diagnóstico diferencial con CMV, Toxoplasma y Síndrome Retroviral Agudo (VIH primario).

1. MONONUCLEOSIS INFECCIOSA POR VIRUS EPSTEIN-BARR (VEB)

El Virus Epstein-Barr (herpesvirus tipo 4) se transmite a través de la saliva ("enfermedad del beso"). Infecta los linfocitos B en la orofaringe a través del receptor CD21, induciendo su proliferación desregulada. 1.04.1.025 | 2.01.1.016

La respuesta inmune del huésped es ejecutada masivamente por **linfocitos T CD8+ citotóxicos reactivos**, los cuales se observan en el hemograma como los característicos **Linfocitos Atípicos o de Downey (> 10%** del frotis). 1.04.1.025 | 2.01.1.016 | 1.04.4.010



Frotis con linfocitos atípicos

Tríada clínica cardinal: (1) Fiebre alta prolongada (1 a 3 semanas), (2) **Faringoamigdalitis exudativa con placas blanquecinas bilaterales indistinguible clínicamente de la estreptocócica**, y (3) **Poliadenopatías cervicales posteriores simétricas y dolorosas** (a diferencia del estreptococo que compromete la cadena anterior submandibular). Se asocia a **Esplenomegalia** (50-60%) y hepatomegalia con leve elevación de transaminasas. 1.04.1.025 | 2.01.1.016 | 2.01.1.030

La trampa clásica del EUNACOM (Erupción por Aminopenicilinas): si un paciente con mononucleosis es erróneamente diagnosticado de amigdalitis estreptocócica y tratado con **Amoxicilina o Ampicilina**, el 90-100% de los casos desarrolla a los 5-7 días un **exantema maculopapular eritematoso difuso pruriginoso**. Este fenómeno es una reacción inmunológica mediada por inmunocomplejos transitoria; *NO constituye una verdadera alergia a betalactámicos*. **(ver Imagen 5.2A y B)** 1.04.1.025 | 2.01.1.016

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME MONONUCLEÓSICO

• **Citomegalovirus (CMV):** es la **causa número uno de síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos NEGATIVOS**. Cursa típicamente como un "síndrome febril prolongado aislado (tifoideo)" en adultos jóvenes, con escasa o nula faringitis y mínimas adenopatías. 1.04.1.025 | 2.01.1.018

• **Toxoplasmosis aguda:** predomina el compromiso ganglionar cervical indoloro aislado en paciente expuesto a gatos o ingesta de carnes crudas. 1.04.1.025 | 2.01.1.030

• **Síndrome Retroviral Agudo (VIH primario):** se presenta 2 a 4 semanas tras la exposición sexual de riesgo con fiebre, faringitis, adenopatías y **úlceras mucocutáneas orales o genitales muy dolorosas**. 1.04.1.025

3. COMPLEJO TORCH PERINATAL

Acrónimo de infecciones congénitas perinatales: **T**oxoplasma, **O**tros (Sífilis, Chagas, Varicela, Parvovirus B19), **R**ubéola, **C**itomegalovirus y **H**erpes simple. 2.01.1.127

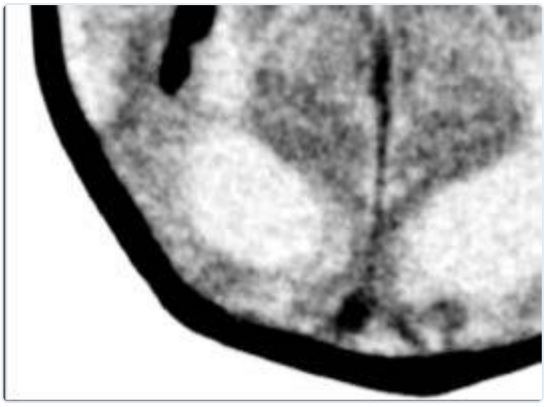
Comparten clínica neonatal: restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), hepatoesplenomegalia, ictericia a predominio directo, microcefalia y púrpura trombocitopénica ("aspecto en muffin de arándanos").

Hallazgos patognomónicos de memoria EUNACOM:

• **CMV congénito: calcificaciones periventriculares**, microcefalia y es la causa #1 de **hipoacusia neurosensorial congénita no hereditaria**.

• **Toxoplasmosis congénita (Tétrada de Sabin): calcificaciones intracraneales difusas**, hidrocefalia, coriorretinitis y convulsiones.

• **Rubéola congénita (Tríada de Gregg): catarata congénita**, hipoacusia neurosensorial y cardiopatía congénita (**Ductus Arterioso Persistente - DAP**). **(ver Imagen 5.2C)**



TAC cerebral neonatal

4. HEMOGRAMA, ADENOPATÍAS Y SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO

Hemograma y VHS en infecciosas: linfocitosis con linfocitos atípicos (> 10 %) sugiere mononucleosis o CMV; **leucocitosis con neutrofilia y desviación a izquierda** (> 15.000/mm³) sugiere infección bacteriana; la leucopenia/neutropenia se ve en virosis, tifoidea, brucelosis y sepsis grave; la **eosinofilia** sugiere parasitosis tisulares (triquinosis, hidatidosis, estrongiloidiasis); la trombocitopenia, dengue, malaria o sepsis. La VHS es inespecífica: valores > 100 mm/h orientan a endocarditis, TBC, osteomielitis, vasculitis, mieloma o neoplasia; la PCR sube y baja más rápido y sirve para seguir la respuesta. 1.04.4.010

Enfoque de las adenopatías: son patológicas si miden > 1 cm (epitroclear > 0,5 cm, inguinal > 1,5 cm). Localizada vs generalizada; **blanda, dolorosa y móvil** orienta a infección reactiva (viral, estreptocócica, *Bartonella*, TBC); **dura, indolora, adherida o supraclavicular** orienta a linfoma o metástasis. Se investiga fiebre, sudoración, baja de peso, contacto con gatos, TBC y viajes, se examina hígado y bazo y se pide hemograma, VHS/PCR, serologías (EBV, CMV, VIH, toxoplasma) y Rx de tórax. Si es localizada y benigna se observa 2–4 semanas; se hace **biopsia** si es > 2 cm, crece, es dura o supraclavicular, persiste más de 4–6 semanas o se asocia a síntomas B o masa mediastínica (sin corticoides previos). Se deriva. 2.01.1.030

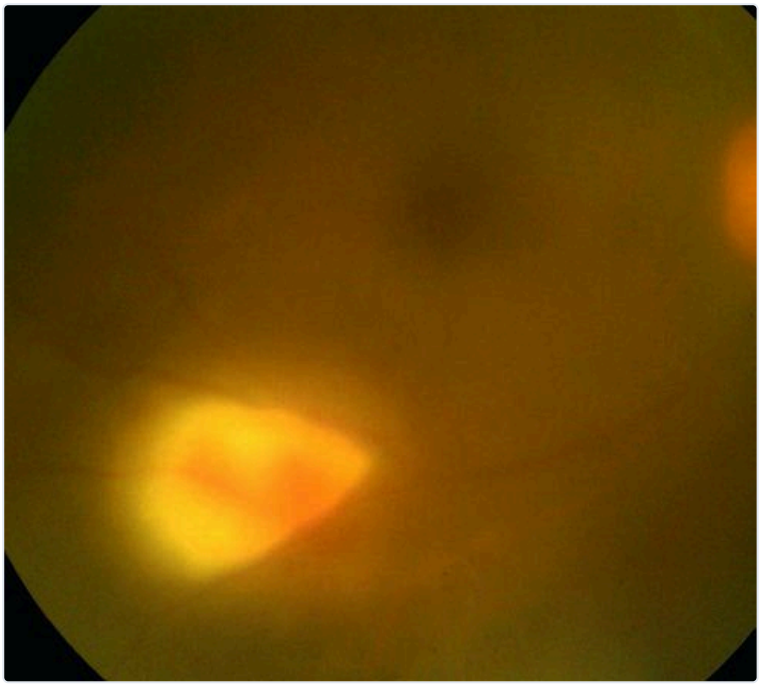
Síndrome febril prolongado (fiebre > 14 días en el niño, > 3 semanas con estudio ambulatorio negativo en el adulto): las causas son infecciones (CMV, EBV, TBC, endocarditis, abscesos ocultos, brucelosis, osteomielitis), enfermedades del tejido conectivo (Still, LES, Kawasaki, vasculitis), neoplasias (leucemia, linfoma) y fármacos. Estudio escalonado: historia detallada (viajes, animales, fármacos, contactos), examen repetido, hemograma, VHS/PCR, perfil hepático, sedimento y urocultivo, **hemocultivos × 3**, Rx de tórax, PPD, serologías y ecografía abdominal. **No se inician antibióticos ni corticoides empíricos** sin diagnóstico; se deriva a infectología o pediatría si persiste. El CMV es una causa frecuente y benigna en el inmunocompetente. 2.01.1.018



A. AMIGDALITIS



B. EXANTEMA POR AMOXICILINA



C. CORIORRETINITIS

Imagen 5.2

TABLA 5.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DEL SÍNDROME MONONUCLEÓSICO

1.04.1.025, 2.01.1.016, 2.01.1.127, 2.01.1.018, 2.01.1.030, 1.04.4.010

ETIOLOGÍA	ANTICUERPOS HETERÓFILOS	FARINGITIS Y ADENOPATÍAS	PERLA DISTINTIVA DE EXAMEN
Virus Epstein-Barr (VEB)	POSITIVOS (Paul-Bunnell / Monotest)	Faringitis exudativa + ganglios posteriores	Exantema tras recibir Amoxicilina (95%)
Citomegalovirus (CMV)	NEGATIVOS	Faringitis mínima o ausente	Causa #1 mononucleosis heterófilos (-)
Toxoplasma gondii	NEGATIVOS	Adenopatías cervicales no dolorosas	Exposición a heces de gatos o carnes crudas
VIH primario (SRA)	NEGATIVOS	Faringitis moderada + adenopatías	Úlceras mucosas orales dolorosas + rash

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.2

Joven de 19 años consulta por fiebre de 38.5 °C, dolor faríngeo intenso y astenia de 6 días. Fue evaluado en un centro ambulatorio hace 3 días donde se le diagnosticó amigdalitis aguda y se le indicó Amoxicilina oral 500 mg cada 8 horas. Tras la cuarta dosis presenta un exantema maculopapular eritematoso difuso no pruriginoso en tronco y extremidades. Al examen: faringe congestiva con grandes exudados blanquecinos amigdalinos confluentes, múltiples adenopatías laterocervicales posteriores y submandibulares sensibles de 2 cm, y bazo palpable a 3 cm bajo el reborde costal.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a un Síndrome Mononucleósico por Virus Epstein-Barr (VEB) con aparición del clásico exantema post-amoxicilina. La combinación de faringoamigdalitis exudativa con adenopatías de la cadena cervical posterior y esplenomegalia es el patrón típico de la mononucleosis infecciosa. La administración de aminopenicilinas en pacientes con VEB gatilla casi invariablemente un rash maculopapular autolimitado que no constituye una verdadera alergia anafiláctica a la penicilina. La conducta correcta es suspender la amoxicilina, solicitar hemograma (que revelará linfocitos atípicos > 10%) y prueba de anticuerpos heterófilos (Monotest) o serología IgM anti-VCA, e indicar reposo relativo estricto por 3 a 4 semanas sin deportes de contacto por el riesgo vital de rotura esplénica traumática.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Mononucleosis por VEB: faringitis con exudado + adenopatías cervicales posteriores + esplenomegalia.
- Laboratorio: leucocitosis con predominio mononuclear y LINFOCITOS ATÍPICOS > 10% en el frotis.
- Exantema maculopapular tras recibir Amoxicilina: inducido por VEB en > 90%; no es alergia permanente.
- Recomendación crítica: PROHIBIDOS deportes de contacto por 3 a 4 semanas por riesgo de rotura esplénica.
- Causa más frecuente de mononucleosis con anticuerpos heterófilos negativos: Citomegalovirus (CMV).
- TORCH: CMV produce calcificaciones periventriculares e hipoacusia; Toxoplasma produce calcificaciones difusas y coriorretinitis.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Síndrome Mononucleósico

1. Un universitario de 20 años presenta fiebre de 39 °C, disfagia intensa y astenia de una semana. Se le diagnosticó faringitis estreptocócica hace 3 días y se le administró amoxicilina, presentando al segundo día un exantema eritematoso maculopapular generalizado. Al examen físico destaca faringe con placas pultáceas, adenopatías cervicales posteriores bilaterales y esplenomegalia palpable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Shock anafiláctico secundario a penicilina
B) Mononucleosis infecciosa por Virus Epstein-Barr
C) Escarlatina por Streptococcus pyogenes
D) Infección aguda por Citomegalovirus
E) Lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos

Banco de Preguntas Oficial · Complejo TORCH

2. Un recién nacido de 5 días de vida presenta microcefalia, ictericia y hepatoesplenomegalia. La ecografía transfontanelar revela calcificaciones periventriculares y el examen auditivo demuestra hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. ¿Cuál es el agente etiológico congénito más probable?

A) Toxoplasma gondii
B) Citomegalovirus (CMV)
C) Treponema pallidum
D) Virus de la Rubéola
E) Virus Herpes Simplex tipo 2

Más preguntas online de Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH →

5.3. Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.009 2.01.1.008 2.01.1.058

¿POR QUÉ?

El diagnóstico diferencial de los exantemas febriles en la infancia es uno de los temas pediátricos/infectológicos más evaluados en el EUNACOM. La clave radica en reconocer los enantemas patognomónicos, el patrón de progresión del rash (céfalo-caudal vs centrípeto) y la identificación de la Enfermedad de Kawasaki para prevenir aneurismas coronarios con gammaglobulina.

1. SARAMPIÓN VS RUBÉOLA: ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

• **Sarampión (Paramixovirus - Notificación Obligatoria Inmediata):** transmisión aérea de altísima contagiosidad (R0 12-18). Pródromos con fiebre alta, tos perruna, coriza acuosa intensa y conjuntivitis con fotofobia severa ("facies gripal llorosa"). Enantema patognomónico: **Manchas de Koplik** (pápulas blanquecinas milimétricas en la mucosa yugal frente al segundo molar superior, preceden al exantema en 24-48 h). Exantema: maculopapular confluente de inicio retroauricular con **progresión céfalo-caudal lenta**, que descama en láminas finas ("en salvado") dejando pigmentación parduzca. 1.04.1.011 2.01.1.009

• **Rubéola (Togavirus - Notificación Inmediata):** cuadro mucho más leve. Pródromos escasos con **adenopatías retroauriculares, suboccipitales y cervicales posteriores muy dolorosas**. Exantema: máculas rosadas no confluentes de rápida progresión céfalo-caudal que desaparece en 3 días ("sarampión de 3 días"). Enantema: **Manchas de Forchheimer** (petequias en el paladar blando). **(ver Imagen 5.3A y B)**

2. ESCARLATINA Y ERITEMA INFECCIOSO (MEGALOERITEMA)

• **Escarlatina (*Streptococcus pyogenes* productor de exotoxina pirogénica A, B o C):** se origina a partir de una faringoamigdalitis estreptocócica. Exantema micropapular eritematoso difuso con **textura áspera "en papel de lija" o piel de gallina**. Signos patognomónicos: (1) **Líneas de Pastia** (hiperpigmentación petequial lineal en los pliegues antecubitales e inguinales), (2) **Facies de Filatov** (eritema marcado en mejillas y frente con palidez peribucal circumoral), y (3) **Lengua en fresa blanca (primeros 2 días) que evoluciona a lengua en frambuesa roja descamada (día 4-5)**. Tratamiento: **Amoxicilina oral 50 mg/kg/día por 10 días completos** (o Penicilina Benzatina IM dosis única) para prevenir la Fiebre Reumática. 2.01.1.008

• **Eritema Infeccioso / 5ª Enfermedad (Parvovirus B19):** inicia con el **Signo de la bofetada** (eritema macular confluente rojo encendido brillante en ambas mejillas con palidez peribucal). A los 2-3 días evoluciona a un exantema maculopapular eritematoso en tronco y extremidades con **patrón reticulado "en encaje"**, que recidiva con el calor o la exposición solar. El virus tiene tropismo por los precursores eritroides, provocando **crisis aplásica severa en pacientes con anemia hemolítica previa** (drepanocitosis, esferocitosis) e hidrops fetal en embarazadas. **(ver Imagen 5.3C)**

3. ENFERMEDAD DE KAWASAKI (VASCULITIS CORONARIA INFANTIL)

Vasculitis necrotizante de vasos de mediano calibre que afecta a lactantes y preescolares (< 5 años). **Es la primera causa de cardiopatía adquirida en la infancia**. 2.01.1.058

Criterios diagnósticos: Fiebre alta persistente de ≥ 5 días de duración refractaria a antipiréticos común + al menos **4 de los siguientes 5 signos clínicos**:

1. **Inyección conjuntival bilateral bulbar no exudativa** (sin pus).
2. **Cambios en labios y mucosa oral:** queilitis labial eritematosa fisurada, eritema faríngeo y **lengua en frambuesa**.
3. **Cambios en extremidades periféricas:** edema indurado y eritema en palmas y plantas en fase aguda; descamación periungueal "en dedo de guante" en fase subaguda.
4. **Exantema polimorfo difuso** (no vesicular).
5. **Linfadenopatía cervical unilateral no purulenta (≥ 1.5 cm)**.



Kawasaki



Kawasaki



Kawasaki

Tratamiento de urgencia: Inmunoglobulina Endovenosa (IGEV 2 g/kg en infusión única) + Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) en dosis antiinflamatoria (30-50 mg/kg/día). Administrada antes del décimo día de fiebre, reduce el riesgo de **aneurismas de las arterias coronarias** del 25% a menos del 3-5%.

4. VASCULITIS EN LA INFANCIA: PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH Y OTRAS

La **púrpura de Schönlein-Henoch** (vasculitis por IgA) es la vasculitis más frecuente del niño (3–15 años) y suele seguir a una infección respiratoria. Tétrada: **púrpura palpable** en extensores de piernas y glúteos con plaquetas y coagulación normales, **artritis** de rodillas y tobillos, **dolor abdominal cólico** (puede complicarse con invaginación o hemorragia digestiva) y **compromiso renal** (hematuria, proteinuria). El diagnóstico es clínico; se trata con reposo y analgesia (AINE para la artritis; 2.01.1.058

corticoides si el dolor abdominal es intenso), y se controla la presión arterial y la orina por 6–12 meses. Se deriva si hay proteinuria nefrótica, hemorragia digestiva o sospecha de invaginación. Otras vasculitis infantiles: **Kawasaki** (gammaglobulina EV + AAS), poliarteritis nodosa, Takayasu y las asociadas a ANCA; se sospechan ante fiebre prolongada con púrpura u otro compromiso orgánico. Diferenciar de la meningococcemia (petequias con fiebre tóxica) y de la PTI (plaquetas bajas).



Púrpura palpable de las piernas en la vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch)



A. MANCHAS DE KOPLIK



B. SARAMPIÓN



C. ESCARLATINA

Imagen 5.3

TABLA 5.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS EXANTEMAS FEBRILES CLÁSICOS DE LA INFANCIA 2.01.1.009, 2.01.1.008, 2.01.1.058

ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL	ENANTEMA / SIGNO PATOGNOMÓNICO	CARACTERÍSTICAS DEL EXANTEMA	TRATAMIENTO EUNACOM
Sarampión	Paramixovirus	Manchas de Koplik (mucosa yugal)	Maculopapular céfalo-caudal confluente	Vitamina A oral + soporte (ENO)
Rubéola	Togavirus	Manchas de Forchheimer + adenopatías retroauriculares	Macular rosado no confluente (3 días)	Sintomático de soporte (ENO)
Escarlatina	Streptococcus pyogenes	Lengua en frambuesa + Líneas de Pastia + Filatov	Micropapular áspero "en papel de lija"	Amoxicilina oral por 10 días completos
Eritema Infeccioso	Parvovirus B19	Signo de la bofetada en mejillas	Patrón reticulado eritematoso "en encaje"	Sintomático (riesgo crisis aplásica)
Enfermedad de Kawasaki	Vasculitis idiopática	Labios fisurados + conjuntivitis seca + lengua frambuesa	Polimorfo + fiebre ≥ 5 días refractaria	Inmunoglobulina EV (2 g/kg) + Aspirina

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.3

Niño de 3 años es traído a urgencias por presentar fiebre de 39.5 °C de 6 días de evolución que no cede con paracetamol ni ibuprofeno. Al examen físico se constata inyección conjuntival bilateral intensa sin secreción purulenta, labios intensamente eritematosos secos con fisuras sangrantes, lengua de aspecto aframbuesado, un exantema maculopapular eritematoso en tronco y marcado edema duro con eritema en palmas de manos y plantas de pies. En la región cervical derecha se palpa un ganglio único de 2 cm, doloroso y no fluctuante. El ecocardiograma inicial no muestra alteraciones coronarias.

Conducta oficial. El paciente cumple estrictamente los criterios diagnósticos de la Enfermedad de Kawasaki: fiebre prolongada de ≥ 5 días asociada a 5 de los 5 criterios clínicos clásicos (inyección conjuntival bulbar no exudativa, alteraciones de la mucosa oral con lengua en frambuesa y labios fisurados, cambios en extremidades con edema palmo-plantar, exantema polimorfo y adenopatía cervical unilateral > 1.5 cm). La complicación más grave y temida de la enfermedad de Kawasaki es la aparición de aneurismas de las arterias coronarias en la fase subaguda. La indicación terapéutica inmediata que previene esta complicación cardíaca es la infusión endovenosa de Inmunoglobulina Humana (IGEV a dosis única de 2 g/kg administrada en 10-12 horas) combinada con Ácido Acetilsalicílico (Aspirina a dosis antiinflamatoria de 30 a 50 mg/kg/día).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Sarampión: fiebre alta + tos + coriza + conjuntivitis con fotofobia + MANCHAS DE KOPLIK (ENO inmediata).
- Rubéola: exantema rosado de 3 días con ADENOPATÍAS RETROAURICULARES y suboccipitales dolorosas.
- Escarlatina: Streptococcus pyogenes; piel áspera "en papel de lija", Facies de Filatov, Líneas de Pastia y lengua en frambuesa; tratar con Amoxicilina 10 días.
- Eritema Infeccioso (Parvovirus B19): "signo de la bofetada" en mejillas y exantema reticulado "en encaje"; riesgo de crisis aplásica.
- Enfermedad de Kawasaki: fiebre ≥ 5 días + conjuntivitis no exudativa + labios fisurados/lengua frambuesa + edema palmo-plantar + exantema + adenopatía cervical > 1.5 cm.
- Tratamiento de Kawasaki: INMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA (IGEV 2 g/kg) + ASPIRINA para prevenir aneurismas coronarios.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Exantemas de la Infancia

1. Un niño de 5 años presenta dolor faríngeo y fiebre de 38.5 °C. Al examen destaca un exantema micropapular eritematoso difuso que palidece a la presión y tiene un tacto áspero similar a un papel de lija, con acentuación del eritema en los pliegues antecubitales formando líneas transversales que no palidecen (Líneas de Pastia). Se observa lengua con papilas hipertróficas rojas prominentes. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico indicado para este cuadro?

A) Azitromicina 10 mg/kg/día por 3 días
B) Amoxicilina oral 50 mg/kg/día por 10 días completos
C) Cefuroxima oral por 5 días
D) Ciprofloxacino oral por 7 días
E) No requiere antibióticos por tratarse de una infección viral autolimitada

Banco de Preguntas Oficial · Exantemas de la Infancia

2. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento precoz con Inmunoglobulina Endovenosa a altas dosis en un lactante diagnosticado con Enfermedad de Kawasaki?

A) Prevenir la progresión a glomerulonefritis post-infecciosa
B) Evitar el desarrollo de aneurismas y ectasias en las arterias coronarias
C) Reducir la duración de la descamación periungueal
D) Erradicar la portación nasal de Streptococcus
E) Prevenir la reactivación por virus varicela zóster

Más preguntas online de Exantemas Febriles de la Infancia →

5.4. Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.011 1.04.2.010 6.01.2.007

¿POR QUÉ?

La primoinfección por Virus Varicela-Zóster (VVZ) y su reactivación como Herpes Zóster son altamente prevalentes. En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria la identificación de las complicaciones graves de la varicela (neumonitis viral en adultos, ataxia cerebelosa aguda y sobreinfección bacteriana invasiva por S. pyogenes), el tratamiento antiviral precoz con Aciclovir y el manejo del Herpes Zóster oftálmico.

1. VARICELA PRIMARIA: SEMIOLOGÍA Y POLIMORFISMO LESIONAL

El Virus Varicela-Zóster (VVZ, herpesvirus humano tipo 3) se 1.04.1.011 transmite por aerosoles respiratorios (aislamiento aéreo) y por contacto directo con el líquido vesicular. Altamente contagioso: **el paciente transmite desde 48 horas antes de la aparición del exantema hasta que TODAS las lesiones se encuentran en fase de COSTRA seca**. **(ver Imagen 5.4A)**

Exantema patognomónico: se caracteriza por su **distribución centrípeta** (predominio en cuero cabelludo, cara y tronco, respetando relativamente las extremidades distales) y por su **POLIMORFISMO REGIONAL ("en cielo estrellado")**: coexistencia simultánea de máculas, pápulas, vesículas con contenido claro sobre base eritematosa ("gotas de rocío sobre pétalo de rosa"), pústulas y costras en una misma zona anatómica.

2. COMPLICACIONES MAYORES DE LA VARICELA SEGÚN GRUPO ETARIO

• **Sobreinfección bacteriana de la piel (la más frecuente en niños):** causada por *Streptococcus pyogenes* o *Staphylococcus aureus* secundario al rascado por prurito intenso (impétigo, celulitis, y en casos severos fascitis necrotizante). 1.04.2.010

• **Ataxia Cerebelosa Aguda / Cerebelitis (complicación neurológica más común en niños):** se presenta 1 a 3 semanas post-exantema con ataxia de la marcha, dismetría, temblor intencional y nistagmo, sin signos meníngeos. Pronóstico excelente, autolimitada en semanas.

• **Neumonitis Varicelosa (la complicación más letal, típica en ADULTOS, embarazadas y fumadores):** se manifiesta al 3°-5° día del exantema con tos seca, disnea súbita, taquipnea, hemoptisis e hipoxemia severa. Radiografía de tórax: infiltrados nodulares difusos bilaterales. **Mortalidad > 20-30%**. Exige **Aciclovir EV inmediato (10 mg/kg cada 8 horas)**.

• **Síndrome de Reye:** encefalopatía hepática aguda no inflamatoria con degeneración grasa microvesicular hepática e hiperamonemia en niños con varicela o influenza que reciben **Aspirina** (contraindicación absoluta de ácido acetilsalicílico en niños).



Neumonitis varicelosa

3. HERPES ZÓSTER Y SÍNDROME DE RAMSAY-HUNT

Reactivación del VVZ latente en los ganglios de la raíz dorsal o de pares craneanos por inmunosenescencia o inmunosupresión. 1.04.1.011 6.01.2.007

Cursa con dolor neuropático urente en un **dermatoma unilateral estricto** que no cruza la línea media, seguido de vesículas en racimo.

• **Herpes Zóster Oftálmico (rama V1 del trigémino):** vesículas en la punta de la nariz (**Signo de Hutchinson**) indican compromiso del nervio nasociliar y predicen afectación corneal grave (queratitis dendrítica, uveítis, ceguera). Exige evaluación oftalmológica urgente y Aciclovir sistémico.

• **Síndrome de Ramsay-Hunt (ganglio geniculado del VII par):** tríada de **Parálisis facial periférica + Otalgia intensa + Vesículas en el conducto auditivo externo o pabellón auricular**.

Tratamiento: Aciclovir oral 800 mg 5 veces al día por 7 días (o Valaciclovir 1 g cada 8 h) iniciado idealmente en las primeras 72 horas para reducir el dolor agudo y la incidencia de **Neuralgia Postherpética** (dolor neuropático persistente > 3 meses, tratado con Pregabalina, Gabapentina o Amitriptilina). **(ver Imagen 5.4B y C)**



A. VARICELA



B. HERPES ZÓSTER



C. ZÓSTER OFTÁLMICO

Imagen 5.4

TABLA 5.4 · COMPLICACIONES DE LA INFECCIÓN POR VIRUS VARICELA-ZÓSTER (VVZ) 1.04.1.011, 1.04.2.010, 6.01.2.007

COMPLICACIÓN	POBLACIÓN VULNERABLE	MANIFESTACIÓN CLÍNICA CARDINAL	CONDUCTA MÉDICA EUNACOM
Neumonitis Varicelosa	Adultos, embarazadas y fumadores	Disnea aguda + infiltrados nodulares bilaterales	Aciclovir EV (10 mg/kg c/8h) + Soporte en UCI
Ataxia Cerebelosa Aguda	Niños preescolares y escolares	Marcha atáxica, dismetría y nistagmo post-varicela	Manejo conservador (autolimitada, buen pronóstico)
Sobreinfección Bacteriana	Niños con prurito intenso y rascado	Fascitis necrotizante o celulitis con pus	Cefazolina / Cloxacilina o Aseo quirúrgico
Herpes Zóster Oftálmico	Adultos mayores (compromiso V1 trigémino)	Signo de Hutchinson (vesícula punta nasal)	Aciclovir oral/EV + Derivación urgente a Oftalmología
Síndrome de Ramsay-Hunt	Adultos con reactivación VII par	Parálisis facial periférica + vesículas en CAE	Aciclovir oral a dosis altas + Corticoides

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Hombre de 32 años, previamente sano y no vacunado contra la varicela, presenta desde hace 4 días fiebre y exantema vesicular pruriginoso con lesiones en diferentes estadios en cara y tórax. Hace 12 horas agrega tos seca, disnea de reposo rápidamente progresiva y dolor torácico pleurítico bilateral. Al examen: T° 38.6 °C, FC 118 lpm, FR 32 rpm, saturación de oxígeno 88% al aire ambiente. A la auscultación pulmonar se pesquisan crépitos bilaterales difusos. La radiografía de tórax revela múltiples infiltrados micronodulares bilaterales difusos en ambos campos pulmonares.

Conducta oficial. El paciente adulto presenta una Neumonitis Varicelosa, la complicación visceral más temida y de mayor letalidad de la varicela primaria en el adulto. La clínica de insuficiencia respiratoria aguda e infiltrados nodulares difusos en un paciente con varicela activa exige hospitalización inmediata en cuidados intensivos (UCI), oxigenoterapia para corregir la hipoxemia y administración urgente de ACICLOVIR ENDOVENOSO en dosis de 10 mg/kg cada 8 horas. No se debe intentar tratamiento con aciclovir oral, dada la escasa biodisponibilidad y la rápida letalidad del cuadro respiratorio si no se alcanzan niveles séricos antivirales terapéuticos inmediatos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Varicela: lesiones en diferente estadio ("cielo estrellado") con distribución centrípeta; contagiosa hasta que todas son costras.
- Neumonitis varicelosa: complicación más grave en ADULTOS (disnea, hipoxemia, infiltrado nodular); requiere ACICLOVIR EV urgente.
- Ataxia cerebelosa: complicación neurológica benigna y autolimitada más común en niños.
- Signo de Hutchinson en Herpes Zóster: vesícula en la punta de la nariz que avisa riesgo inminente de queratitis oftálmica.
- Síndrome de Ramsay-Hunt: parálisis facial periférica + vesículas en el conducto auditivo externo (ganglio geniculado del nervio facial).
- Tratamiento de Herpes Zóster: Aciclovir oral 800 mg 5 veces al día por 7 días iniciado en las primeras 72 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Varicela y Herpes Zóster

1. Un hombre de 36 años fumador consulta por disnea aguda progresiva y tos con estrías de sangre de 24 horas de evolución. Presenta desde hace 4 días un exantema vesicular polimórfico en cara y tronco compatible con varicela. La saturación de oxígeno es 89% con aire ambiental y la radiografía de tórax muestra infiltrados micronodulares bilaterales difusos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico prioritario?

A) Aciclovir endovenoso a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas
B) Aciclovir oral 800 mg cada 4 horas
C) Ceftriaxona más Claritromicina endovenosa
D) Inmunoglobulina hiperinmune contra varicela zóster intramuscular
E) Metilprednisolona endovenosa en pulsos

Banco de Preguntas Oficial · Varicela y Herpes Zóster

2. Una mujer de 68 años consulta por intenso dolor urente en la hemicara izquierda de 3 días de evolución, asociándose hace 24 horas a la aparición de vesículas en racimo en la frente, el párpado superior y la punta de la nariz (signo de Hutchinson positivo). ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Iniciar Aciclovir oral a dosis plenas y solicitar evaluación urgente por Oftalmología
B) Indicar tratamiento con Carbamazepina y analgesia con Paracetamol
C) Aplicar ungüento tópico de corticoides en las lesiones nasales y párpado
D) Administrar vacuna de refuerzo contra herpes zóster
E) Realizar desbridamiento quirúrgico de las vesículas nasales

Más preguntas online de Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster →

5.5. Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.020 | 1.04.1.019 | 2.01.1.034 | 1.04.1.024

¿POR QUÉ?

La neutropenia febril post-quimioterapia es la principal emergencia oncológica infectológica. El EUNACOM evalúa dos conceptos taxativos: la regla de los 60 minutos para iniciar monoterapia antipseudomónica (Cefepime EV) tras los hemocultivos y la sospecha de micosis invasora (Voriconazol EV) ante fiebre persistente al 4°–7° día.

1. DEFINICIONES NORMATIVAS Y FISIOPATOLOGÍA

En el neutropénico **no hay pus ni signos inflamatorios habituales**; la fiebre suele ser la única alarma de bacteriemia. 1.04.1.020 2.01.1.034



Ectima gangrenoso

Fiebre: registro axilar único **≥ 38.3 °C** o **≥ 38.0 °C por > 1 hora**. **Neutropenia: RAN < 500 células/mm³** (o < 1.000 con caída prevista a < 500 en 48 h). Patógeno más temido: ***Pseudomonas aeruginosa*** (shock séptico fulminante en < 12 h).

2. ESTRATIFICACIÓN MASCC Y MANEJO DE EMERGENCIA

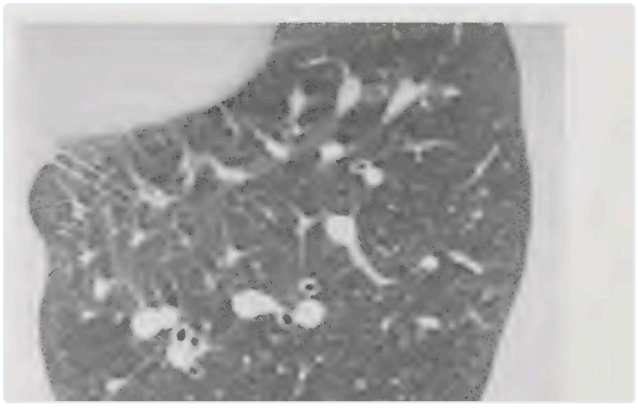
Regla de los 60 minutos: infundir el antibiótico EV en la primera hora, previa toma rápida de 2 hemocultivos. 1.04.1.020 2.01.1.034

• **Alto Riesgo (MASCC < 21):** hospitalización y **Cefepime 2 g c/8h EV** (o Piperacilina-Tazobactam). Vancomicina solo si hay shock, infección franca de catéter o mucositis severa.

• **Bajo Riesgo (MASCC ≥ 21):** opción ambulatoria seleccionada con **Ciprofloxacino + Amoxicilina/Clavulánico oral**.

3. FIEBRE PERSISTENTE AL 4°–7° DÍA (MICOSIS INVASORA)

Si persiste febril al 4°–7° día con hemocultivos negativos bajo cobertura de amplio espectro, la causa más frecuente es una **Infección Fúngica Invasora (Aspergilosis pulmonar o Candidiasis)**. 1.04.1.019



TAC de tórax con signo del halo

Conducta obligatoria: **TAC de tórax de alta resolución** (buscar el **Signo del Halo**) e inicio inmediato de **Voriconazol EV** o una Equinocandina (Caspofungina).

4. MUCORMICOSIS Y FIEBRE SIN FOCO O PROLONGADA

Mucormicosis (*Rhizopus*, *Mucor*): hongo angioinvasor que causa necrosis tisular; afecta a pacientes con **cetoacidosis diabética**, neutropenia prolongada, trasplante, corticoides, sobrecarga de hierro (deferoxamina) o COVID-19 grave. La forma **rinocerebral** da dolor facial, secreción nasal sanguinolenta, **escara negra** en paladar o cornetes, edema periorbitario, proptosis y oftalmoplejía; también hay formas pulmonar y cutánea. Sospecharla cuando hay necrosis y el paciente empeora con voriconazol (no tiene actividad contra mucorales). Diagnóstico urgente con **biopsia** (hifas anchas, aseptadas, ramificadas en ángulo recto). Tratamiento: **desbridamiento quirúrgico amplio + anfotericina B liposomal** (5–10 mg/kg/día), corrección de la acidosis y la glicemia y reducción de la inmunosupresión; posaconazol o isavuconazol de rescate. Mortalidad cercana a 50 %; se deriva de inmediato. 1.04.1.019



Mucormicosis rinocerebral: edema facial y proptosis unilateral

Fiebre sin foco y fiebre prolongada del adulto: la fiebre de menos de 7 días con examen y exámenes básicos (hemograma, PCR, orina, Rx de tórax) normales es habitualmente viral: manejo sintomático y control; son signos de alarma la inmunosupresión, la neutropenia, el catéter o prótesis, el compromiso hemodinámico y la edad extrema. La fiebre > 3 semanas (> 38,3 °C) sin diagnóstico tras estudio inicial se estudia de forma escalonada: hemocultivos × 3, hemograma, PCR/VHS, perfil hepático, LDH, sedimento, Rx, ecografía/TAC, PPD o IGRA, serologías (VIH, EBV, CMV, *Brucella*), ANA y ecocardiograma si hay soplo. Causas: infecciosas (TBC, endocarditis, abscesos), inflamatorias (arteritis de células gigantes en el anciano, Still) y neoplasias (linfoma). Se sospecha, se inicia el estudio y se deriva; no se dan antibióticos ni corticoides empíricos. 1.04.1.024

FIGURA 5.5 · MANEJO DE EMERGENCIA EN NEUTROPENIA FEBRIL POST-QUIMIOTERAPIA

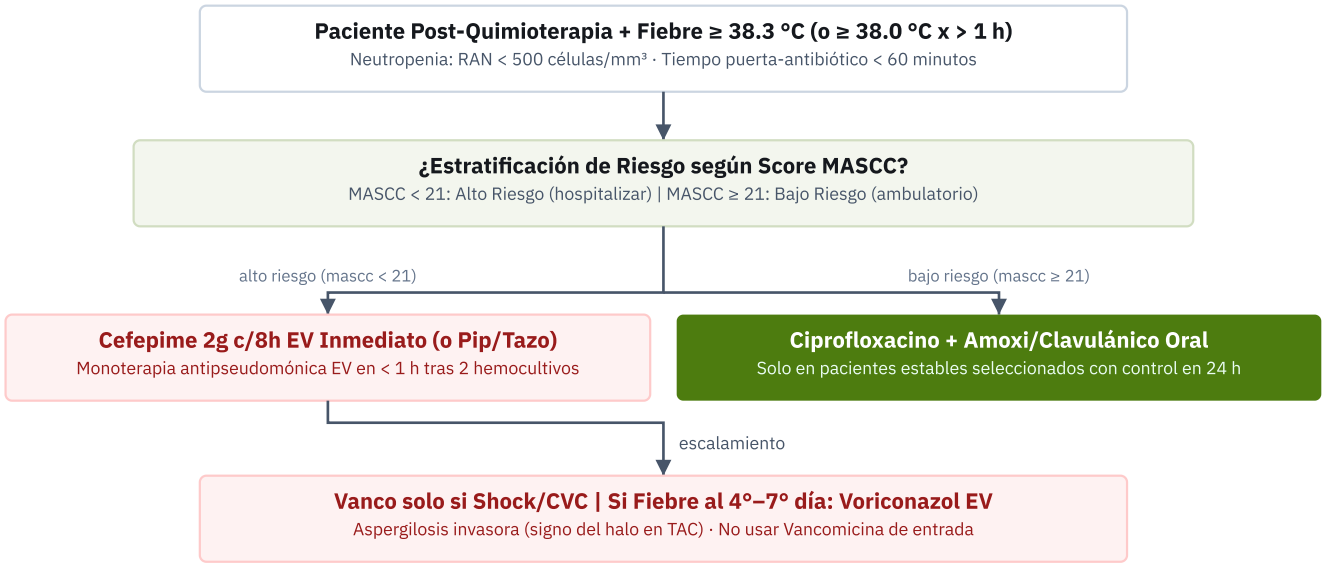


TABLA 5.5 · ESTRATIFICACIÓN Y MANEJO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EUNACOM `1.04.1.020, 1.04.1.019, 2.01.1.034, 1.04.1.024`

CATEGORÍA DE RIESGO	SCORE MASCC	LUGAR DE TRATAMIENTO	ESQUEMA DE ELECCIÓN
Bajo Riesgo	MASCC ≥ 21 puntos	Ambulatorio / Domicilio estricto	Ciprofloxacino oral + Amoxicilina/Clavulánico
Alto Riesgo	MASCC < 21 puntos	Hospitalización en Aislamiento	Cefepime 2 g c/8h EV (o Pip/Tazo) en < 60 min
Alto Riesgo + Shock/CVC	MASCC < 21 + Foco Gram(+)	Unidad de Paciente Crítico (UCI)	Cefepime EV + Vancomicina 15-20 mg/kg EV
Fiebre al 4°–7° día	Refractario a antibióticos	Hospitalizado con TAC de tórax	Voriconazol EV o Equinocandina (Caspofungina)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.5

Hombre de 54 años en tratamiento con quimioterapia por linfoma no Hodgkin hace 9 días consulta en urgencias por sensación febril y calofríos. Al examen físico: T° 38.6 °C axilar, FC 110 lpm, PA 100/65 mmHg, FR 20 rpm. No presenta foco respiratorio, urinario ni abdominal evidente; el sitio de su catéter venoso central está sano. El hemograma de urgencia informa: Leucocitos 800/mm³, con 15% de baciliformes, 20% de segmentados (Recuento Absoluto de Neutrófilos RAN = 280/mm³) y plaquetas 65.000/mm³.

Conducta oficial. El paciente presenta una Neutropenia Febril post-quimioterapia (registro térmico ≥ 38.3 °C con RAN < 500/mm³). Esta situación clínica constituye una emergencia médica absoluta de máxima gravedad con riesgo inminente de shock séptico bacteriano fulminante por Pseudomonas aeruginosa o enterobacterias. La conducta médica inmediata que no admite dilación es la hospitalización en aislamiento protector, toma inmediata de dos frascos de hemocultivos (periféricos y a través del CVC) e inicio dentro de los primeros 60 minutos de monoterapia antibiótica antipseudomónica endovenosa con CEFEPIME (2 g cada 8 h EV) o Piperacilina-Tazobactam. No está indicado asociar Vancomicina de entrada por encontrarse hemodinámicamente estable y sin signos de infección de catéter.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Definición de Neutropenia Febril: Fiebre ≥ 38.3 °C (o ≥ 38.0 °C por > 1 h) + RAN < 500 células/mm³.
- Emergencia infectológica: tiempo puerta-antibiótico DEBE ser MENOR A 60 MINUTOS.
- Antibiótico empírico de elección (alto riesgo): Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam 4.5 g c/6h EV).
- Vancomicina de entrada: SOLO si hay shock séptico, infección de catéter evidente, mucositis severa o sospecha de SAMR.
- Bajo riesgo (MASCC ≥ 21): opción ambulatoria con Ciprofloxacino + Amoxicilina/Clavulánico oral.
- Fiebre persistente al 4°-7° día a pesar de antibióticos: sospechar Aspergilosis o micosis invasora e iniciar Voriconazol o Caspofungina EV.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Neutropenia Febril

1. Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en urgencias por fiebre de 38.7 °C y calofríos. Al examen no se identifica foco infeccioso evidente. El hemograma revela un recuento de leucocitos de 600/mm³ con 30% de neutrófilos totales (RAN 180/mm³). Tras la toma de hemocultivos, ¿cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

A) Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos
B) Administrar Ceftriaxona 2 g EV más Vancomicina y hospitalizar en sala básica
C) Indicar tratamiento con Ciprofloxacino oral y control ambulatorio en 24 horas
D) Esperar el resultado de los hemocultivos para iniciar el antibiótico dirigido
E) Iniciar tratamiento antifúngico con Fluconazol oral en monoterapia

Banco de Preguntas Oficial · Neutropenia Febril

2. Un paciente neutropénico febril post-quimioterapia cumple 5 días hospitalizado recibiendo Cefepime y Vancomicina EV a dosis plenas. Los hemocultivos iniciales y urocultivo resultaron negativos. A pesar de esto, el paciente persiste febril (38.8 °C) y neutropénico severo (RAN 120/mm³). ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica prioritaria?

A) Suspender todos los antibióticos y observar la evolución espontánea
B) Solicitar TAC de tórax de alta resolución e iniciar terapia antifúngica empírica con Voriconazol o Equinocandina
C) Reemplazar Cefepime por Ciprofloxacino oral
D) Administrar corticoides sistémicos a dosis altas para yugular la fiebre
E) Indicar tratamiento con Aciclovir oral por probable reactivación herpética

Más preguntas online de Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco →

5.6. Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.04.1.016 1.04.1.029 2.01.2.144

¿POR QUÉ?

La influenza y la COVID-19 son las dos virosis respiratorias de mayor impacto estacional. En el EUNACOM se evalúa el reconocimiento clínico, el uso racional de antivirales (oseltamivir en influenza y nirmatrelvir/ritonavir en COVID-19, reservados a grupos de riesgo o formas graves), la estratificación de gravedad y las complicaciones pediátricas, en particular el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) que aparece semanas después de la infección por SARS-CoV-2.

1. INFLUENZA: CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIONES

La **influenza** (virus influenza A y B) se transmite por gotitas y tiene brotes invernales. Se presenta con **fiebre alta de inicio brusco, mialgias, cefalea, malestar intenso, tos seca y odinofagia**, a diferencia del resfrío común (rinorrea y congestión predominan, sin fiebre alta). Dura 3–7 días. El diagnóstico es clínico en temporada; la confirmación (PCR o inmunofluorescencia de aspirado nasofaríngeo) se reserva para pacientes hospitalizados, graves o para vigilancia. 1.04.1.016

Complicaciones: neumonía viral primaria, **neumonía bacteriana secundaria** (*S. pneumoniae*, *S. aureus*), descompensación de enfermedades crónicas (EPOC, asma, insuficiencia cardíaca), miocarditis, encefalopatía y, en niños con aspirina, síndrome de Reye (por eso no se usa AAS). Son **grupos de riesgo**: edad ≥ 65 años, menores de 5 años (sobre todo menores de 2 años), embarazadas, obesidad mórbida, enfermedades cardiopulmonares, renales, hepáticas, diabetes e inmunosupresión.

2. INFLUENZA: TRATAMIENTO ANTIVIRAL Y PREVENCIÓN

Oseltamivir 75 mg cada 12 horas por 5 días (inhibidor de la neuraminidasa), idealmente dentro de las primeras 48 horas, pero **sin esperar** en formas graves u hospitalizadas, en que se da aunque hayan pasado más horas. Está indicado en **grupos de riesgo**, embarazadas y formas graves; en un adulto sano sin factores de riesgo con cuadro leve basta el manejo sintomático (el oseltamivir es opcional y acorta la enfermedad solo alrededor de un día). Ajustar en insuficiencia renal. En niños la dosis es por peso: ≤ 15 kg 30 mg, 15–23 kg 45 mg, 23–40 kg 60 mg y > 40 kg 75 mg cada 12 horas; en lactantes menores de 1 año 3 mg/kg por dosis. 1.04.1.016

Prevención: vacuna inactivada anual (embarazadas, ≥ 65 años, enfermos crónicos, personal de salud y niños de 6 meses a 5.º básico, gratuita en el PNI), lavado de manos, etiqueta respiratoria y aislamiento por gotitas. La quimioprofilaxis postexposición con oseltamivir se reserva para contactos de alto riesgo no vacunados. Se notifican los casos de infección respiratoria aguda grave.

3. COVID-19: CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD Y TRATAMIENTO DEL ADULTO

La **COVID-19** (SARS-CoV-2) va desde infección asintomática hasta insuficiencia respiratoria grave. Síntomas: fiebre, tos, odinofagia, mialgias, cefalea, y anosmia/ageusia (menos frecuentes con las variantes recientes). Se confirma con **PCR** o **test de antígeno** (más rendimiento en los primeros 5–7 días de síntomas). Clasificación: **leve** (sin disnea ni neumonía), **moderada** (neumonía con SpO_2 ≥ 94 %), **grave** (SpO_2 < 94 % ambiental, FR > 30 rpm o infiltrados > 50 %) y **crítica** (insuficiencia respiratoria, shock, falla multiorgánica). Factores de riesgo de progresión: edad avanzada, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular o renal, inmunosupresión y no estar vacunado. 1.04.1.029

Enfermedad leve a moderada (nivel completo): manejo sintomático (paracetamol, hidratación, reposo), aislamiento mientras haya síntomas, educación sobre signos de alarma (disnea, saturación baja, dolor torácico, compromiso de conciencia) y control. En pacientes con **riesgo de progresión** se indica **nirmatrelvir/ritonavir** (300/100 mg cada 12 h por 5 días, dentro de los primeros 5 días de síntomas; ojo con las **interacciones** del ritonavir y el ajuste en insuficiencia renal) o remdesivir por 3 días. Los antibióticos solo se usan ante sobreinfección bacteriana. Si requiere oxígeno: **dexametasona 6 mg al día por hasta 10 días**, anticoagulación profiláctica y, en casos seleccionados, baricitinib o tocilizumab; se hospitaliza con SpO_2 < 94 %.

4. COVID-19 EN EL NIÑO: MANEJO Y MIS-C

En el niño la COVID-19 es habitualmente **leve** (fiebre, tos, rinorrea, síntomas digestivos, laringitis o bronquiolitis). Se maneja con tratamiento sintomático y vigilancia de **signos de gravedad**: dificultad respiratoria, retracciones, SpO_2 < 94 %, rechazo alimentario, somnolencia o deshidratación. Los lactantes, los niños con cardiopatías, inmunosupresión, obesidad o enfermedades crónicas tienen más riesgo; se hospitaliza si hay hipoxemia y se usa dexametasona si requiere oxígeno. El antiviral se reserva para adolescentes de riesgo (≥ 12 años y ≥ 40 kg). 2.01.2.144 1.04.1.029

Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C): aparece **2 a 6 semanas** después de la infección o el contacto con SARS-CoV-2, como una respuesta inmune exagerada. Fiebre persistente (≥ 3 días) con compromiso de varios órganos: dolor abdominal y vómitos (puede simular apendicitis), exantema, conjuntivitis, shock, miocarditis o disfunción ventricular. Laboratorio: **PCR, ferritina, dímero D, troponina y BNP elevados**, linfopenia y trombocitopenia. Se diferencia del Kawasaki por la edad mayor, el predominio de síntomas digestivos y el shock. Es una urgencia: se deriva a UCI pediátrica para **inmunoglobulina EV, corticoides** y manejo del shock, con ecocardiograma.

FIGURA 5.6 · MANEJO DE INFLUENZA Y COVID-19 EN EL PACIENTE AMBULATORIO

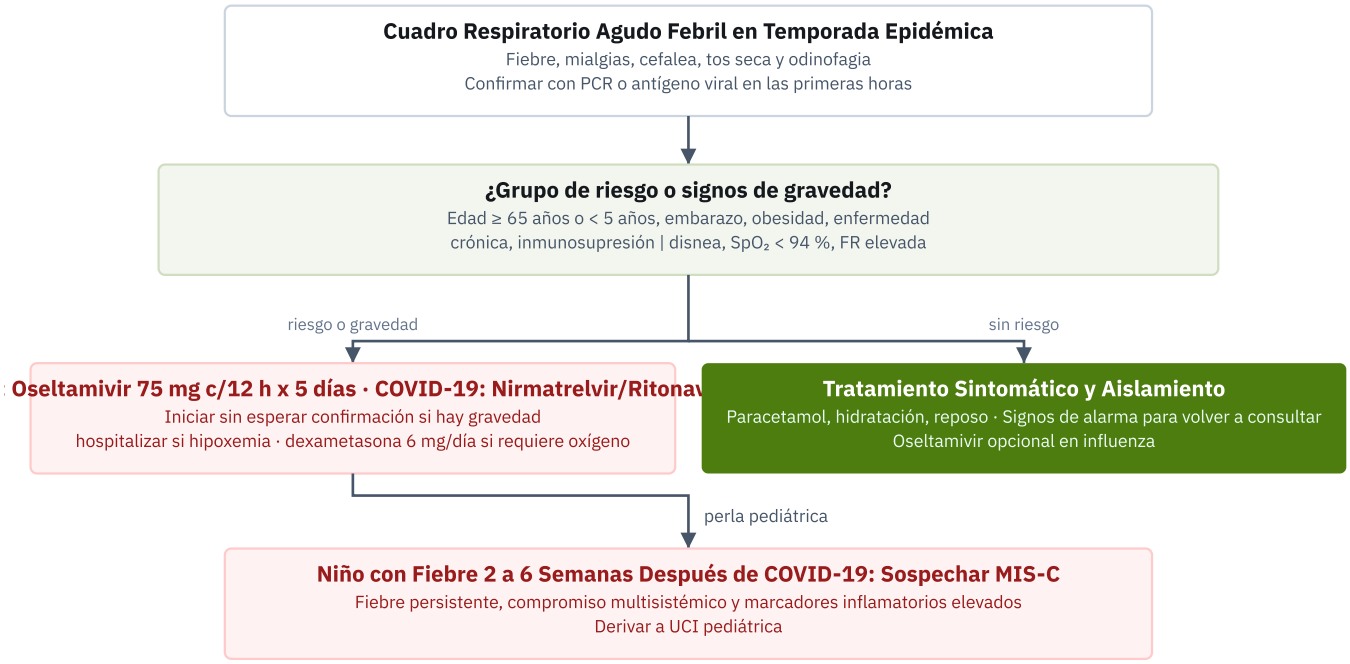


TABLA 5.6 · INFLUENZA VERSUS COVID-19: DIFERENCIAS PRÁCTICAS

1.04.1.016, 1.04.1.029, 2.01.2.144

ASPECTO	INFLUENZA	COVID-19	CONDUCTA
Inicio y síntomas	Brusco; fiebre alta, mialgias, cefalea intensos	Variable; anosmia/ageusia, disnea, cuadro más prolongado	Confirmar con PCR o antígeno
Antiviral	Oseltamivir 75 mg c/12 h x 5 días	Nirmatrelvir/ritonavir x 5 días o remdesivir x 3 días	Solo riesgo o gravedad (influenza: no esperar confirmación si es grave)
Corticoides	No recomendados de rutina	Dexametasona 6 mg/día si requiere oxígeno	Hospitalizar si SpO_2 < 94 %
Complicación pediátrica	Neumonía, miocarditis, Reye con AAS	MIS-C 2 a 6 semanas después	Derivar a UCI pediátrica
Vacuna	Anual (inactivada)	Esquema y refuerzos según PNI	Priorizar grupos de riesgo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.6

Mujer de 68 años, hipertensa y diabética tipo 2, consulta en julio por fiebre de 39 °C de inicio brusco hace 24 horas, mialgias intensas, cefalea y tos seca. En su comuna hay un brote de influenza. Saturación de oxígeno 96 % ambiental, frecuencia respiratoria 18 por minuto, sin disnea y auscultación pulmonar normal. No está vacunada.

Conducta oficial. Es una influenza en una paciente de un grupo de riesgo (más de 65 años, diabetes e hipertensión): el cuadro es típico, sin signos de neumonía ni de gravedad. Corresponde indicar oseltamivir 75 mg cada 12 horas por 5 días, idealmente en las primeras 48 horas, sin esperar la confirmación por laboratorio, además de tratamiento sintomático con paracetamol, hidratación y reposo, educación sobre signos de alarma y vacunación posterior. Los antibióticos no están indicados mientras no haya sobreinfección bacteriana, y los corticoides no forman parte del tratamiento de la influenza.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Influenza: fiebre alta brusca, mialgias, cefalea y tos seca; el diagnóstico en temporada es clínico.
- Oseltamivir 75 mg cada 12 h por 5 días en grupos de riesgo (≥ 65 años, embarazo, crónicos, inmunosupresión) y formas graves; en el adulto sano con cuadro leve solo se da tratamiento sintomático.
- No usar aspirina en niños con influenza (síndrome de Reye).
- COVID-19: leve, moderada (neumonía con SpO_2 ≥ 94 %), grave (SpO_2 < 94 %) y crítica; el diagnóstico es por PCR o test de antígeno.
- Nirmatrelvir/ritonavir en pacientes de riesgo dentro de 5 días; dexametasona 6 mg/día solo si requiere oxígeno.
- MIS-C: fiebre y compromiso multisistémico 2 a 6 semanas después de COVID-19, con PCR, ferritina, dímero D y troponina elevados; se deriva a UCI pediátrica para inmunoglobulina y corticoides.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2015 · Influenza

1. Un hombre de 22 años, sano, consulta en invierno por rinorrea, congestión nasal, fiebre de 38,5 °C, mialgias y tos seca de 2 días de evolución, durante un brote de influenza en su comuna. No tiene enfermedades crónicas ni signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar para oseltamivir endovenoso
B) Iniciar amoxicilina-ácido clavulánico por riesgo de neumonía bacteriana
C) Indicar prednisona oral por 5 días
D) Solicitar PCR en todos los casos antes de decidir el manejo
E) Tratamiento sintomático, con oseltamivir como opción en vez de indicación obligatoria

EUNACOM Agosto 2021 · COVID-19 pediátrico

2. Un adolescente de 14 años consulta por fiebre de 39 °C de 3 días, dolor abdominal, vómitos y diarrea, con exantema y conjuntivitis no purulenta. Hace 4 semanas tuvo un cuadro respiratorio leve del que no se hizo estudio y un familiar tuvo COVID-19. Al examen está hipotenso y taquicárdico. La PCR, la ferritina, el dímero D y la troponina están elevados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda complicada
B) Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2
C) Gastroenteritis aguda por rotavirus
D) Sarampión
E) Neumonía viral por SARS-CoV-2

Banco de Preguntas Oficial · COVID-19 del adulto

3. Un hombre de 58 años, obeso y diabético, no vacunado, consulta al segundo día de síntomas por fiebre, tos y mialgias. Test de antígeno positivo para SARS-CoV-2. Saturación 97 % ambiental y frecuencia respiratoria 16 por minuto. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Dexametasona 6 mg diarios por 10 días
B) Hospitalización en UCI con tocilizumab
C) Antibiótico de amplio espectro por vía endovenosa
D) Manejo sintomático e indicar nirmatrelvir/ritonavir por 5 días, verificando las interacciones farmacológicas
E) Solo reposo sin antivirales porque la enfermedad es leve

Más preguntas online de Virus Respiratorios →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.6

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis	Erisipela: dermis superficial; Streptococcus pyogenes; placa rojo vivo con BORDES NETOS...	**Celulitis: tejido celular subcutáneo profundo; S. aureus y S. pyogenes; eritema con...**	—
Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH	Mononucleosis por VEB: faringitis con exudado + adenopatías cervicales posteriores +...	**Laboratorio: leucocitosis con predominio mononuclear y LINFOCITOS ATÍPICOS > 10% en el...**	Recomendación crítica: PROHIBIDOS deportes de contacto por 3 a 4 semanas por riesgo de...
Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki	Sarampión: fiebre alta + tos + coriza + conjuntivitis con fotofobia + MANCHAS DE KOPLIK...	**Rubéola: exantema rosado de 3 días con ADENOPATÍAS RETROAURICULARES y suboccipitales...**	—
Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster	Varicela: lesiones en diferente estadio ("cielo estrellado") con distribución...	**Neumonitis varicelosa: complicación más grave en ADULTOS (disnea, hipoxemia, infiltrado...**	El paciente adulto presenta una Neumonitis Varicelosa, la complicación visceral más...
Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	Definición de Neutropenia Febril: Fiebre ≥ 38.3 °C (o ≥ 38.0 °C por > 1 h) + RAN < 500...	**Emergencia infectológica: tiempo puerta-antibiótico DEBE ser MENOR A 60 MINUTOS.**	El paciente presenta una Neutropenia Febril post-quimioterapia (registro térmico ≥ 38.3...
Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)	Influenza: fiebre alta brusca, mialgias, cefalea y tos seca; el diagnóstico en...	**Oseltamivir 75 mg cada 12 h por 5 días en grupos de riesgo (≥ 65 años, embarazo...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Erisipela: dermis superficial; Streptococcus pyogenes; placa rojo vivo con BORDES NETOS SOBREELEVADOS.

Celulitis: tejido celular subcutáneo profundo; S. aureus y S. pyogenes; eritema con BORDES DIFUSOS Y MAL DELIMITADOS.

Siempre buscar la puerta de entrada: tinea pedis interdigital (intertrigo micótico) es la causa más común de celulitis de...

Conducta obligatoria: marcar con lápiz los bordes de la lesión para evaluar progresión o regresión objetiva.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Celulitis: tejido celular subcutáneo profundo; S. aureus y S. pyogenes; eritema con BORDES DIFUSOS Y MAL DELIMITADOS.
- Siempre buscar la puerta de entrada: tinea pedis interdigital (intertrigo micótico) es la causa más común de celulitis de extremidades.
- Laboratorio: leucocitosis con predominio mononuclear y LINFOCITOS ATÍPICOS > 10% en el frotis.
- Exantema maculopapular tras recibir Amoxicilina: inducido por VEB en > 90%; no es alergia permanente.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Erisipela: dermis superficial; Streptococcus pyogenes; placa rojo vivo con BORDES NETOS SOBREELEVADOS.	Tema 5.1 →
Mononucleosis por VEB: faringitis con exudado + adenopatías cervicales posteriores + esplenomegalia.	Tema 5.2 →
Sarampión: fiebre alta + tos + coriza + conjuntivitis con fotofobia + MANCHAS DE KOPLIK (ENO inmediata).	Tema 5.3 →
Varicela: lesiones en diferente estadio ("cielo estrellado") con distribución centrípeta; contagiosa hasta que...	Tema 5.4 →
Definición de Neutropenia Febril: Fiebre ≥ 38.3 °C (o ≥ 38.0 °C por > 1 h) + RAN < 500 células/mm³.	Tema 5.5 →
Influenza: fiebre alta brusca, mialgias, cefalea y tos seca; el diagnóstico en temporada es clínico.	Tema 5.6 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 Banco de Preguntas Oficial · Sepsis y Shock Séptico

Un paciente de 62 años con neumonía adquirida en la comunidad grave evoluciona con taquipnea (FR 28 rpm), compromiso de...

CLAVE B **Iniciar infusión de noradrenalina con meta de PAM ≥ 65 mmHg**

El paciente se encuentra en shock séptico refractario a fluidos (PAM 2 mmol/L post-volumen). La recomendación Surviving Sepsis Campaign establece la Noradrenalina como el vasopresor de primera línea para restaurar la presión de perfusión tisular (PAM ≥ 65 mmHg). La dopamina (A) aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y mortalidad. Los corticoides (C) se indican solo en shock refractario a dosis altas de noradrenalina.

> **Perla.** Continuar aportando volumen a ciegas (D) provoca edema pulmonar y mayor falla ventricular.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 Banco de Preguntas Oficial · Sepsis y Shock Séptico

¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos forma parte del score qSOFA (quick SOFA) para la identificación rápida de...

CLAVE C **Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto**

El qSOFA consta exclusivamente de tres parámetros clínicos de fácil evaluación sin requerir exámenes de laboratorio: (1) Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm, (2) Alteración del estado mental (Glasgow < 15), y (3) Presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg.

> **Perla.** La temperatura, taquicardia y leucocitosis (A, B, D) pertenecían a los antiguos criterios de SIRS, los cuales fueron abandonados por su baja especificidad.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 3 Banco de Preguntas Oficial · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

Hombre de 58 años es traído a urgencias con fiebre de 39 °C, rigidez de nuca y sopor. Al examen se constata hemiparesia...

CLAVE B **Tomar hemocultivos, administrar dexametasona y antibióticos EV de inmediato, y luego solicitar TAC cerebral**

La presencia de focalidad neurológica (hemiparesia y Babinski) es una contraindicación formal para la punción lumbar inmediata por riesgo inminente de herniación cerebral fatal. Sin embargo, la regla médica absoluta es que NUNCA se debe postergar el inicio de los antibióticos por la realización de neuroimágenes.

> **Perla.** La conducta exacta es tomar hemocultivos inmediatos, administrar la Dexametasona EV + Ceftriaxona + Vancomicina + Ampicilina (por ser > 50 años), y proceder de inmediato a la realización del TAC.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 4 Banco de Preguntas Oficial · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

Se recibe el informe del citoquímico de LCR de un joven de 21 años previamente sano con fiebre y rigidez de nuca...

CLAVE C **Meningitis viral (aséptica)**

El perfil de LCR muestra pleocitosis moderada a expensas de mononucleares/linfocitos, con proteínas levemente aumentadas y GLUCOSA NORMAL (ratio LCR/suero > 0.6). Este patrón es característico de meningitis viral (etiología enterovirus la más frecuente en adultos jóvenes).

> **Perla.** La bacteriana (A, B) y la tuberculosa/fúngica (D, E) cursan con hipoglucorraquia marcada (consumo patológico de glucosa).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 5 Banco de Preguntas Oficial · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

Una mujer de 35 años consulta por fiebre de 38.5 °C, cefalea y desorientación de 48 horas. Durante la anamnesis...

CLAVE A **Iniciar Aciclovir endovenoso de inmediato**

La presencia de fiebre asociada a síntomas del lóbulo temporal (alucinaciones olfatorias, afasia de comprensión, desorientación) configura una alta sospecha de encefalitis herpética. La TAC cerebral puede ser completamente normal en las primeras 48 a 72 horas.

> **Perla.** La conducta inmediata y que no admite demora es el inicio de Aciclovir EV (10 mg/kg c/8h), el cual reduce la mortalidad de más de un 70% a menos del 20%.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 6 Banco de Preguntas Oficial · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

¿Cuál de los siguientes esquemas antibióticos empíricos es el de elección para el tratamiento de un absceso cerebral...

CLAVE A **Ceftriaxona + Metronidazol EV**

Los abscesos cerebrales contiguos secundarios a sinusitis u otitis media crónica son provocados típicamente por flora mixta polimicrobiana: estreptococos aerobios y anaerobios de la cavidad oral/orofaríngea (Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus).

> **Perla.** El esquema de elección es Ceftriaxona (cruza BHE con excelente cobertura para estreptococos) combinada con Metronidazol (excelente penetración en LCR y tejido necrótico contra anaerobios).

TEMA 1.4 · PREGUNTA 7 Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

Un paciente diabético de 52 años es evaluado en el box de reanimación por una lesión eritematosa en el muslo derecho...

CLAVE B **Trasladar de inmediato a pabellón para exploración y desbridamiento quirúrgico extenso**

La presencia de flictenas hemorrágicas, crepitación y shock séptico en una infección de partes blandas es diagnóstica de fascitis necrotizante. La mortalidad se incrementa drásticamente por cada hora de demora quirúrgica. Ningún examen de imagen (A) ni procedimiento diagnóstico menor (D) debe retrasar el ingreso a pabellón.

> **Perla.** El tratamiento es quirúrgico inmediato (desbridamiento amplio de toda la fascia desvitalizada) asociado a reanimación y antibióticos EV de amplio espectro.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 8 Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

Un paciente de 38 años consulta por aumento de volumen doloroso cervical anterior y submandibular de 48 horas de...

CLAVE A **Asegurar la vía aérea de forma inmediata mediante intubación guiada o traqueostomía**

El cuadro corresponde a una Angina de Ludwig con signos inminentes de compromiso obstructivo de la vía aérea (estridor inspiratorio, protrusión lingual, cuello en embudo). La causa número uno de muerte en esta patología es la asfixia por colapso de la hipofaringe.

> **Perla.** La prioridad médica absoluta antes de cualquier estudio radiológico o intervención quirúrgica del foco es el aseguramiento de la vía aérea mediante intubación con fibra óptica o traqueostomía de urgencia.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 9 Banco de Preguntas Oficial · Manejo de Contactos

Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. Tras el lavado...

CLAVE B **Ofrecer de inmediato triterapia antirretroviral profiláctica (PEP) por 28 días a 6 semanas**

Ante un accidente laboral de riesgo biológico con fuente desconocida o seropositiva, la profilaxis post-exposición (PEP) con triterapia debe ofrecerse e iniciarse de forma inmediata (idealmente < 2-4 horas, máximo 72 horas) por 28 días.

Trampa. No se debe postergar el inicio esperando el resultado serológico de la fuente (A), ya que la eficacia decae drásticamente tras las primeras horas.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 10 Banco de Preguntas Oficial · Manejo de Contactos

Niño de 8 años, contacto intradomiciliario de padre con tuberculosis bacilífera. Baciloscopía negativa, radiografía...

CLAVE C **Isoniazida por 3 meses y controlar con nuevo PPD al término**

En menores de 15 años expuestos a un contacto bacilífero con PPD inicial negativo (< 10 mm en no infectados), la norma chilena indica quimioprofilaxis con Isoniazida de entrada durante 3 meses ("período de ventana inmunológica") y repetir el PPD: si al tercer mes continúa negativo se suspende; si positiviza (viraje), se completan 6 meses de tratamiento.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 11 Banco de Preguntas Oficial · Rabia y Tétanos

Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No...

CLAVE B **Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato**

En Chile, el murciélago es el principal reservorio de rabia. Las mordeduras de murciélago pueden ser indoloras e imperceptibles. Según la norma MINSAL, el hallazgo de un murciélago en la misma habitación donde dormía una persona se considera una exposición de alto riesgo ("contacto no apercibido").

Perla. La indicación obligatoria es iniciar de inmediato la vacunación antirrábica completa (esquema de 5 dosis) junto con la administración de Inmunoglobulina antirrábica.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 12 Banco de Preguntas Oficial · Rabia y Tétanos

Una mujer de 45 años consulta tras cortarse la mano con una lata oxidada en su patio. Su esquema de vacunación contra...

CLAVE A **Aseo quirúrgico local de la herida sin necesidad de vacuna ni inmunoglobulina**

En un paciente con antecedente fidedigno de vacunación completa cuya última dosis fue administrada hace menos de 5 años, los títulos séricos de anticuerpos antitoxina son óptimos y protectores, incluso ante heridas sucias o tetanígenas.

Perla. Por ende, solo se requiere aseo prolijo de la herida, sin indicación de toxoide ni de inmunoglobulina.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 13 Banco de Preguntas Oficial · IAAS y Aislamientos

¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea...

CLAVE B **Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva**

La Tuberculosis pulmonar bacilífera activa se transmite mediante aerosoles con núcleos de gotitas microscópicas (< 5 micrones) que permanecen suspendidas en el aire por horas. Requiere aislamiento aéreo estricto con mascarilla de alta filtración (N95) y presión negativa en la habitación para evitar que los aerosoles pasen a los pasillos del hospital.

Perla. El meningococo y coqueluche (A, D) usan aislamiento por gotitas (mascarilla quirúrgica simple); Clostridioides y bacterias BLEE (C, E) usan aislamiento de contacto.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 14 Banco de Preguntas Oficial · IAAS y Aislamientos

Un paciente de 58 años en hemodiálisis por fístula nativa en maduración es portador de un catéter tunelizado yugoslavo...

CLAVE B **Retirar inmediatamente el catéter y administrar terapia antifúngica sistémica**

La candidemia asociada a catéter venoso central es una infección invasiva de máxima gravedad con formación masiva de biofilm fúngico intra y extraluminal.

Trampa. La guía internacional y las normas de IAAS establecen que el catéter DEBE RETIRARSE INMEDIATAMENTE en toda infección por Candida spp., asociado a terapia antifúngica sistémica (Equinocandina o Fluconazol) y fondo de ojo para descartar endoftalmitis candidiásica.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 15 Banco de Preguntas Oficial · Intoxicación Alimentaria y Cólera

Un grupo de colegas de trabajo presenta náuseas y vómitos severos unas 3 horas después de compartir arroz frito...

CLAVE B **Bacillus cereus (forma emética)**

Bacillus cereus presenta dos formas clínicas bien diferenciadas: la forma emética (provocada por la toxina termoestable cereulida, con incubación muy corta de 1 a 5 horas y vómitos intensos, clásicamente asociada al arroz frito o recalentado) y la forma diarreica (incubación de 8 a 16 horas, mediada por enterotoxinas lábiles).

Perla. Salmonella y Campylobacter (A, E) tienen períodos de incubación mayores a 16-24 horas y cursan con fiebre.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 16 Banco de Preguntas Oficial · Intoxicación Alimentaria y Cólera

Una mujer de 52 años es llevada a urgencias por presentar visión doble (diplopía), caída de los párpados y dificultad...

CLAVE B **Hospitalizar en UCI, monitorizar mecánica ventilatoria y administrar antitoxina botulínica**

El antecedente de ingesta de conservas caseras sumado a la clínica de compromiso de pares craneanos (diplopía, ptosis, midriasis) y parálisis flácida descendente sin alteración sensitiva es patognomónico de Botulismo alimentario. El Guillain-Barré (A) es una parálisis típicamente ASCENDENTE (de piernas hacia arriba) y la miastenia (D) no causa midriasis ni disautonomía.

Perla. La conducta urgente es ingreso a UCI por riesgo de fallo ventilatorio y administración de Antitoxina Botulínica equina inmediata.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 17 Banco de Preguntas Oficial · Infección por VIH

Un joven de 24 años se realiza un test rápido visual para VIH en una campaña universitaria, el cual resulta reactivo...

CLAVE B **Tomar una segunda muestra de sangre venosa y derivarla al Instituto de Salud Pública (ISP) para confirmación**

En Chile, según la Ley 19.779 (Ley del SIDA), ningún examen de tamizaje local (sea test rápido o ELISA de 4ª generación) confiere diagnóstico definitivo. Ante cualquier resultado reactivo, se debe tomar una segunda muestra de sangre y enviarla al ISP para su confirmación oficial mediante Western Blot / Inmunocromatografía.

> **Perla.** Solo con el informe confirmatorio del ISP se entrega el diagnóstico al paciente y se activa la canasta GES.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 18 Banco de Preguntas Oficial · Infección por VIH

¿Cuál es el esquema antirretroviral de primera línea preferente para el inicio de tratamiento en pacientes adultos con...

CLAVE B **Tenofovir disoproxilo + Lamivudina + Dolutegravir**

El esquema preferente de primera línea en las guías clínicas GES del MINSAL es la combinación en tableta única diaria de dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos (Tenofovir disoproxil fumarato + Lamivudina) asociados a un inhibidor de integrasa de segunda generación (Dolutegravir: TDF/3TC/DTG).

> **Perla.** Este esquema reemplazó a los regímenes antiguos basados en Efavirenz (asociados a efectos neuropsiquiátricos) y Zidovudina (asociada a mielotoxicidad y anemia severa).

TEMA 3.2 · PREGUNTA 19 Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Oportunistas

Un paciente de 38 años con VIH y recuento de CD4 de 85 células/mm³ es diagnosticado de neumonía por Pneumocystis...

CLAVE B **Administrar corticoides sistémicos (Prednisona) antes o junto con el antibiótico**

En la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la presencia de una PaO2 < 70 mmHg o un gradiente alvéolo-arterial ≥ 35 mmHg define una forma moderada-severa con alto riesgo de falla ventilatoria.

> **Perla.** El uso de corticoides sistémicos (Prednisona 40 mg c/12h con pauta descendente por 21 días) reduce a la mitad la necesidad de intubación y la mortalidad intrahospitalaria, al mitigar la respuesta inflamatoria paradójica gatillada por la muerte del hongo.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 20 Banco de Preguntas Oficial · Infecciones Oportunistas

Hombre de 31 años con VIH y abandono de terapia presenta cefalea holocraneana y hemiparesia faciobraquial derecha de 5...

CLAVE C **Iniciar tratamiento empírico para Toxoplasmosis con Sulfadiazina + Pirimetamina y evaluar respuesta en 10-14 días**

En un paciente con SIDA avanzado (CD4 < 100) que se presenta con múltiples lesiones cerebrales con realce en anillo y predilección por los núcleos de la base, la etiología más frecuente con gran diferencia es la Toxoplasmosis cerebral. La conducta recomendada internacionalmente es iniciar tratamiento empírico antitoxoplasma y repetir la neuroimagen en 10 a 14 días.

> **Perla.** La biopsia cerebral (A) solo se plantea si el paciente empeora clínicamente o no muestra mejoría radiológica tras 2 semanas (sospecha de Linfoma Primario del SNC).

TEMA 3.3 · PREGUNTA 21 Banco de Preguntas Oficial · Tuberculosis

Un paciente de 35 años consulta por dolor torácico pleurítico y disnea. La toracocentesis diagnóstica obtiene un...

CLAVE B **Pleuritis tuberculosa**

Un líquido pleural exudativo con claro predominio mononuclear/linfocítico (> 80%) y una elevación de la enzima Adenosina Deaminasa (ADA) por encima de 40 UI/L tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 95% para Pleuritis Tuberculosa en áreas de prevalencia moderada como Chile.

> **Perla.** El empiema bacteriano (A) cursa con predominio PMN franco y pH < 7.20; la insuficiencia cardíaca (C) produce un trasudado con ADA normal (< 20 UI/L).

TEMA 3.3 · PREGUNTA 22 Banco de Preguntas Oficial · Tuberculosis

Un paciente de 28 años que inició tratamiento antituberculoso hace 3 semanas consulta alarmado porque su orina y saliva...

CLAVE B **Tranquilizar al paciente, explicar que es un efecto farmacológico benigno de la rifampicina y continuar el esquema**

La Rifampicina y sus metabolitos tienen una coloración rojo-anaranjada intrínseca que tiñe los fluidos corporales (orina, sudor, lágrimas y saliva). Este fenómeno es completamente inocuo, carece de significado patológico y no indica daño hepático ni renal.

> **Perla.** La conducta es educar y tranquilizar al paciente para asegurar la adherencia al tratamiento, advirtiendo a usuarios de lentes de contacto que estos pueden mancharse de forma permanente.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 23 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

Un hombre de 24 años consulta por un exantema eritematoso difuso en tronco que compromete francamente las palmas de las...

CLAVE A **Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única**

El paciente cursa con un secundarismo sifilítico (sífilis secundaria con exantema palmoplantar característico y títulos altos de VDRL). La sífilis secundaria forma parte de la Sífilis Precoz (menos de 1 año de evolución desde el contacto infectante). El tratamiento de elección normado por el MINSAL es Penicilina G Benzatina en DOSIS ÚNICA de 2.400.000 UI IM.

> **Perla.** El esquema de 3 semanas consecutivas (B) se reserva para sífilis latente tardía (> 1 año) o de duración indeterminada.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 24 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

Una mujer de 26 años con embarazo de 14 semanas presenta un VDRL de tamizaje reactivo 1:16, confirmado mediante FTA-ABS...

CLAVE B **Hospitalizar para desensibilización oral a la penicilina y luego administrar Penicilina Benzatina**

La Penicilina es el ÚNICO antibiótico con eficacia demostrada para atravesar la placenta y tratar tanto a la madre como al feto, previniendo la sífilis congénita, el aborto y la muerte fetal in útero. La doxiciclina (A) está formalmente contraindicada en el embarazo por daño dental y óseo fetal. Los macrólidos (C) no cruzan adecuadamente la placenta.

> **Perla.** Por tanto, ante una embarazada alérgica a la penicilina, la norma nacional e internacional exige desensibilización protocolizada a penicilina y tratamiento posterior con Penicilina Benzatina.

TEMA 3.5 · PREGUNTA 25 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

Un hombre de 25 años consulta por disuria y secreción uretral purulenta abundante. La tinción de Gram de la secreción...

CLAVE B **Ceftriaxona 500 mg IM dosis única + Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral por 7 días**

Aunque el frotis confirme gonorrea, el tratamiento sindrómico normado por el MINSAL y la CDC exige cobertura combinada para Neisseria gonorrhoeae (Ceftriaxona 500 mg IM dosis única) y Chlamydia trachomatis (Doxiciclina 100 mg c/12h por 7 días), debido a la frecuencia extrema de coinfección oculta.

Perla. El ciprofloxacino (C) no se utiliza por alta resistencia de gonococo en Chile (> 50%).

TEMA 3.5 · PREGUNTA 26 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades de Transmisión Sexual

Una mujer de 22 años consulta por intenso dolor vulvar y ardor al orinar de 3 días de evolución. Al examen ginecológico...

CLAVE C **Herpes genital primario / Aciclovir oral**

La presencia de lesiones vesiculares agrupadas en racimo que evolucionan a úlceras superficiales dolorosas asociadas a adenopatías sensibles es el cuadro prototípico del primer episodio de Herpes Genital (generalmente por VHS-2). El tratamiento de elección para acortar el cuadro y reducir la eliminación viral es Aciclovir oral (400 mg cada 8 horas o 200 mg 5 veces al día por 7 a 10 días).

Perla. El chancro sifilítico (B) es una úlcera única e indolora.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 27 Banco de Preguntas Oficial · Hantavirus

Un trabajador forestal de 32 años consulta en un hospital de baja complejidad por cuadro de 3 días de fiebre alta...

CLAVE A **Carga masiva de cristaloides con 30 mL/kg en bolo**

El cuadro corresponde a un Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus. En esta patología, la permeabilidad capilar alveolar está severamente aumentada por fuga endotelial; la administración de bolos masivos de volumen (como los 30 mL/kg típicos de la sepsis bacteriana) precipita un edema pulmonar masivo irreversible y asfixia al paciente.

Trampa. La guía clínica del MINSAL contraindica la resucitación agresiva con fluidos y exige manejo hemodinámico restrictivo.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 28 Banco de Preguntas Oficial · Hantavirus

¿Cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente del virus Hanta en Chile según la epidemiología nacional?

CLAVE B **Inhalación de aerosoles contaminados con excretas de ratón colilargo**

El virus Andes se transmite casi exclusivamente por vía aérea mediante la inhalación de polvo y aerosoles suspendidos en el aire provenientes de la saliva, orina o heces desecadas del roedor silvestre Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga), frecuentemente al realizar limpieza de cabañas, galpones o bodegas que han permanecido cerradas durante largo tiempo.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 29 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedad de Chagas

¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar o descartar la transmisión congénita de la Enfermedad de...

CLAVE B **Examen parasitológico directo mediante microhematocrito en sangre fresca**

En el recién nacido, los anticuerpos IgG atraviesan la placenta libremente, por lo que una serología IgG positiva solo refleja la infección materna y no confirma enfermedad en el niño.

Perla. Por este motivo, la norma ministerial indica que el diagnóstico neonatal se realiza mediante métodos parasitológicos directos que buscan visualizar el parásito vivo en sangre (microhematocrito de sangre de cordón o capilar) o mediante PCR en centros de referencia.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 30 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedad de Chagas

Un hombre de 60 años originario de la Región de Coquimbo consulta por constipación crónica pertinaz de años de...

CLAVE B **Enfermedad de Chagas en fase crónica determinada**

La coexistencia de megacolon (fase digestiva) y alteraciones de conducción cardíaca típicas como el bloqueo completo de rama derecha (fase cardíaca) en un paciente procedente de una zona endémica histórica de Chile (IV Región) es la presentación característica de la Enfermedad de Chagas en fase crónica determinada.

Perla. Se debe confirmar con serología IgG (ELISA e IFI).

TEMA 4.3 · PREGUNTA 31 Banco de Preguntas Oficial · Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

Un hombre de 30 años consulta en urgencias por fiebre de 39 °C, cefalea y artralgias intensas tras regresar hace 4 días...

CLAVE B **Ketoprofeno**

En los pacientes con sospecha de dengue, los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs como Ketoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco) y el ácido acetilsalicílico (Aspirina) están terminantemente contraindicados debido a su acción antiagregante plaquetaria y al riesgo de gatillar hemorragias digestivas graves y potenciar el colapso hemodinámico en caso de evolución a dengue grave.

Perla. El analgésico y antipirético de elección es el Paracetamol.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 32 Banco de Preguntas Oficial · Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

Una mujer de 29 años presenta accesos febriles con calofríos intensos y sudoración profusa cada 48 horas tras regresar...

CLAVE A **Administrar Primaquina oral durante 14 días**

Plasmodium vivax y Plasmodium ovale tienen la capacidad biológica de generar formas intrahepáticas durmientes denominadas hipnozoítos, las cuales no son eliminadas por la cloroquina (que solo actúa sobre las formas intraeritrocitarias sanguíneas).

Trampa. Para lograr la cura radical y evitar recaídas que pueden presentarse meses después, es mandatario administrar Primaquina por 14 días, previa verificación de niveles normales de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).

TEMA 4.4 · PREGUNTA 33 Banco de Preguntas Oficial · Zoonosis Chilenas

Un paciente de 35 años consulta por fiebre de 38.8 °C, dolor muscular difuso y marcado edema bipalpebral bilateral tras...

CLAVE A **Triquinosis**

El antecedente del consumo de carne o embutidos de cerdo no fiscalizados sumado a la tríada de fiebre, edema bipalpebral y mialgias con hipereosinofilia marcada (> 30%) es patognomónico de Triquinosis (infección por Trichinella spiralis).

> **Perla.** La hidatidosis (B) no cursa con este cuadro muscular agudo ni con edema bipalpebral; el Chagas agudo (E) produce el signo de Romaña que es típicamente UNILATERAL.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 34 Banco de Preguntas Oficial · Zoonosis Chilenas

Durante la realización de una ecografía abdominal de rutina a un campesino de 50 años asintomático, se identifica en el...

CLAVE A **Rotura espontánea o traumática con shock anafiláctico grave**

El hallazgo ecográfico del signo del camalote es característico de un quiste hidatídico hepático por Echinococcus granulosus.

> **Perla.** La complicación aguda más temida y de riesgo vital inminente es la rotura del quiste (sea espontánea por aumento de presión intracística o traumática tras un golpe menor), lo cual libera líquido hidatídico rico en antígenos altamente alergénicos hacia el peritoneo, desencadenando un shock anafiláctico fulminante y siembra peritoneal difusa de protoescólices.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 35 Banco de Preguntas Oficial · Brucelosis y Leptospirosis

Un trabajador agrícola de 38 años consulta por fiebre de 39 °C, cefalea intensa y marcado dolor en las pantorrillas de...

CLAVE A **Leptospirosis ictérica (Síndrome de Weil)**

El antecedente de contacto con aguas estancadas y alcantarillados sumado al cuadro de fiebre, mialgias exquisitas en las pantorrillas y el signo patognomónico de sufusión conjuntival bilateral sin pus, que progresa a falla multiorgánica con ictericia severa y falla renal aguda (Síndrome de Weil), es diagnóstico de Leptospirosis grave por Leptospira interrogans.

> **Perla.** La hepatitis A (B) y la colangitis (C) no cursan con sufusión conjuntival ni dolor marcado en pantorrillas.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 36 Banco de Preguntas Oficial · Brucelosis y Leptospirosis

¿Cuál es el esquema antibiótico de primera línea recomendado para el tratamiento de la Brucelosis en un paciente adulto...

CLAVE B **Doxiciclina oral asociada a Rifampicina oral durante 6 semanas**

Debido a que Brucella es un microorganismo intracelular facultativo con alta propensión a la latencia en el sistema reticuloendotelial y hueso, la monoterapia antibiótica tiene una tasa inaceptable de recaídas (> 50%).

> **Perla.** La OMS y las normas clínicas exigen biterapia sinérgica prolongada durante un mínimo de 6 semanas, siendo el régimen estándar de elección Doxiciclina (100 mg cada 12 h) asociada a Rifampicina (600 a 900 mg al día).

TEMA 4.6 · PREGUNTA 37 Banco de Preguntas Oficial · Ántrax

Un trabajador de una fábrica procesadora de cueros importados consulta por una lesión en el dorso de la mano izquierda...

CLAVE A **Ciprofloxacino oral**

La presentación clínica de una escara necrótica negruzca indolora con vesículas satélites y edema masivo en un trabajador expuesto a cueros o lanas animales es característica de carbunco cutáneo (Ántrax).

> **Perla.** El tratamiento antibiótico de elección recomendado internacionalmente por su alta efectividad y cobertura frente a cepas naturales y de bioseguridad es Ciprofloxacino oral (500 mg cada 12 h) o alternativamente Doxiciclina.

TEMA 4.6 · PREGUNTA 38 Banco de Preguntas Oficial · Ántrax

¿Cuál de las siguientes conductas está formalmente CONTRAINDICADA en el manejo de una lesión cutánea sospechosa de...

CLAVE B **Desbridamiento y resección quirúrgica amplia de la escara necrótica**

En el carbunco cutáneo, el desbridamiento, curetaje o escisión quirúrgica de la escara necrótica está terminantemente contraindicado.

> **Perla.** La manipulación mecánica invasiva de la lesión rompe la barrera tisular local y favorece el paso masivo de las bacterias y sus toxinas hacia el torrente circulatorio, desencadenando bacteriemia, shock tóxico sistémico y muerte.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 39 Banco de Preguntas Oficial · Infección de Piel y Partes Blandas

Una mujer de 64 años consulta por fiebre de 38.6 °C y dolor en la pierna izquierda. Al examen se observa una placa...

CLAVE B **Streptococcus pyogenes**

La presencia de una placa eritematosa con bordes nítidos, claramente delimitados y sobreelevados es la descripción clásica de la erisipela, la cual es producida en más del 90% de los casos por Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A).

> **Perla.** La celulitis por S. aureus o Gram negativos produce bordes planos y difusos.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 40 Banco de Preguntas Oficial · Infección de Piel y Partes Blandas

¿Cuál de los siguientes esquemas antimicrobianos por vía oral es el de primera línea para el tratamiento ambulatorio de...

CLAVE B **Cefadroxilo 500 mg cada 12 horas**

En la celulitis comunitaria no complicada, los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus meticilino-sensible y Streptococcus pyogenes.

> **Perla.** El tratamiento oral de primera línea de elección en Chile son las cefalosporinas de primera generación (Cefadroxilo 500 mg c/12h o Cefalexina 500 mg c/6h) o las penicilinas isoxazólicas (Flucloxacilina 500 mg c/8h), por su excelente perfil de eficacia y tolerancia.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 41 Banco de Preguntas Oficial · Síndrome Mononucleósico

Un universitario de 20 años presenta fiebre de 39 °C, disfagia intensa y astenia de una semana. Se le diagnosticó...

CLAVE B **Mononucleosis infecciosa por Virus Epstein-Barr**

La tríada de faringitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia asociada a la aparición de un exantema eritematoso difuso tras la ingesta de amoxicilina es patognomónica de Mononucleosis Infecciosa por Virus Epstein-Barr (VEB).

> **Perla.** La amoxicilina induce este rash en más del 90% de los pacientes infectados por VEB por alteración de la respuesta celular inmune.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 42 Banco de Preguntas Oficial · Complejo TORCH

Un recién nacido de 5 días de vida presenta microcefalia, ictericia y hepatoesplenomegalia. La ecografía...

CLAVE B **Citomegalovirus (CMV)**

El Citomegalovirus (CMV) es la infección congénita más frecuente del complejo TORCH. Su hallazgo radiológico patognomónico son las calcificaciones en la zona subependimaria periventricular, y es la principal causa no genética de hipoacusia neurosensorial infantil.

> **Perla.** Toxoplasma (A) causa calcificaciones intraparenquimatosas difusas y coriorretinitis.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 43 Banco de Preguntas Oficial · Exantemas de la Infancia

Un niño de 5 años presenta dolor faríngeo y fiebre de 38.5 °C. Al examen destaca un exantema micropapular eritematoso...

CLAVE B **Amoxicilina oral 50 mg/kg/día por 10 días completos**

El cuadro corresponde a Escarlatina, producida por cepas de Streptococcus pyogenes productoras de toxina eritrogénica. Para asegurar la erradicación bacteriana faríngea y prevenir complicaciones no supurativas tardías (especialmente la Fiebre Reumática aguda), la norma nacional e internacional exige administrar Amoxicilina oral durante 10 días completos (o alternativamente Penicilina Benzatina IM en dosis única).

> **Perla.** Pautas más cortas fracasan en prevenir la fiebre reumática.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 44 Banco de Preguntas Oficial · Exantemas de la Infancia

¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento precoz con Inmunoglobulina Endovenosa a altas dosis en un lactante...

CLAVE B **Evitar el desarrollo de aneurismas y ectasias en las arterias coronarias**

La complicación más temida de la Enfermedad de Kawasaki es la vasculitis coronaria, que sin tratamiento conduce a la formación de aneurismas coronarios en hasta el 25% de los pacientes, con riesgo subsecuente de infarto agudo de miocardio infantil y muerte súbita.

> **Perla.** La administración de IGEV (2 g/kg) en los primeros 10 días de evolución reduce esta incidencia a menos del 3-5%, siendo el pilar terapéutico cardioprotector indiscutido.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 45 Banco de Preguntas Oficial · Varicela y Herpes Zóster

Un hombre de 36 años fumador consulta por disnea aguda progresiva y tos con estrías de sangre de 24 horas de evolución...

CLAVE A **Aciclovir endovenoso a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas**

La neumonitis varicelosa es una complicación potencialmente mortal típica del adulto joven. El tratamiento de elección indiscutido es Aciclovir por vía ENDOVENOSA a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas durante 7 a 10 días. La vía oral (B) es insuficiente debido a su baja biodisponibilidad (15-20%) y no logra concentraciones pulmonares terapéuticas suficientes para frenar la replicación viral en el pulmón.

> **Perla.** La inmunoglobulina (D) solo sirve para profilaxis post-exposición precoz, no para tratar la enfermedad establecida.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 46 Banco de Preguntas Oficial · Varicela y Herpes Zóster

Una mujer de 68 años consulta por intenso dolor urente en la hemicara izquierda de 3 días de evolución, asociándose...

CLAVE A **Iniciar Aciclovir oral a dosis plenas y solicitar evaluación urgente por Oftalmología**

El cuadro corresponde a un Herpes Zóster Oftálmico que afecta la rama nasociliar del nervio oftálmico (V1 del trigémino), evidenciado por el signo de Hutchinson (vesículas en la punta de la nariz). Esta manifestación predice afectación corneal severa (queratitis dendrítica, uveítis anterior, glaucoma secundario y riesgo de pérdida visual irreversible).

> **Perla.** La conducta inmediata consiste en iniciar Aciclovir oral (800 mg 5 veces al día) o Valaciclovir y derivar de forma urgente al especialista en Oftalmología para examen con lámpara de hendidura.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 47 Banco de Preguntas Oficial · Neutropenia Febril

Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en...

CLAVE A **Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos**

El paciente cursa con una neutropenia febril de alto riesgo (RAN < 500 en contexto de leucemia mieloide aguda). La recomendación Surviving Sepsis y las guías internacionales de neutropenia febril exigen el inicio inmediato de antibioterapia antipseudomónica endovenosa de amplio espectro (tiempo puerta-aguja < 60 minutos), siendo Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam) el fármaco de elección.

> **Perla.** Ceftriaxona (B) no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, el germen más letal en este escenario.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 48 Banco de Preguntas Oficial · Neutropenia Febril

Un paciente neutropénico febril post-quimioterapia cumple 5 días hospitalizado recibiendo Cefepime y Vancomicina EV a...

CLAVE B **Solicitar TAC de tórax de alta resolución e iniciar terapia antifúngica empírica con Voriconazol o Equinocandina**

En un paciente con neutropenia febril prolongada que persiste con fiebre al 4°-7° día a pesar de cobertura antibiótica bacteriana de amplio espectro óptima, la principal sospecha es una Infección Fúngica Invasora (especialmente Aspergilosis pulmonar invasora o Candidiasis diseminada).

> **Perla.** La conducta protocolizada es solicitar TAC de tórax de alta resolución (en busca de nódulos con signo del halo característicos de Aspergillus) e iniciar de inmediato cobertura antifúngica empírica con Voriconazol o una Equinocandina (Caspofungina).

TEMA 5.6 · PREGUNTA 49 EUNACOM Julio 2015 · Influenza

Un hombre de 22 años, sano, consulta en invierno por rinorrea, congestión nasal, fiebre de 38,5 °C, mialgias y tos seca...

CLAVE E **Tratamiento sintomático, con oseltamivir como opción en vez de indicación obligatoria**

En un adulto joven sano con influenza leve el tratamiento es sintomático (paracetamol, hidratación, reposo) y el oseltamivir es solo una opción, porque su beneficio es modesto. El oseltamivir está indicado en grupos de riesgo (≥ 65 años, embarazo, enfermedades crónicas, inmunosupresión) y en formas graves.

> **Perla.** Los antibióticos solo se usan si hay sobreinfección bacteriana, los corticoides no tienen lugar y el diagnóstico en temporada epidémica es clínico, sin necesidad de PCR en todos los casos.

TEMA 5.6 · PREGUNTA 50 EUNACOM Agosto 2021 · COVID-19 pediátrico

Un adolescente de 14 años consulta por fiebre de 39 °C de 3 días, dolor abdominal, vómitos y diarrea, con exantema y...

CLAVE B **Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2**

Fiebre persistente con compromiso digestivo, mucocutáneo (exantema, conjuntivitis) y cardiovascular (hipotensión), con marcadores inflamatorios y troponina elevados 2 a 6 semanas después de un contacto o infección por SARS-CoV-2, configura el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C). Es una urgencia: se deriva a UCI pediátrica para inmunoglobulina endovenosa, corticoides y soporte hemodinámico.

> **Perla.** La apendicitis y la gastroenteritis no explican el compromiso multisistémico ni los marcadores, y el cuadro no es una neumonía.

TEMA 5.6 · PREGUNTA 51 Banco de Preguntas Oficial · COVID-19 del adulto

Un hombre de 58 años, obeso y diabético, no vacunado, consulta al segundo día de síntomas por fiebre, tos y mialgias...

CLAVE D **Manejo sintomático e indicar nirmatrelvir/ritonavir por 5 días, verificando las interacciones farmacológicas**

Es una COVID-19 leve en un paciente con factores de riesgo de progresión (obesidad, diabetes, falta de vacunación). Se indica tratamiento antiviral precoz, dentro de los primeros 5 días de síntomas: nirmatrelvir/ritonavir 300/100 mg cada 12 horas por 5 días, revisando las interacciones del ritonavir con sus otros fármacos y la función renal, junto con manejo sintomático y signos de alarma.

> **Perla.** La dexametasona está reservada a quienes requieren oxígeno y puede ser perjudicial en la enfermedad leve; los antibióticos no tienen indicación sin sobreinfección bacteriana.